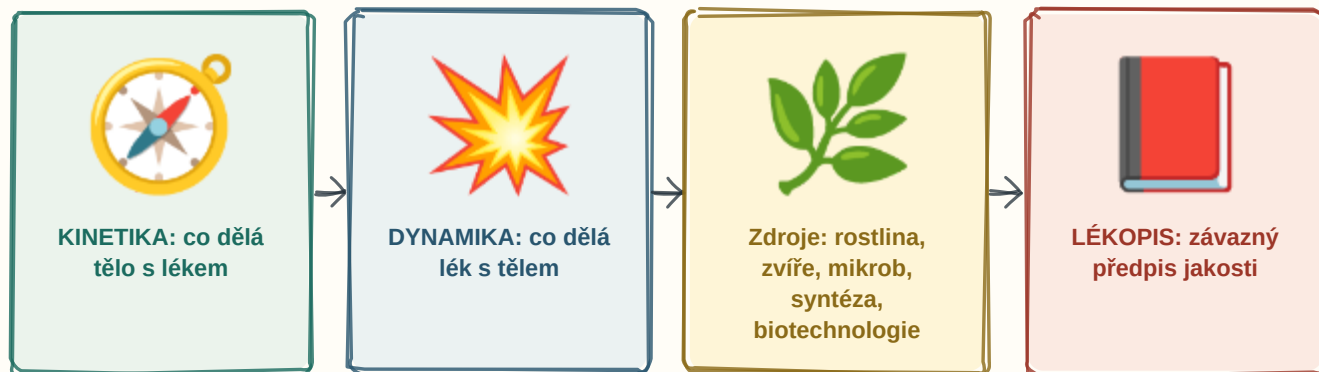


O1 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Kinetika = KAM lék jde. Dynamika = CO tam dělá. Jedna cesta tam, druhá zpátky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kompas

Farmakokinetika — absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece (ADME).

Výbuch

Farmakodynamika — mechanismus účinku, vztah dávky a odpovědi.

Bylina a bakterie

Zdroje: rostliny (morfin, atropin, digoxin), živočichové (heparin, inzulin), mikroorganismy (peniciliny), chemická syntéza, biotechnologie (monoklonální protilátky).

Tři jména

Chemický (vzorec) · generický = mezinárodní nechráněný (ibuprofen) · firemní chráněný (Brufen®).

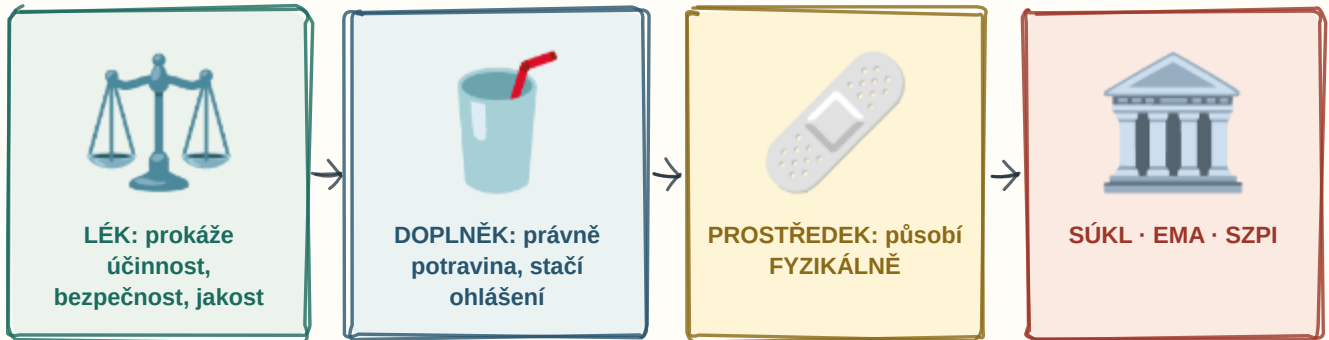
Červená kniha

Lékopis — závazný soubor požadavků na jakost léčiv; Český vychází z Evropského.

! Léčivá látka je nositel účinku; léčivý přípravek je hotová forma, kterou pacient dostane. Magistraliter se připravuje v lékárně, HVLP se vyrábí hromadně.

02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Lék musí DOKÁZAT, že funguje. Doplňěk stravy jen nesmí LHÁT, že léčí. O kategorii rozhoduje mechanismus, ne složení.



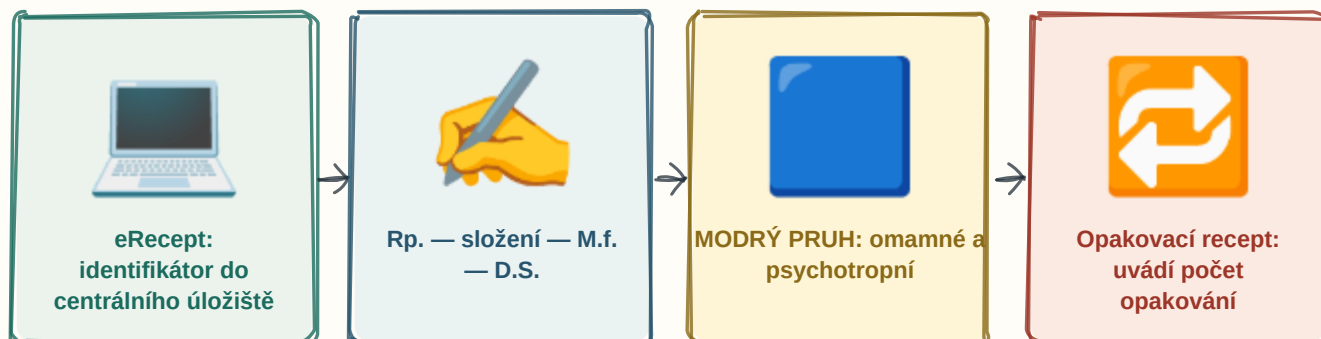
ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy	Léčivý přípravek působí farmakologicky, imunologicky nebo metabolicky; registruje SÚKL národně nebo EMA centralizovaně.
Kelímek	Doplňěk stravy je potravinu — účinnost dokládat nemusí, nesmí tvrdit, že léčí; dozor má SZPI.
Náplast	Zdravotnický prostředek působí fyzikálně (výplň, implantát, obvaz) — posuzuje se shoda a riziková třída.
Budova	SÚKL registruje, stanovuje ceny a úhrady, dozoruje lékárny a vede farmakovigilanci; klinické hodnocení schvaluje i etická komise.

⚠ Pacient rozdíl mezi lékem a doplňkem nevidí — na doplňky se proto ptej cíleně: mají reálné interakce (třezalka, ginkgo, česnek).

03 Předepisování léčivých přípravků

Recept je PRÁVNÍ dokument dvou lidí: lékař ručí za to, co předepsal, lékárník za to, co vydal.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dva podpisy

Odpovědnost je sdílená — proto musí být recept čitelný a úplný.

Náležitosti

Pacient (jméno, číslo pojištění) · léčivo (název, síla, forma, množství) · dávkování a způsob podání (D.S. = da signa) · lékař a pracoviště s podpisem a razítkem · datum.

Modrý pruh

Vyhrazen omamným a psychotropním látkám, má přísnější evidenci.

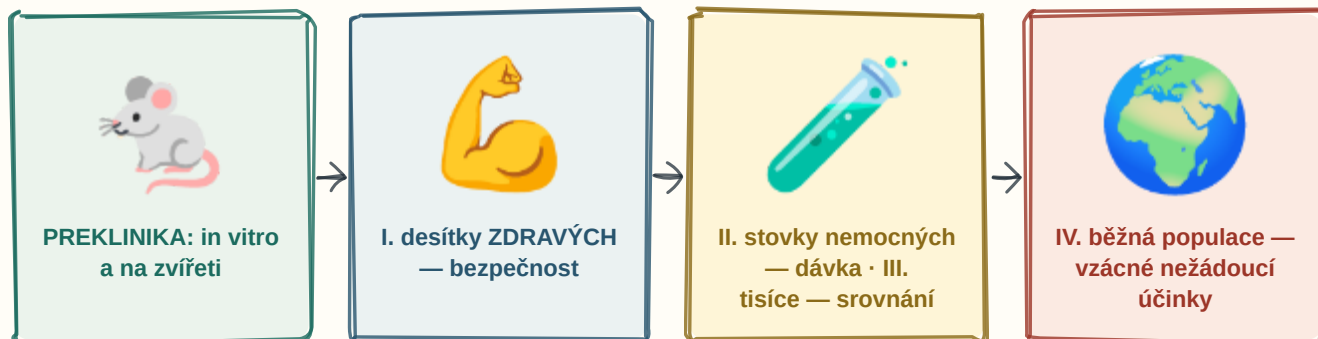
Rp. = recipe

„Vezmi“; M.f. = misce fiat („smíchej, ať vznikne“); D.S. = „vydej a označ“ — stavba magistraliter předpisu.

⚠ Platnost běžného receptu je zpravidla 14 dní, u antibiotik kratší [ověřit dle skript]. Před předepsáním patří anamnéza: alergie, gravidita, funkce jater a ledvin, ostatní léky.

O4 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

I. je to bezpečné? II. jaká dávka? III. je to lepší než dosavadní léčba?
IV. co vzácného se objeví, až to bere milion lidí?



ROZKLÍČOVÁNÍ

Myš

Preklinika: farmakokinetika, farmakodynamika, toxicita (ED50, TD50, LD50), mutagenita, teratogenita, karcinogenita.

Fáze I

Desítky zdravých dobrovolníků — snášenlivost a chování látky v těle; zahajuje se mikrodávkami s pomalou eskalací.

Fáze II a III

II. stovky nemocných — hledá se účinná dávka. III. tisíce — srovnání s dosavadní léčbou nebo placebem; na jejím základě se registruje.

Fáze IV

Po uvedení na trh — sledování v běžné populaci; teprve tady se odhalí vzácné nežádoucí účinky, protože ve studii na tisících pacientů neměly šanci vyjít najevo.

Zásady studie

Randomizace, zaslepení (jednoduché, dvojité, trojitě), kontrolní skupina, předem daný cíl, souhlas etické komise.

⚠ Generikum účinnost neprokazuje znovu — dokládá bioekvivalenci, tedy shodný průběh hladin s originálem.

O5 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní otázka není „jak rychle“, ale „PROJDE TO JÁTRY?“. First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dveře do jater

Perorální podání = vrátnice: látka projde střevní stěnou a játry dřív, než se dostane do oběhu. Proto se stejný lék podává ústy v mnohem vyšší dávce než do žíly.

Jazyk

Sublingválně a bukálně se látka vstřebá rovnou do systémového oběhu — obchází first-pass; proto nitroglycerin pod jazyk.

Stříkačka

I.v. má z definice biologickou dostupnost 100 % a okamžitý účinek — ale podané se nedá vzít zpět. I.m. rychlé, s.c. pomalejší (inzulin, hepariny).

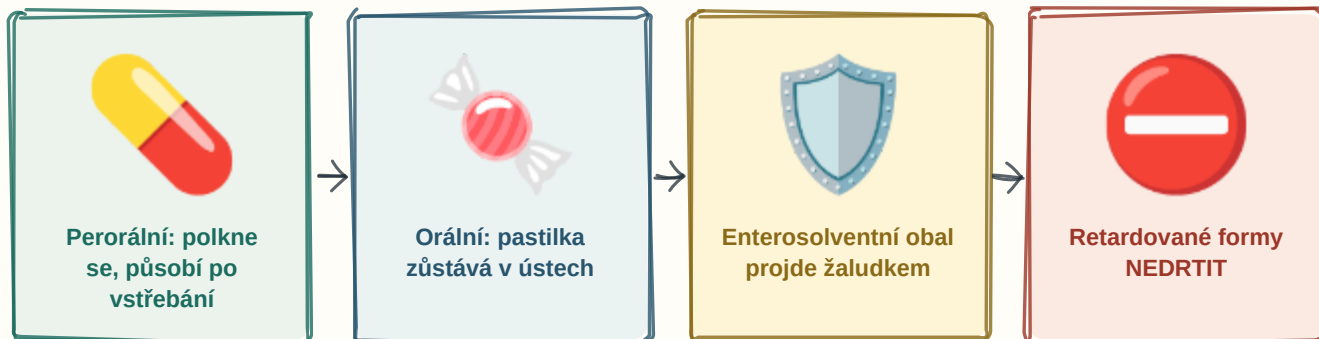
Náplast

Nejpomalejší nástup, ale stálá hladina po dny; po sejmutí účinek doznívá z kožního depa.

⚠ „Místní“ podání neznamená „bez celkového účinku“ — oční, nosní i inhalační formy se vstřebávají. Timolol z očních kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus.

O6 Lékové formy — perorální a orální

PER os = skrz ústa dál do střeva. ORÁLNÍ = zůstává v ústech. A obojí, co má obal nebo je retardované, se NESMÍ DRTIT.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Skrz ústa dál

Perorální formy: tablety, potahované tablety, tobolky, granuláty, sirupy, suspenze, kapky.

Zůstává v ústech

Orální formy: pastilky, žvýkací tablety, ústní vody, gely. Sublingválně a bukalně se látka vstřebává do krve a obejde first-pass.

Štít

Enterosolventní obal se rozpadne až ve střevě — chrání látku před kyselinou, nebo žaludek před látkou.

Zákaz drcení

Retardované formy (SR, ZOK) uvolňují látku postupně; rozdrcením se uvolní celá denní dávka najednou nebo se látka zničí.

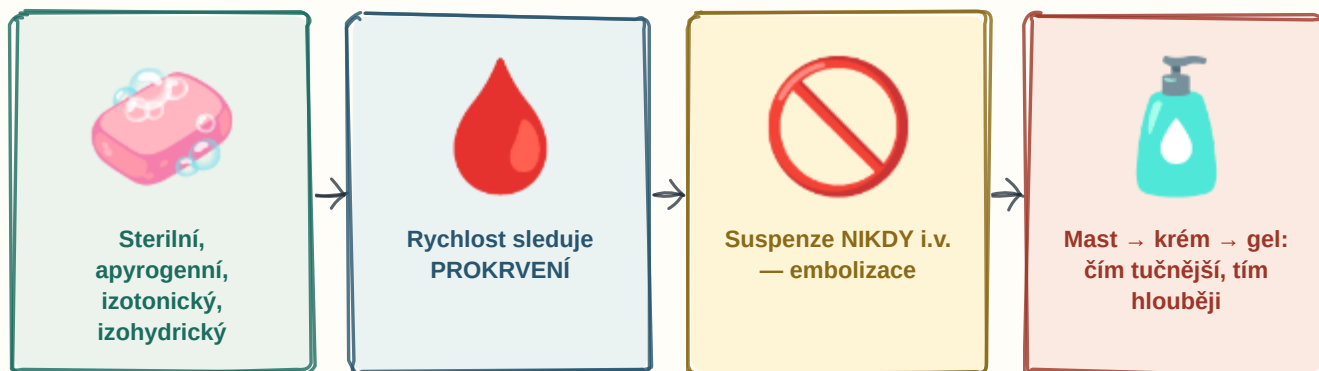
Pomocné látky

Nejsou neutrální: laktóza vadí při intoleranci, barviva mohou vyvolat alergii, cukr v sirupech je při dlouhodobé léčbě rizikový.

⚠ Rozpad a rozpuštění předchází vstřebání — u málo rozpustných léčiv je rychlost rozpouštění krokem, který určuje rychlost nástupu účinku.

07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Parenterální forma obchází všechny přirozené bariéry — proto musí být sterilní. A co je jednou v žíle, nevrátíš.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Mýdlo

Přípravek obchází kůži i sliznici, proto musí být sterilní, apyrogenní (bez pyrogenů), izotonický, izohydrický a bez mechanických nečistot.

Krev

i.v. okamžitě a se 100% dostupností · i.m. rychle · s.c. pomaleji · depotní formy a náplasti nejpomaleji, ale působí dny až měsíce.

Zákaz

Suspenze a emulze se nepodávají i.v. — hrozí embolizace.

Tuba

Mast (tučný základ, největší průnik, na suchou kůži) · krém (voda i tuk) · gel (vodný, chladí) · pasta · zásyp · roztok · náplast. Průnik zvyšuje okluze.

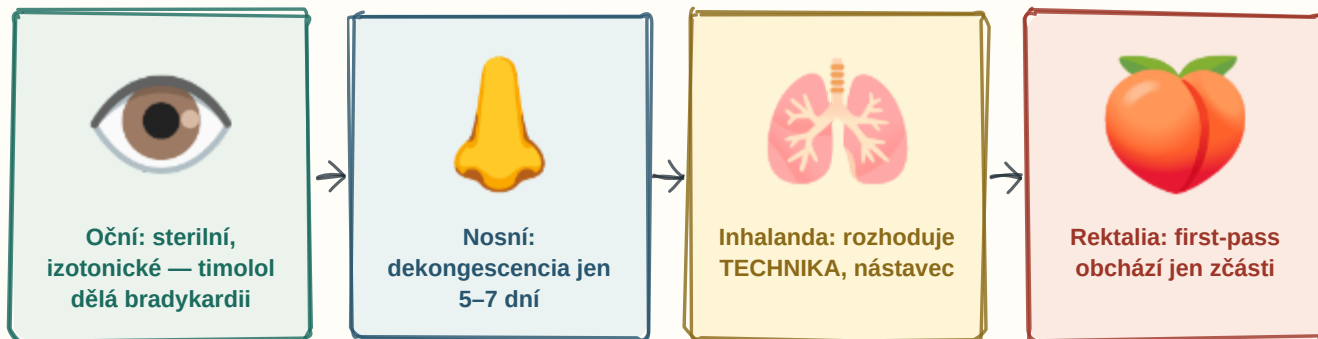
Výhody a nevýhody

Jistá dostupnost, přesné dávkování, použitelné u zvracení a bezvědomí — proti tomu bolestivost, riziko infekce a embolie, nutný personál a nevratnost podání.

⚠ Lokální kortikoidy dlouhodobě způsobí atrofii kůže a strie — na obličej a do záhybů patří jen slabé přípravky a krátce, protože se tam vstřebávají nejvíc.

O8 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

„Místní“ znamená KAM to dáváš, ne KDE to působí. Kapka do oka umí zpomalit srdce.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Oko

Kapky, masti a gely musí být sterilní a izotonické. Timolol z kapek vyvolá bradykardii a bronchospasmus; vstřebání sníží stisknutí vnitřního koutku po nakapání.

Nos

Xylometazolin jen 5–7 dní, jinak vzniká rhinitis medicamentosa. Nosní cestou se podává i desmopresin a sumatriptan k celkovému účinku.

Plíce

Aerosolový dávkovač, práškový inhalátor, nebulizace. Nástavec zlepší depozici a sníží nežádoucí účinky — bez něj inhalační kortikoid vyvolá orofaryngeální kandidózu a chrapot.

Konečník

Rektalia obcházejí játra jen z dolní části konečníku, vstřebávání je kolísavé; hodí se u zvracení, u dětí a v bezvědomí (diazepam u křečí).

Ucho a pochva

Ušní kapky se nesmí podat při perforaci bubínku. Vaginalia slouží hlavně k místní léčbě, ale i odsud se látka částečně vstřebává.

⚠ Vstřebání ze sliznice může být rychlejší než ze střeva — nosní a bukalní sliznice jsou dobře prokrvené a first-pass obcházejí.

09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku, nástup i nežádoucí účinky — a špatně podaná informace udělá z léku nefunkční lék.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ucho

Compliance — míra, do jaké pacient dodržuje pokyny; pasivní pojetí.

Podání ruky

Adherence — pacient se na plánu podílel; konkordance je společné rozhodnutí lékaře a pacienta. Dnes se preferuje adherence, protože zdůrazňuje spoluodpovědnost.

Jiskra

Placebo — očekávané zlepšení; má neurobiologický podklad (endogenní opioidy, dopamin), není „vymyšlené“ a zesiluje účinek každého skutečného léku.

Blesk

Nocebo — očekávaná škoda; nepříznivé věty a příbalový leták vyvolají potíže. Odsud časté vysazení statinů a antidepresiv.

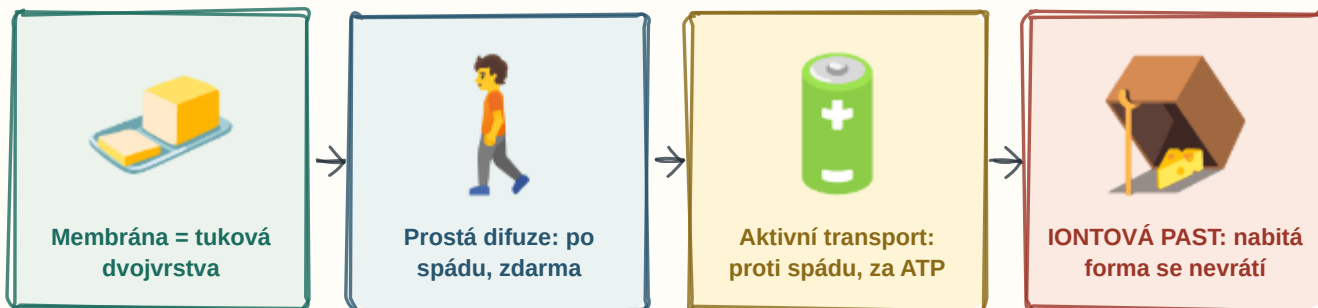
Proč léčba selhává

Nejčastěji ne špatný lék, ale nebraný lék: hypertenze, osteoporóza, složitý režim, mnoho tablet, nežádoucí účinky a obavy z nich, cena, nepochopení a nedůvěra.

⚠ Zlepší to fixní kombinace (méně tablet), dávkování 1× denně, srozumitelné vysvětlení a kontrola. Formulace lékaře je proto sama o sobě účinná látka s vlastní dávkou.

O10 Přechod látek biologickými membránami

Membrána je TUKOVÁ STĚNA. Projde jen látka lipofilní a NENABITÁ. Nabitá forma zůstane stát přede dveřmi.



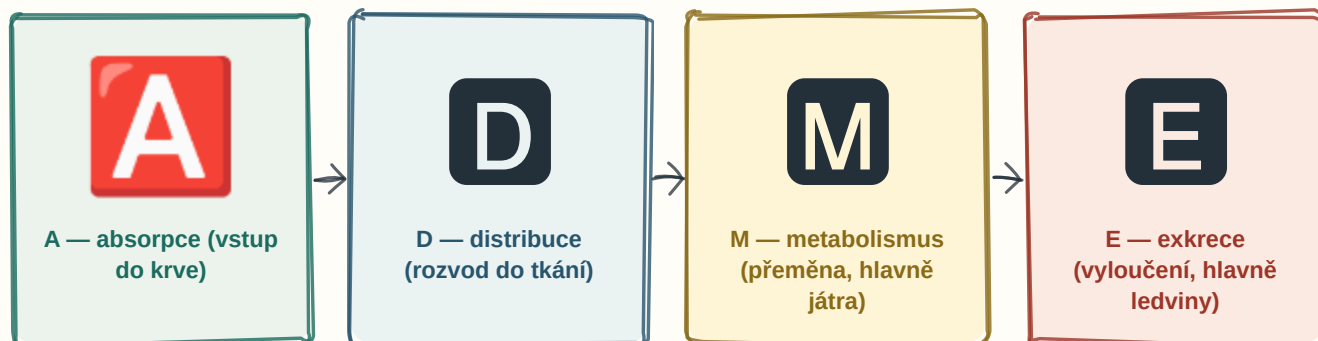
ROZKLÍČOVÁNÍ

Máslo	Přes membránu projde jen látka lipofilní a nenabitá; nabitá (ionizovaná) forma neprojde.
Chodec	Prostá difuze — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče; hlavní mechanismus u většiny léčiv.
Baterie	Aktivní transport — proti spádu, spotřebuje ATP, satureovatelný (např. P-glykoprotein, který léčiva aktivně vypuzuje z buňky). Facilitovaná difuze jde přenašečem, ale po spádu a bez energie.
Past	Látka projde membránou v nenabitě formě, na druhé straně se při jiném pH nabije a zpět už neprojde — tak se hromadí (a proto se alkalizací moči urychlí vyloučení salicylátů).
Bariéry	Hematoencefalická (těsné spoje + P-glykoprotein), placentární (propustnější, než se čeká), krev–varle, krev–sítnice. Zánět bariéru zpropustní — proto penicilin proniká do CNS jen při meningitidě.

! Proto lokální anestetikum nezabírá v kyselém zánětlivém prostředí: převáží nabitá forma, která přes membránu neprojde k sodíkovému kanálu.

O11 Základní farmakokinetické parametry a procesy

ADME. A eliminace není totéž co exkrece — eliminace = metabolismus PLUS vylučování.



ROZKLÍČOVÁNÍ

ADME	Čtyři děje osudu léčiva v těle; probíhají současně, ne po sobě.
Eliminace	Metabolismus + exkrece dohromady — proto se „eliminace“ a „vylučování“ nesmí zaměňovat.
F	Biologická dostupnost — podíl dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu; i.v. = 100 %.
Vd	Distribuční objem — zdánlivý, poměr dávky k plazmatické koncentraci. Vysoké Vd znamená, že látka sedí ve tkáních, ne v krvi (proto ji dialýza neodstraní).
CL a $t_{1/2}$	Clearance — objem krve očištěný za čas. Biologický poločas — doba poklesu koncentrace na polovinu; ustálený stav nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá vymizení.

! Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Farmakodynamika = co lék dělá s tělem. AUC (plocha pod křivkou) je celková expozice, C_{max} vrchol a t_{max} doba do vrcholu.

O12 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

První řád = ubývá stále stejný PODÍL. Nultý řád = ubývá stále stejné MNOŽSTVÍ. Nasycený enzym víc nestihne, i kdyby chtěl.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klesající křivka

Kinetika prvního řádu — odbourává se konstantní podíl (polovina za poločas); platí pro naprostou většinu léčiv, protože enzymy mají kapacitní rezervu.

Přesýpací hodiny

Kinetika nultého řádu — enzym je nasycený, odbourává konstantní množství za čas bez ohledu na koncentraci. Pokles je lineární a poločas ztrácí smysl.

Pivo

Ethanol se odbourává řádově 0,1–0,15 ‰ za hodinu — rychlost nelze urychlit ničím. Proto nelze počítat „za dva poločasy bude polovina“.

Michaelisova–Mentenové kinetika

Přechod mezi oběma: při nízké koncentraci první řád, po nasycení enzymu nultý. Chová se tak fenytoin, salicyláty a theofylin.

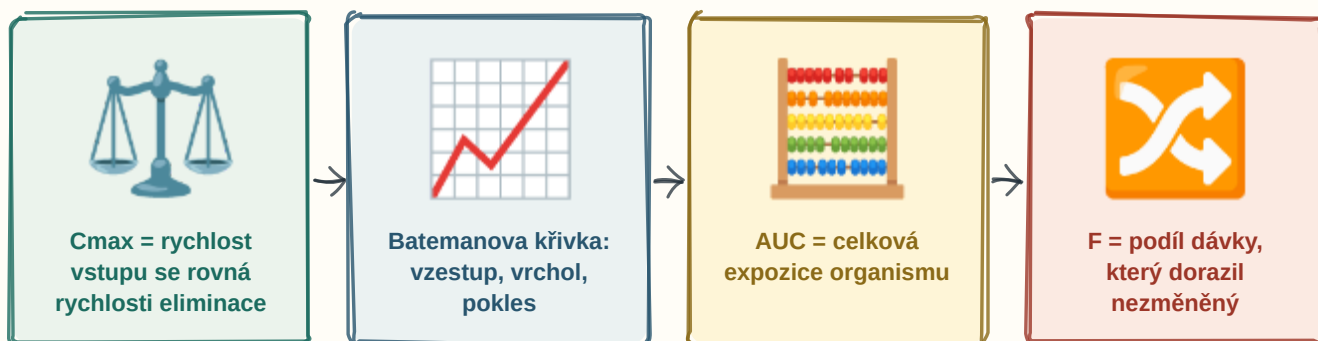
Klinický důsledek

U saturačního léčiva stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma — nystagmus, ataxie, zmatenost u fenytoinu. Proto se měří hladiny.

⚠ Ustálený stav (steady state) nastane za 4–5 poločasů a stejně dlouho trvá, než lék vymizí — proto se u dlouhého poločasu podává nasycovací dávka.

O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

C_{max} není konec vstřebávání — je to REMÍZA: okamžik, kdy se rychlost vstřebávání vyrovná rychlosti eliminace.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy

Ve vrcholu (C_{max}) se vstřebávání a eliminace vyrovnají — vstřebávání pokračuje i po něm, jen ho eliminace převáží.

Křivka

Batemanova funkce popisuje průběh koncentrace po jednorázovém perorálním podání: vzestupná fáze (převažuje absorpce), vrchol, sestupná fáze (převažuje eliminace).

Kalkulačka

AUC = plocha pod křivkou = celková expozice; podle ní se srovnává originál s generikem (bioekvivalence).

Biologická dostupnost

F = podíl podané dávky, který se dostane nezměněný do systémového oběhu. Snižuje ji neúplné vstřebání a first-pass metabolismus.

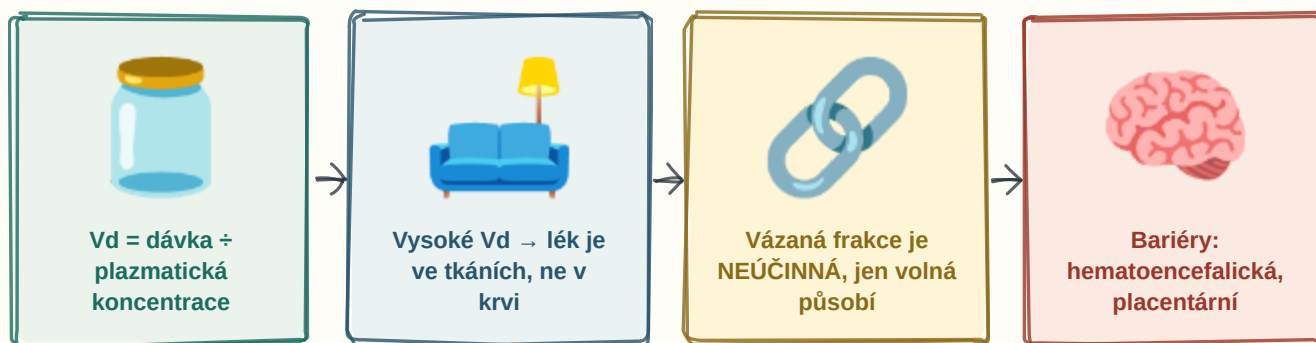
Co ovlivní vstřebání

Léková forma, rozpustnost, pH, jídlo, motilita, prokrvení, současně podaná léčiva (antacida, železo, vápník váží tetracykliny a chinolony).

⚠ t_{max} vypovídá o rychlosti vstřebávání, C_{max} a AUC o rozsahu. Generikum musí mít shodné AUC i C_{max} v předepsaném rozmezí — proto se u něj nezkontroluje znovu účinnost.

O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Vd je ZDÁNlivý objem — ne skutečný. Vysoké Vd znamená: „lék není v krvi, sedí ve tkáních“ — a dialýza ho nedostane ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nádoba

Distribuční objem je zdánlivý — je to počítaná veličina, ne anatomický prostor. Může mnohonásobně převýšit objem těla.

Gauč

Vysoké Vd = lék je uložený ve tkáních (tuk, sval), v krvi ho je málo — proto ho hemodialýza neodstraní (digoxin, antidepresiva).

Řetěz

Účinná je jen volná frakce. Albumin váže kyselé látky (warfarin, fenytoin), orosomukoid (kyselý α 1-glykoprotein) zásadité. Při hypoalbuminemii stoupá volná frakce a s ní účinek i toxicita.

Mozek

Hematoencefalická bariéra — těsné spoje a P-glykoprotein; propustí jen lipofilní a nenabitě látky. Placentární bariéra je propustnější, než se obvykle čeká.

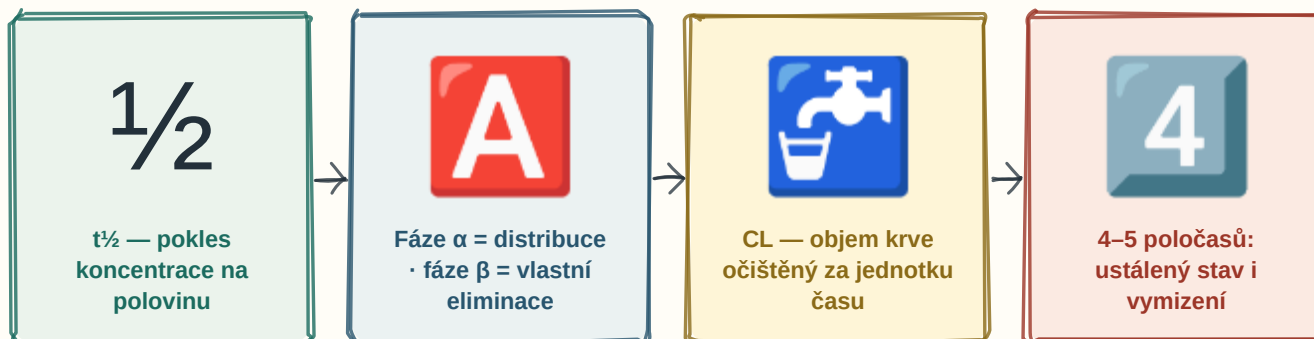
Redistribuce

Thiopental uspí rychle, protože se dostane do mozku, a probudí rychle, protože se přesune do svalu a tuku — konec účinku dělá přesun, ne eliminace.

⚠ Vytěsnění z vazby na bílkovinu je klasická interakce (sulfonamidy vytěsní warfarin), ale samo o sobě bývá klinicky přechodné — nebezpečné je, když se k němu přidá i útlum metabolismu.

O15 Eliminace, poločas, fáze α a β , eliminační konstanta, clearance

Za 4–5 poločasů se hladina ustálí — a stejně dlouho trvá, než lék po vysazení zmizí. Poločas je hodiny, ne účinek.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Polovina	Biologický poločas — doba, za kterou klesne koncentrace na polovinu. U kinetiky prvního řádu je konstantní a nezávisí na dávce.
Dvě fáze	Po i.v. podání klesá koncentrace nejprve strmě (fáze α — rozvod do tkání), pak pozvolna (fáze β — skutečná eliminace). Poločas se počítá z fáze β .
Kohoutek	Clearance = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; sčítá se renální a jaterní ($CL = CL_{ren} + CL_{hep}$). Vztah: $t_{1/2} = 0,693 \times V_d \div CL$.
Čtyřka	Za 4–5 poločasů se dosáhne ustáleného stavu při opakovaném podávání — a stejně dlouho trvá vymizení po vysazení.
Eliminační konstanta	kel — podíl látky odstraněný za jednotku času; $t_{1/2} = 0,693 \div kel$.

! Poločas roste, když klesne clearance (jaterní nebo renální selhání) NEBO když stoupne V_d — proto nestačí sledovat jen ledviny.

O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Když podáš další dávku dřív, než se vyloučí ta předchozí, lék se **HROMADÍ**.
Nasycovací dávka řeší čekání, udržovací drží hladinu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Hromada

Kumulace nastane, je-li dávkovací interval kratší než doba potřebná k eliminaci; ustálí se po 4–5 poločasech.

Raketa

Nasycovací dávka = $V_d \times \text{cílová koncentrace}$. Podává se, když je poločas dlouhý a nelze čekat 4–5 poločasů na účinek.

Kolotoč

Udržovací dávka = $CL \times \text{cílová koncentrace} \times \text{interval}$. Nahrazuje to, co se za interval vyloučí.

Graf

Krátký interval a malé dávky = plochá, stabilní hladina. Dlouhý interval a velké dávky = větší kolísání mezi vrcholem a údolím — riziko u léčiv s úzkým terapeutickým oknem.

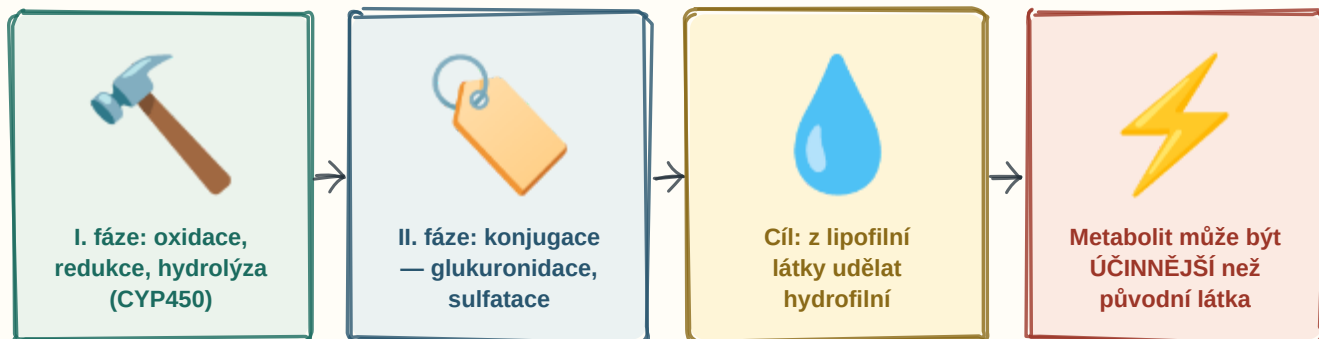
Kumulační index

Poměr koncentrace v ustáleném stavu k té po první dávce; udává, kolikrát se hladina nahromadí.

⚠ Nasycovací dávka závisí na V_d , udržovací na clearance — proto se u renální insuficience krátí udržovací dávka, ale nasycovací zůstává stejná.

O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Fáze I. látku ROZBIJE a odhalí funkční skupinu. Fáze II. na ni PŘILEPÍ velkou vodorozpustnou molekulu, aby šla ven.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kladivo

I. fáze — oxidace (hlavně cytochromy P450, nejvíc CYP3A4), redukce, hydrolýza. Vzniká reaktivnější metabolit s odhalenou funkční skupinou.

Štítek

II. fáze — konjugace: glukuronidace, sulfatace, acetylace, methylace, vazba na glutathion. Produkt je velký, polární a snadno vyloučitelný.

Kapka

Smyslem je změnit lipofilní látku na hydrofilní — jinak by se v ledvinách stále zpětně vstřebávala.

Blesk

Proléčivo se aktivuje až metabolismem: kodein → morfin (CYP2D6), enalapril → enalaprilát, cyklofosfamid, klopidoogrel. Metabolit může být i toxický: paracetamol → NAPQI.

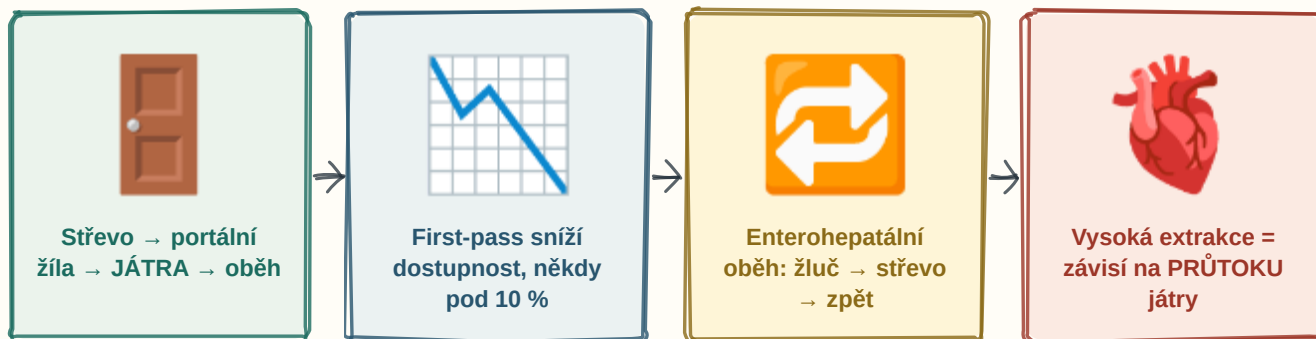
Kde

Především játra, ale i střevní stěna, plíce, ledviny a plazma (esterázy).

⚠ Novorozenec má nezralou glukuronidaci — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu. U starších klesá hlavně I. fáze, II. fáze zůstává poměrně zachovaná.

O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Co se vstřebá ze střeva, jde **NEJPRVE** do jater — teprve zbytek doputuje do těla. Proto je perorální dávka mnohonásobně vyšší než nitrožilní.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vrátnice

Vše vstřebané ze střeva projde portální žílou játry dřív, než se dostane do systémového oběhu.

Pokles

Silný first-pass mají nitroglycerin, propranolol, morfin, verapamil, lidokain — proto se nitroglycerin podává sublingválně a lidokain se ústy nepodává vůbec.

Kruh

Enterohepatální oběh: látka se vyloučí žlučí, ve střevě se uvolní zpět a znovu vstřebá — prodlužuje účinek (kontraceptiva; proto antibiotika mohou jejich účinnost snížit).

Srdce

U léčiv s vysokou jaterní extrakcí limituje eliminaci průtok játry — při srdečním selhání a šoku hladiny stoupají. U nízké extrakce rozhoduje enzymatická kapacita a vazba na bílkoviny.

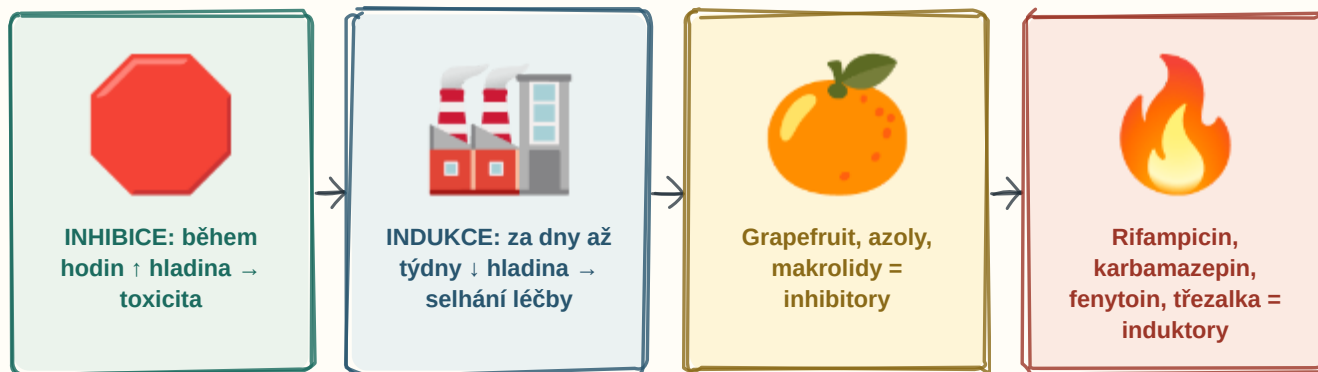
Jaterní selhání

Klesá metabolismus i tvorba albuminu, roste volná frakce a zkratový oběh obchází játra — dávky se snižují.

⚠ Rektální podání obchází first-pass jen zčásti (dolní část konečníku), proto je vstřebávání kolísavé. Sublingválně a transdermálně se játra obejdou zcela.

O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

INHIBICE je rychlá a hladina **VYSKOČÍ**. **INDUKCE** je pomalá a hladina **SPADNE** — musí se nasyntetizovat nový enzym.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Stopka

Inhibitor obsadí enzym hned — hladina druhého léčiva stoupá během hodin až dnů a hrozí toxicita.

Továrna

Induktor spouští tvorbu nového enzymu — trvá dny až týdny, než se plně projeví, a stejně dlouho odeznívá. Hladina druhého léčiva klesne a léčba selže.

Inhibitory

Grapefruitová šťáva, azolová antimykotika (flukonazol, itrakonazol), makrolidy (erythromycin, klarithromycin — nikoli azithromycin), ciprofloxacin, verapamil, amiodaron, ritonavir.

Induktory

Rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná; chronický alkohol a kouření (CYP1A2).

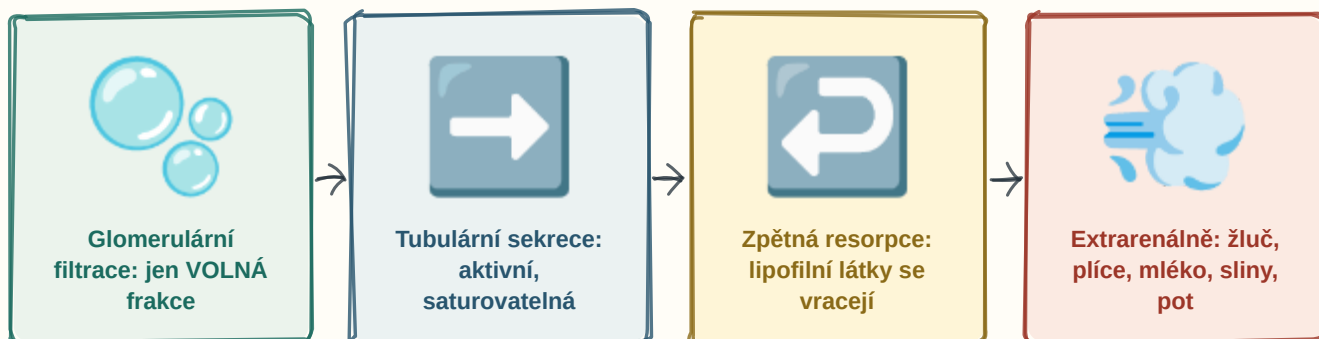
Co to udělá

Rifampicin sníží účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a antiretrovirotik. Klarithromycin se statinem zvýší riziko rabdomyolýzy.

⚠ U proléčiva je to obráceně: inhibitor CYP2D6 (fluoxetin, paroxetin) sníží účinek kodeinu a klopidoogrelu, protože zabrání jejich AKTIVACI.

O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

Ledvina dělá tři věci: **FILTRUJE**, **SEKRETUJE** a část zase **VSTŘEBÁ ZPĚT**.
Vyloučí se jen to, co je vodorozpuštěné.



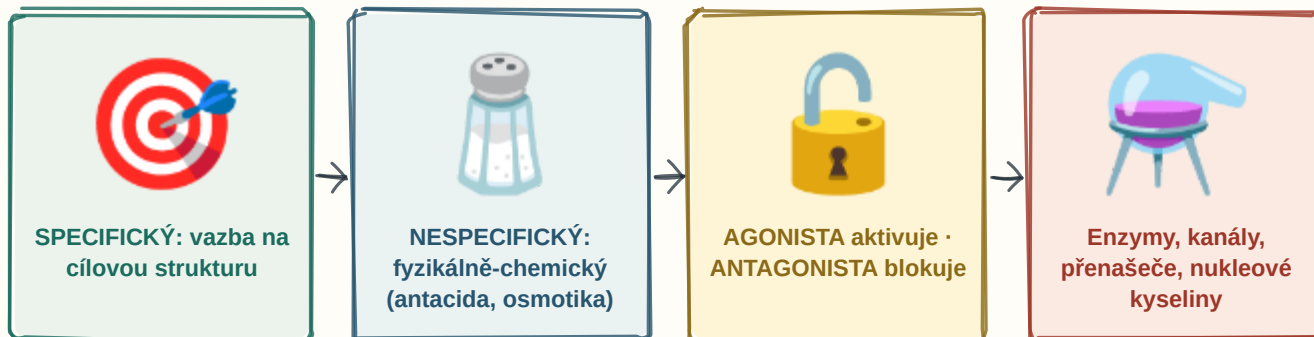
ROZKLÍČOVÁNÍ

Filtr	Glomerulem projde jen volná (nenavázaná) frakce; látka vázaná na albumin se nefiltruje.
Šipka ven	Tubulární sekrece je aktivní transport se společnými přenašeči — proto probenecid zpomaluje vylučování penicilinu (soupeří o týž přenašeč).
Šipka zpět	Lipofilní a nenabité látky se z tubulu vstřebávají zpět. Změnou pH moči se to dá ovlivnit: alkalizace bikarbonátem urychlí vyloučení kyselých látek (salicyláty, barbituráty).
Pára	Extrarenální cesty: žluč a stolice (a enterohepatální oběh), plíce (inhalační anestetika, ethanol — odtud dechová zkouška), mateřské mléko, sliny, pot.
Renální insuficience	Dávky léčiv vylučovaných ledvinami se snižují podle clearance kreatininu — aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium, mnohá antibiotika.

⚠ Vyloučit se dá jen látka vodorozpuštěná — proto předchází biotransformace. Lipofilní látka by se v tubulu jen stále dokola vstřebávala zpět.

O21 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Většina léčiv se váže na **CÍLOVOU STRUKTURU** — receptor, enzym, kanál nebo přenašeč. Nespecifický účinek žádnou cílovou strukturu nepotřebuje.



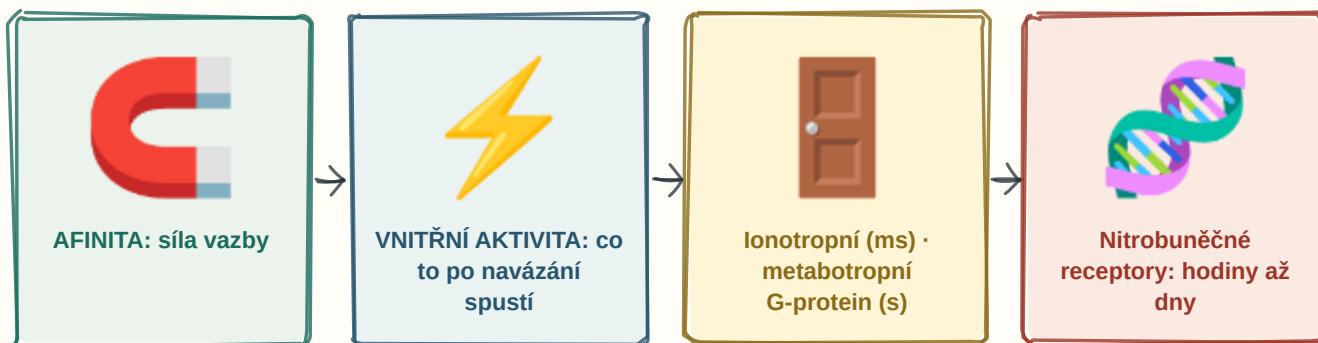
ROZKLÍČOVÁNÍ

Terč	Specifický účinek — vazba na receptor, enzym, iontový kanál, přenašeč nebo nukleovou kyselinu; je strukturně závislý a nasýtitelný.
Sůl	Nespecifický účinek — fyzikálně-chemický, bez cílové struktury: antacida neutralizují kyselinu, osmotická projímadla táhnou vodu, aktivní uhlí adsorbuje, celková anestetika mění vlastnosti membrány.
Klíč	Agonista se váže a receptor aktivuje (má afinitu i vnitřní aktivitu). Antagonista se váže, ale neaktivuje (má jen afinitu) — brání navázání agonisty.
Cílové struktury	Enzymy (statiny na HMG-CoA-reduktázu, ACE inhibitory), iontové kanály (lokální anestetika na sodíkové, blokátory kalciových kanálů), přenašeče (SSRI na serotoninový transportér, IPP na H ⁺ /K ⁺ -ATPázu), nukleové kyseliny (cytostatika, chinolony).

⚠ Účinek léčiva je vždy jen zesílení nebo zeslabení děje, který v těle už existuje — lék nevytváří novou funkci.

O22 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

AFINITA = jak pevně se to naváže. **VNITŘNÍ AKTIVITA** = jestli to po navázání něco udělá. Antagonista má afinitu, ale nulovou aktivitu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Magnet

Afinita — jak pevně se ligand váže; určuje potřebnou koncentraci.

Blesk

Vnitřní aktivita — co se po navázání stane. Plný agonista 1, parciální agonista mezi 0 a 1 (buprenorfin), antagonist 0, inverzní agonista pod 0 (utlumí i bazální aktivitu — H1-antihistaminika).

Dveře

Ionotropní receptory jsou samy iontovým kanálem — účinek za milisekundy (nikotinový acetylcholinový, GABA-A, NMDA). Metabotropní jdou přes G-protein a druhého posla — sekundy (muskarinové, adrenergní, opioidní).

DNA

Nitrobuněčné (jaderné) receptory mění přepis genů — účinek za hodiny až dny (kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, pohlavní hormony). Odsud jejich pomalý nástup.

Antagonismus

Kompetitivní — překonatelný vyšší dávkou agonisty, posouvá křivku doprava. Nekompetitivní — nepřekonatelný, snižuje maximum.

⚠ Down-regulace (úbytek receptorů při trvalé stimulaci) vysvětluje toleranci; up-regulace při dlouhé blokádě vysvětluje rebound fenomén po náhlém vysazení β -blokátoru.

O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

Terapeutické okno je pruh mezi „ještě to nefunguje“ a „už to škodí“. U digoxinu, warfarinu a lithia je ten pruh úzký jako vlas.



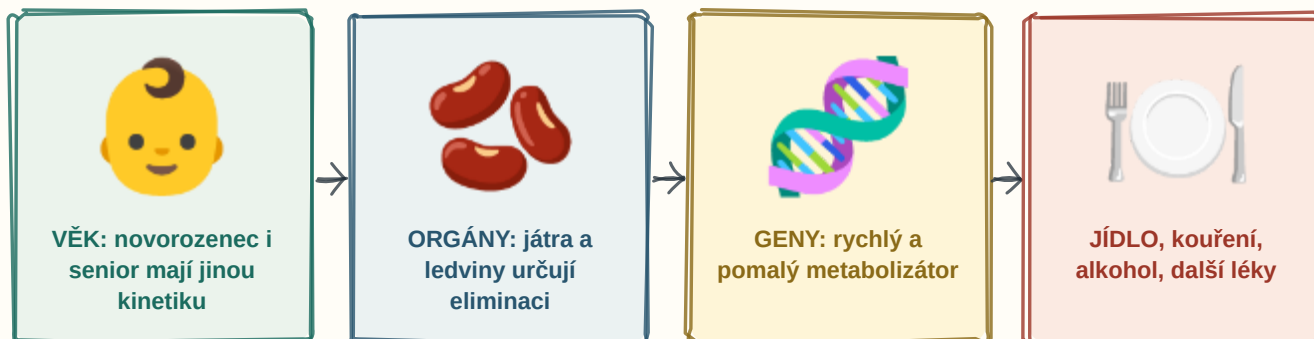
ROZKLÍČOVÁNÍ

Okno	Terapeutické okno — rozmezí koncentrací mezi minimální účinnou a toxickou.
Pravítko	Terapeutický index $TI = TD50 \div ED50$ (u zvířat $LD50 \div ED50$). $ED50$ = dávka účinná u poloviny, $TD50$ = toxická u poloviny, $LD50$ = smrtelná pro polovinu.
Fonendoskop	Úzký terapeutický index mají digoxin, warfarin, theofylin, lithium, fenytoin, aminoglykosidy, cyklosporin — u nich se měří plazmatické hladiny.
Číslice	NNT (number needed to treat) — kolik pacientů je třeba léčit, aby se u jednoho zabránilo příhodě; nízké NNT = účinná léčba. Obdobně NNH pro poškození.
Křivka	Vztah dávky a účinku je sigmoidní (v logaritmickém měřítku). Účinnost (efficacy) = jak vysokého maxima lék dosáhne; potence = jak malá dávka k tomu stačí.

⚠ Potentnější lék není lepší lék — znamená jen nižší potřebnou dávku. Rozhoduje maximální dosažitelný účinek a bezpečnost, ne velikost tablety.

O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Stejná dávka, jiný člověk, jiný účinek. Rozhodují játra, ledviny, věk, geny, další léky a jídlo.



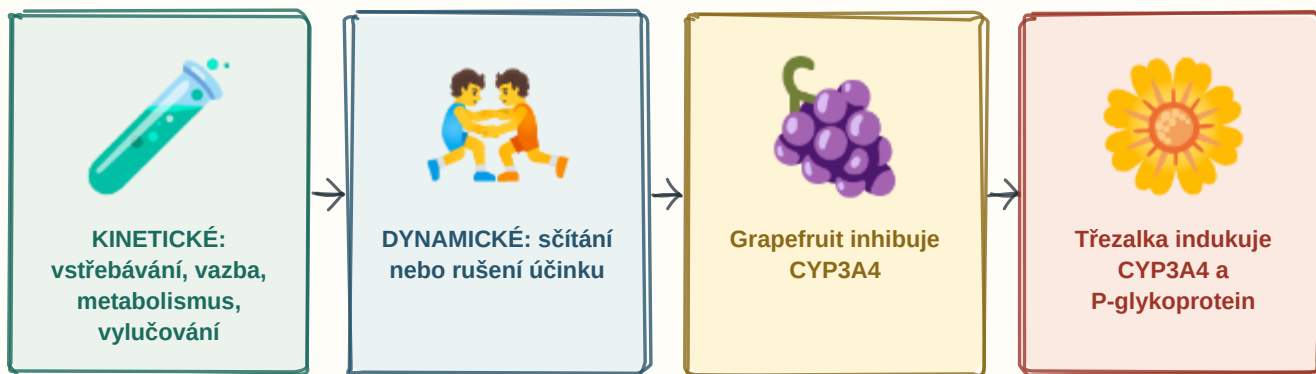
ROZKLÍČOVÁNÍ

Dítě	Novorozenec má nezralou glukuronidaci a vyšší podíl vody; senior má nižší glomerulární filtraci, nižší albumin, méně svaloviny a více tuku (lipofilní léčiva se hromadí).
Ledvina	Jaterní selhání snižuje metabolismus a tvorbu albuminu; renální insuficience zpomaluje vylučování. U obojího se dávky snižují.
DNA	Polymorfismus CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, NAT2, TPMT rozhoduje, zda je člověk pomalý, či ultrarychlý metabolizátor.
Talíř	Jídlo mění vstřebávání (mléko a antacida váží tetracykliny), grapefruit inhibuje CYP3A4, kouření indukuje CYP1A2 (theofylin, klozapin, olanzapin), alkohol akutně inhibuje a chronicky indukuje.
Dynamika	Mění se i citlivost cílové struktury: u seniorů vyšší citlivost na benzodiazepiny a opioidy, při hypokalemii vyšší toxicita digoxinu.

! Gravidita mění obojí: roste objem distribuce a glomerulární filtrace, klesá albumin — a přibývá otázka, co projde placentou.

O25 Lékové interakce

Interakce jsou dvojího druhu: **FARMAKOKINETICKÉ** (lék A změní hladinu léku B) a **FARMAKODYNAMICKÉ** (oba táhnou za též provaz).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zkumavka

Farmakokinetické: vstřebávání (antacida a železo váží tetracykliny a chinolony), vazba na bílkoviny (vytěsnění warfarinu), metabolismus (inhibice a indukce CYP450), vylučování (probenecid a penicilin).

Přetahovaná

Farmakodynamické: synergie (alkohol + benzodiazepiny = útlum dechu; ACE inhibitor + kalium šetřící diuretikum = hyperkalemie) nebo antagonismus (β -blokátor ruší účinek β 2-agonisty u astmatu).

Grapefruit

Inhibuje střevní CYP3A4 → prudce zvýší hladinu statinů, blokátorů kalciových kanálů a imunosupresiv.

Třezalka

Silný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu → sníží účinnost kontracepce, warfarinu, cyklosporinu, digoxinu a antiretrovirotik.

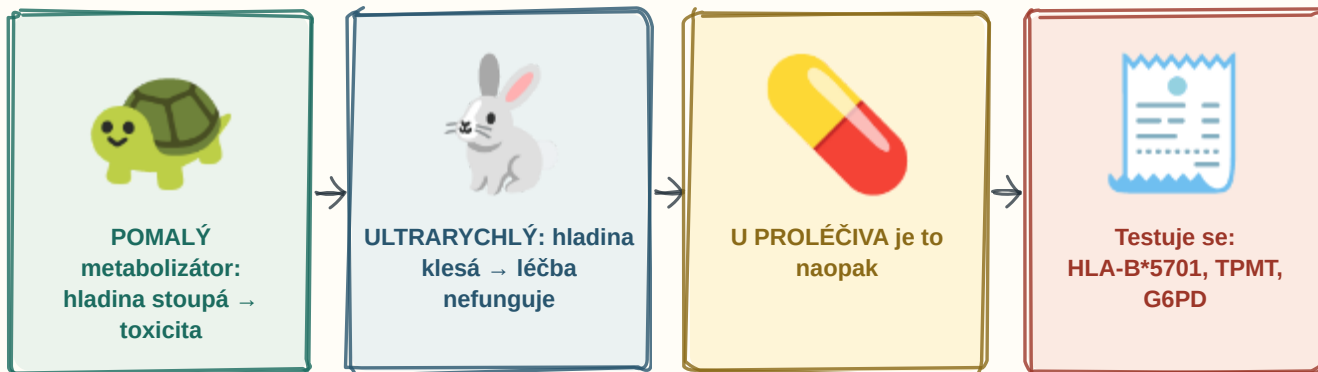
Nejrizikovější dvojice

Warfarin s čímkoli · statin s makrolidem nebo azolem · NSA s antikoagulanciem · látky prodlužující QT navzájem · serotonergní léčiva navzájem.

⚠ Nejvíce interakcí nevzniká z léků na předpis, ale z toho, co pacient nehlásí: volně prodejné NSA, doplňky stravy a bylinky.

O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Stejná dávka může být u jednoho neúčinná a u druhého toxická — rozhoduje, jestli je POMALÝ, nebo ULTRARYCHLÝ metabolizátor.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Želva

Pomalý metabolizátor odbourává léčivo pomalu — hladina stoupá a hrozí toxicita (CYP2D6 a antidepresiva, CYP2C9 a warfarin).

Zajíc

Ultrarychlý metabolizátor odbourá léčivo dříve, než stačí zabrat — léčba selhává.

Proléčivo

U proléčiva se to obrací: ultrarychlý metabolizátor CYP2D6 vytvoří z kodeinu nebezpečně mnoho morfinu, pomalý metabolizátor nemá z kodeinu ani z klopidoogrelu žádný účinek.

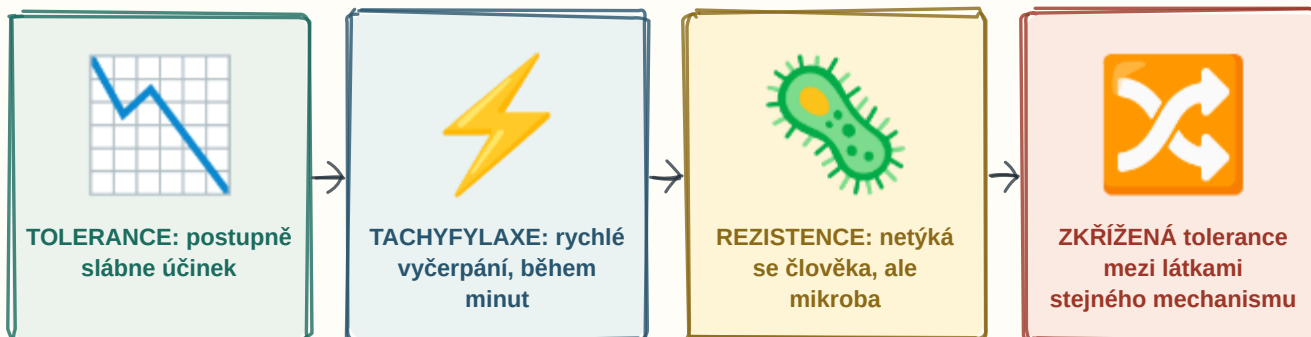
Testy

HLA-B*5701 před abakavirem (hypersenzitivita), HLA-B*5801 před allopurinolem, TPMT před azathioprinem a 6-merkaptopurinem (myelosuprese), G6PD před primachinem a sulfonamidy (hemolýza), NAT2 a rychlost acetylace izoniazidu.

⚠ Farmakogenetika vysvětluje i idiosynkrazii — geneticky podmíněnou neobvyklou reakci, například maligní hypertermii po sukcinylcholinu a halotanu.

O27 Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

TOLERANCE se buduje dny až týdny. **TACHYFYLAXE** je bleskurychlá — přijde během minut a novou dávkou ji nepřekonáš.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klesající křivka

Tolerance — na týž účinek je třeba stále vyšší dávka. Farmakodynamická (down-regulace receptorů) nebo farmakokinetická (indukce vlastního metabolismu, např. barbituráty).

Blesk

Tachyfylaxe — velmi rychlý pokles účinku při opakovaném podání v krátkém sledu, typicky vyčerpáním zásoby mediátoru (efedrin) nebo obsazením receptorů; zvýšení dávky nepomůže. Vzniká i u nitrátů, proto se ponechává noční interval bez náplasti.

Bakterie

Rezistence je vlastnost mikroorganismu, ne pacienta — primární (přirozená) nebo získaná (mutace, přenos plazmidu). Neplet si ji s tolerancí.

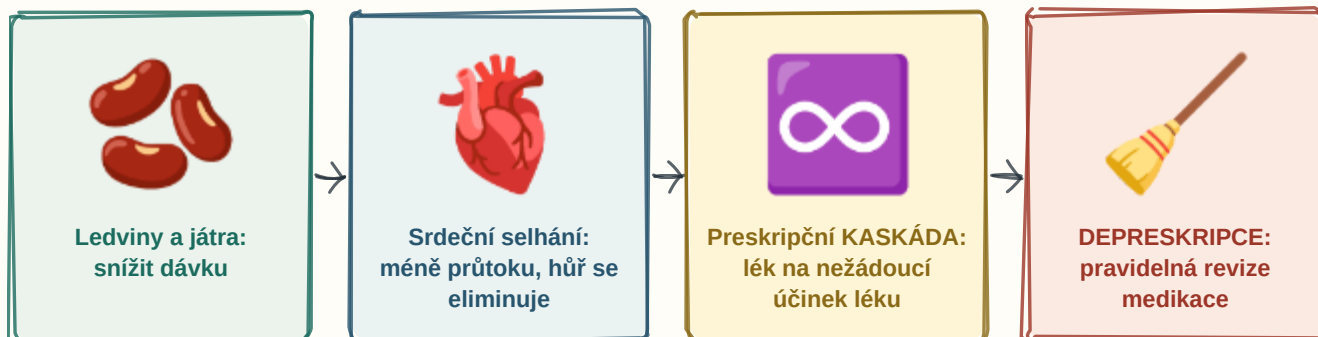
Křížení

Zkřížená tolerance existuje mezi látkami se stejným mechanismem — alkohol, benzodiazepiny a barbituráty; morfin a ostatní opioidy.

⚠ Tolerance na různé účinky téže látky se vyvíjí různě rychle: u opioidů rychle na euforii a útlum dechu, ale prakticky vůbec na zácpu a miózu.

O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmatie

Každý další lék zvyšuje riziko interakce geometricky. A předepsat lék na nežádoucí účinek jiného léku je začátek KASKÁDY.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ledvina

Renální insuficience — snížit dávku léčiv vylučovaných ledvinami (aminoglykosidy, digoxin, metformin, lithium). Jaterní selhání — nižší metabolismus, nižší albumin, zkratový oběh.

Srdce

Srdeční selhání snižuje průtok játry i ledvinami; u léčiv s vysokou jaterní extrakcí hladina stoupá.

Kaskáda

Preskripční kaskáda: metoklopramid vyvolá parkinsonské projevy → nasadí se antiparkinsonikum. Blokátor kalciových kanálů vyvolá otoky → nasadí se diuretikum. Vždy se nejdřív ptej, jestli nový příznak není nežádoucí účinek.

Koště

Depreskripce — plánované vysazení léků, které už nepřinášejí užitek; u polymorbidních je stejně důležitá jako nasazení.

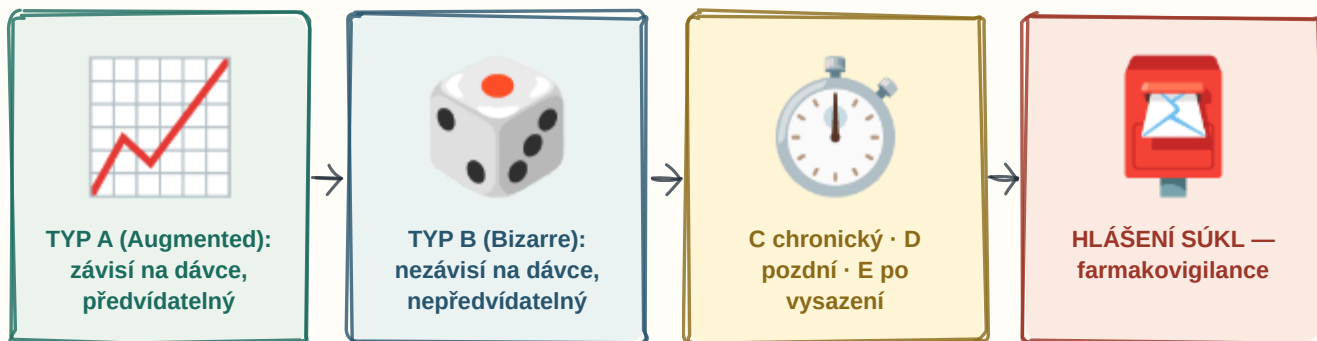
Polypragmatie

Zpravidla 5 a více léčiv současně; roste riziko interakcí, pádů, hospitalizací a klesá adherence.

⚠ Kontraindikace bývají dané právě přidruženou chorobou: β -blokátor u astmatu, NSA u renální insuficience a vředové choroby, metformin při riziku laktátové acidózy.

O29 Nežádoucí účinky léčiv

Typ A je ZESÍLENÝ ÚČINEK — dá se předvídat, závisí na dávce, je častý.
Typ B je BIZARNÍ — nepředvídatelný, na dávce nezávisí, ale zabíjí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vzestup

Typ A — vyplývá z farmakologického účinku, závisí na dávce, je častý a málokdy smrtelný; řeší se snížením dávky. Krvácení po warfarinu, hypoglykemie po inzulinu, bradykardie po β -blokátoru.

Kostka

Typ B — nesouvisí s dávkou ani s mechanismem, nedá se předvídat; je vzácný, ale často závažný. Alergie, aplastická anemie po chloramfenikolu, maligní hypertermie, Stevensův–Johnsonův syndrom.

Hodiny

Typ C — chronický, při dlouhém podávání (osteoporóza po kortikoidech). Typ D — pozdní (teratogenita, kancerogenita). Typ E — po náhlém vysazení (rebound hypertenze, adrenální insuficience).

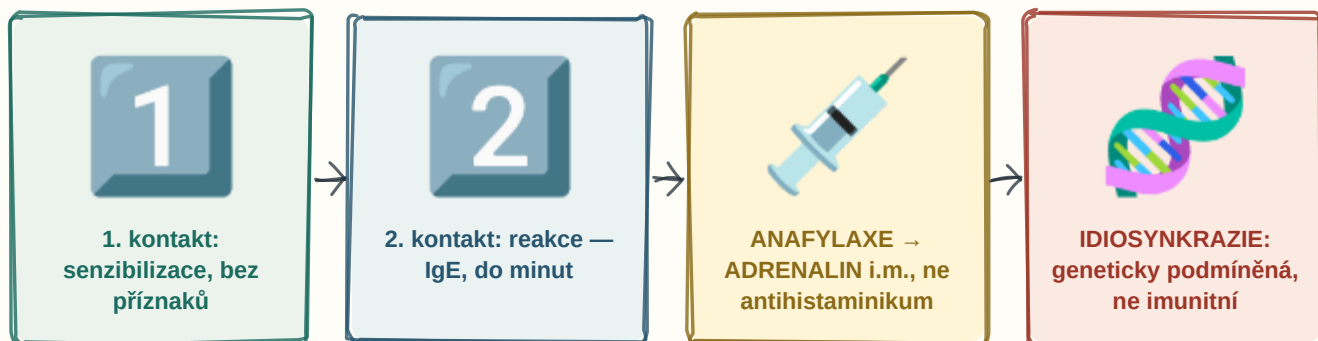
Schránka

Podezření na nežádoucí účinek se hlásí SÚKL; u nově registrovaných léčiv (černý trojúhelník) se hlásí i podezření běžná. Právě tak se odhalí to, co ve fázi III nevyšlo najevo.

⚠ Typ A se řeší úpravou dávky. Typ B znamená lék vysadit a už nikdy nepodat — a poznamenat do dokumentace.

O30 Léková alergie, idiosynkrazie

Alergie POTŘEBUJE PŘEDCHOZÍ SETKÁNÍ — první podání senzibilizuje, druhé spustí reakci. Nesnášenlivost není alergie.



ROZKLÍČOVÁNÍ

První setkání

Senzibilizace probíhá bez příznaků; proto reakce nikdy nepřijde při úplně prvním podání.

Druhé setkání

Typ I (IgE, časný) — kopřivka, angioedém, bronchospasmus, anafylaxe během minut. Typ II cytotoxický, typ III imunokomplexový (sérová nemoc), typ IV pozdní buněčný (kontaktní ekzém, makulopapulózní exantém za dny).

Adrenalin

U anafylaxe je lékem první volby adrenalin intramuskulárně do stehna; antihistaminika a kortikosteroidy jsou pouze doplňkové a působí příliš pomalu.

Idiosynkrazie

Geneticky podmíněná neobvyklá reakce bez účasti imunity — hemolýza při deficitu G6PD, maligní hypertermie po succinylcholinu, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.

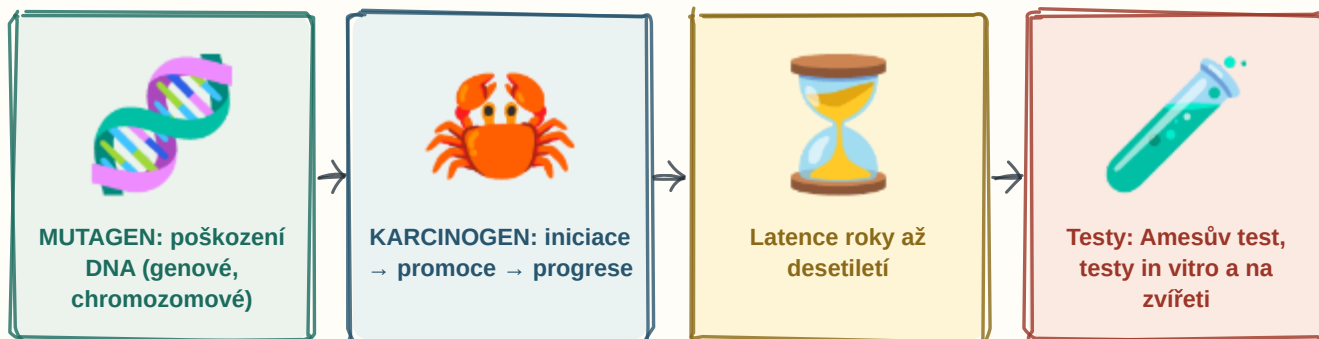
Zkřížená alergie

Mezi peniciliny a cefalosporiny existuje, ale je nižší, než se dřív uvádělo; anafylaxe na penicilin v anamnéze je však kontraindikací celé skupiny.

⚠ Nausea po antibiotiku není alergie, ale nesnášenlivost — přesto se často zapisuje jako alergie a pacient pak zbytečně přijde o celou lékovou skupinu.

O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

Mutagen poškodí DNA. Karcinogen z toho udělá nádor. A projeví se to za roky až desetiletí — proto to žádná studie nezachytí včas.



ROZKLÍČOVÁNÍ

DNA

Mutagenita — poškození genetické informace: genové mutace, chromozomové aberace, změny počtu chromozomů. Postihuje-li zárodečné buňky, přenáší se na potomstvo.

Nádor

Karcinogeneze má fáze iniciace (nevratné poškození DNA), promoce (podpora množení poškozeného klonu) a progresse. Genotoxické karcinogeny nemají bezpečnou dávku, negenotoxické (hormonální, imunosupresivní) působí nepřímo.

Přesýpací hodiny

Dlouhá latence je důvod, proč se karcinogenita odhalí až po letech užívání — a proč se testuje předklinicky.

Zkumavka

Amesův test (mutagenita na bakteriích), testy chromozomových aberací, dlouhodobé studie na hlodavcích.

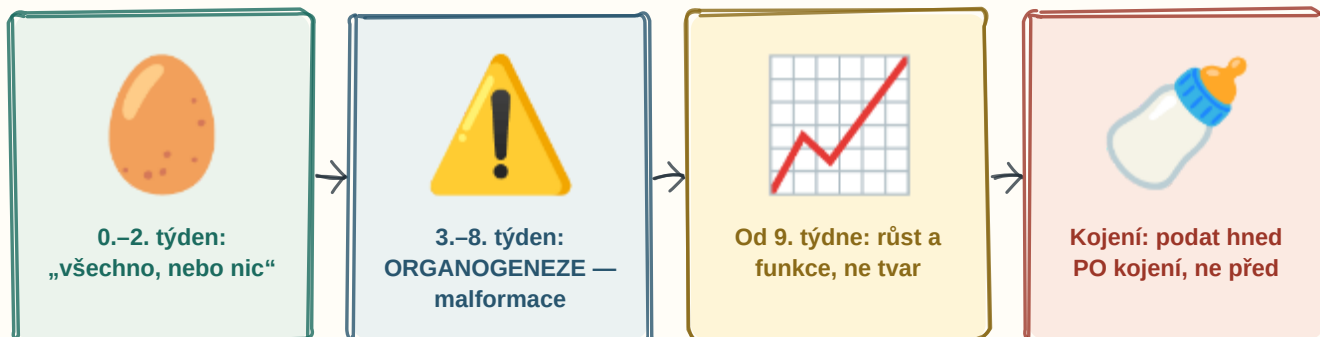
Příklady

Cytostatika (alkylační látky — sekundární leukemie), imunosupresiva (lymfomy a kožní nádory), estrogény bez gestagenu (karcinom endometria), tabákový kouř.

⚠ Cytostatika léčí nádor a zároveň zvyšují riziko nádoru druhého — to není rozpor, ale poměr rizika a prospěchu, který se u každého pacienta váží zvlášť.

032 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Nejzranitelnější je **ORGANOGENEZE (3.–8. týden)** — a to je doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Vajíčko

Do 2. týdne platí pravidlo „všechno, nebo nic“ — buď zárodek zanikne, nebo se poškození plně opraví.

Varování

3.–8. týden je organogeneze a období největšího rizika strukturních vad. Klasické teratogeny: isotretinoin a ostatní retinoidy, thalidomid, warfarin, valproát, karbamazepin, fenytoin, metotrexát, mykofenolát, ACE inhibitory a sartany, tetracykliny, živé vakcíny, inhibitory 5- α -reduktázy.

Růst

Po organogenezi vznikají funkční poruchy a poruchy růstu — ACE inhibitory poškozují ledviny plodu, NSA předčasně uzavírají ductus arteriosus, tetracykliny barví zuby.

Kojení

Do mléka přechází nejspíš látka lipofilní, málo vázaná na bílkoviny a zásaditá. Podává se ihned po kojení, aby do dalšího přiložení hladina klesla. Kontraindikovány jsou cytostatika, radiofarmaka, lithium, amiodaron.

Rozhodování

Neléčená nemoc matky (epilepsie, astma, těžká deprese, infekce) ohrožuje plod často víc než lék — proto se neléčí „nulovým rizikem“, ale poměrem rizika a prospěchu.

Kyselina listová se podává preventivně už před početím jako prevence rozštěpů neurální trubice — u žen na antiepileptících ve vyšší dávce.

O33 Farmakoterapie v dětství

Dítě není zmenšený dospělý. Dávkuje se na KILOGRAM nebo na povrch těla — a některé léky nesmí dostat vůbec.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy

Dávkuje se na kilogram tělesné hmotnosti, u cytostatik na plochu povrchu těla; nikdy se nepřepočítává „zlomkem dávky dospělého“ od oka.

Kojenec

Novorozenec má nezralé jaterní enzymy (glukuronidaci — odtud gray baby syndrom po chloramfenikolu), vyšší podíl tělesné vody (vyšší Vd pro hydrofilní léčiva), nižší vazbu na bílkoviny a nezralou glomerulární filtraci.

Zákaz

Tetracykliny do 8 let (zbarvení zubů a hypoplazie skloviny) · chinolony (poškození chrupavky) · kodein a tramadol (útlum dechu u ultrarychlých metabolizátorů) · kyselina acetylsalicylová u virózy (Reyeův syndrom) · metoklopramid (dystonie).

Sirup

Perorální roztoky, sirupy, kapky, čípky; při dlouhodobé léčbě pozor na obsah cukru a etanolu v přípravku.

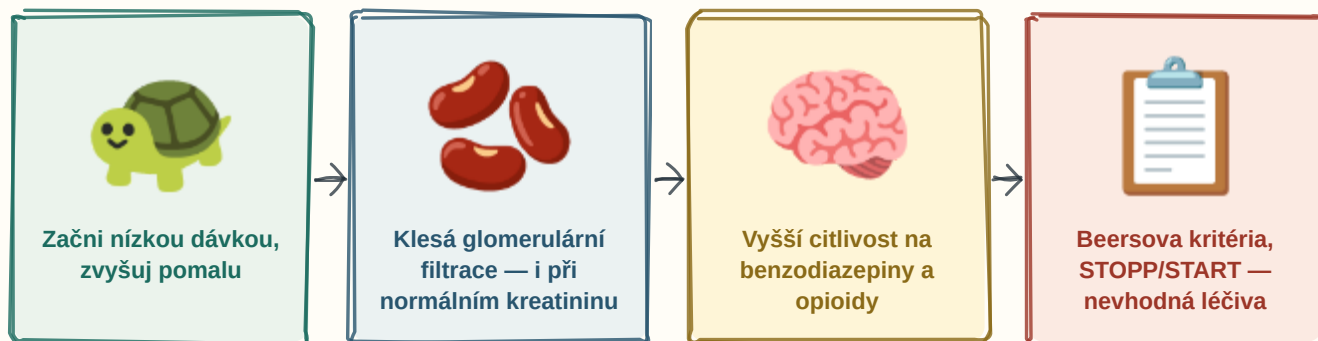
Off-label

Řada léčiv nemá u dětí registraci — podávají se off-label na základě odborných doporučení, protože klinické studie na dětech jsou vzácné.

⚠ Paracetamol a ibuprofen jsou základní antipyretika dětského věku; kyselina acetylsalicylová se u dětí s horečnatým virovým onemocněním nepodává pro riziko Reyeova syndromu.

O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Ve stáří: „START LOW, GO SLOW“. Klesá filtrace, klesá albumin, přibývá tuku — a citlivost mozku na tlumivé léky roste.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Želva

Start low, go slow — nižší úvodní dávka a pomalá titrace; kontrola účinku i nežádoucích účinků.

Ledvina

Glomerulární filtrace klesá s věkem i při normálním sérovém kreatininu, protože ubývá svalové hmoty — proto se počítá clearance, ne jen kreatinin.

Mozek

Roste citlivost na benzodiazepiny, opioidy, anticholinergika a antipsychotika — riziko pádů, zmatenosti a deliria. Ubývá svalů a přibývá tuku, takže lipofilní léčiva se hromadí a mají delší poločas.

Seznam

Beersova kritéria a STOPP/START vyjmenovávají léčiva u seniorů nevhodná (dlouhodobě působící benzodiazepiny, anticholinergika, NSA) a naopak ta, která chybějí.

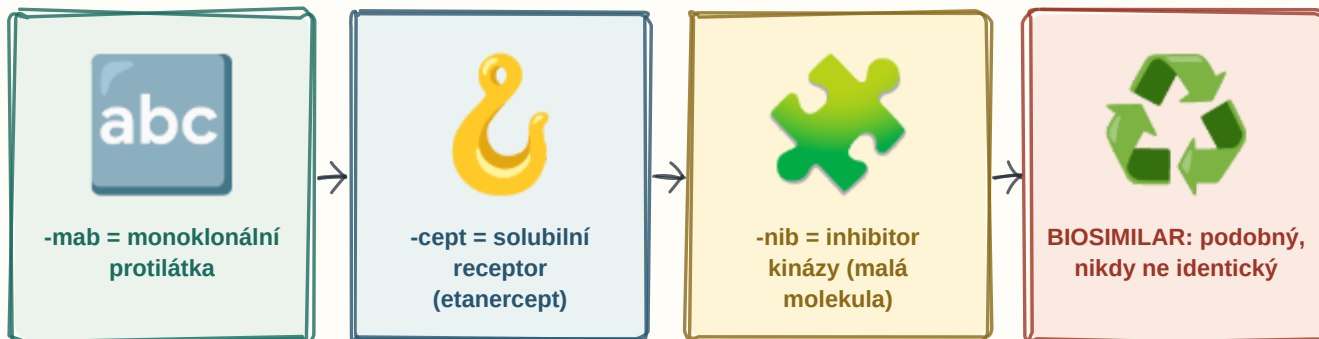
Anticholinergní zátěž

Sčítá se z mnoha léků najednou (antihistaminika I. generace, tricyklická, spasmolytika, některá antipsychotika) — výsledkem je zmatenost, retence moči, zácpa a pády.

⚠ Nový příznak u seniora je nežádoucí účinek léku, dokud se neprokáže opak — teprve pak se hledá nová diagnóza. Jinak vzniká preskripční kaskáda.

O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars

Konec názvu prozradí, co to je: -MAB je protilátka, -CEPT je vazebný receptor, -NIB je malá molekula inhibující kinázu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Přípona -mab

Monoklonální protilátka. Předposlední slabika říká původ: -xi- chimérická (infliximab), -zu- humanizovaná (trastuzumab), -u- plně lidská (adalimumab). Podávají se parenterálně — bílkovina by se v trávicím traktu strávila.

Přípona -cept

Fúzní bílkovina, solubilní receptor, který na sebe naváže cytokin (etanercept váže TNF- α , abatacept, aflibercept).

Přípona -nib

Malá molekula, inhibitor kinázy — na rozdíl od protilátek se podává perorálně (imatinib, tofacitinib, ibrutinib).

Biosimilar

Biologicky podobný přípravek — u bílkoviny nelze vyrobit přesnou kopii jako u generika, proto se dokládá srovnatelná kvalita, účinnost a bezpečnost, ne pouhá bioekvivalence.

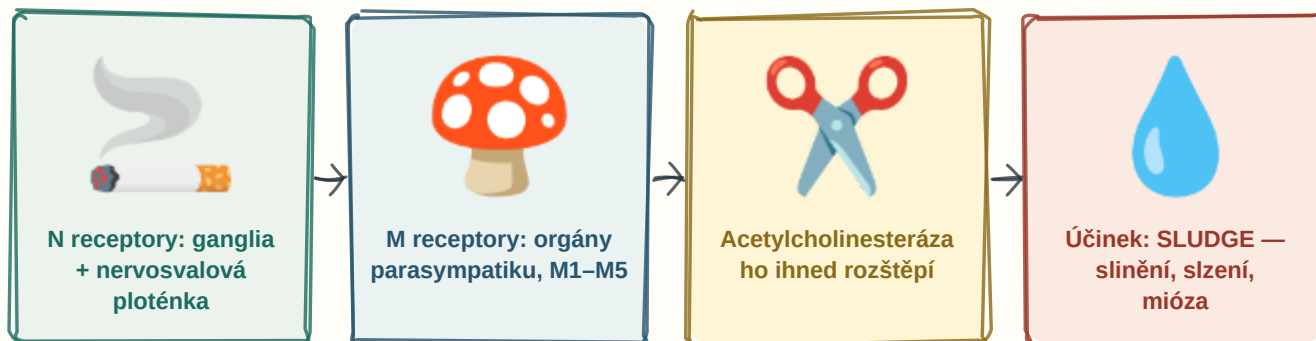
Rizika

Infuzní a hypersenzitivní reakce, imunogenicita (tvorba protilátek proti léku), zvýšené riziko infekcí. ⚠ Před anti-TNF- α je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace.

⚠ Biologika jsou bílkoviny — proto se nepodávají ústy, jsou drahá, vyžadují chladový řetězec a mohou vyvolat tvorbu neutralizujících protilátek, které je časem přestanou nechávat účinkovat.

36 Cholinergní přenos vzruchu

Acetylcholin má DVA typy zámků: NIKOTINOVÝ (rychlý, iontový kanál — ganglia a sval) a MUSKARINOVÝ (pomalý, přes G-protein — orgány).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nikotinové

Ionotropní — jsou samy iontovým kanálem, účinek za milisekundy. Nn v gangliích a dření nadledvin, Nm na nervosvalové ploténce.

Muskarinové

Metabotropní, přes G-protein. M1 v CNS a gangliích, M2 v srdci (zpomalí ho), M3 v hladkém svalu a žlázách (kontrakce, sekrece).

Nůžky

Acetylcholin vzniká z cholinu a acetyl-CoA (cholinacetyltransferáza), po uvolnění ho okamžitě štěpí acetylcholinesteráza — proto je jeho účinek velmi krátký.

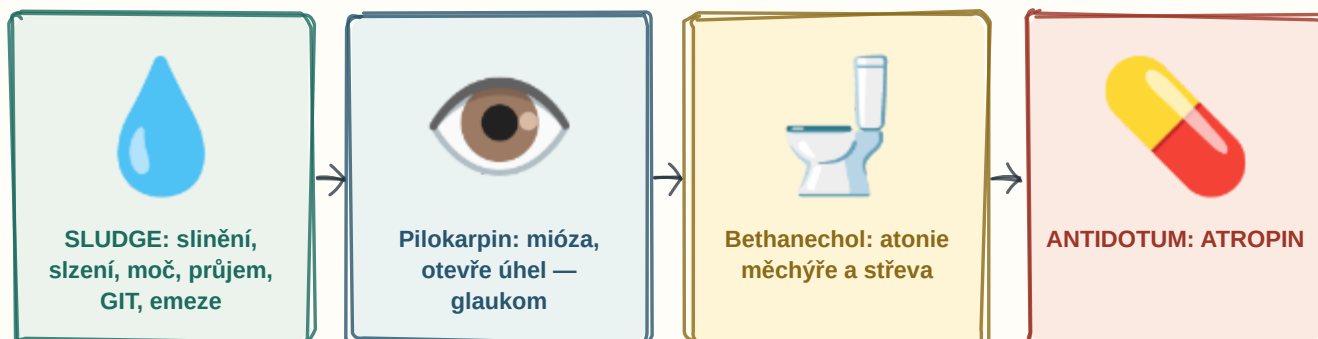
Účinky parasympatiku

Mióza, akomodace na blízko, slzení a slinění, bradykardie, bronchokonstrikce a sekrece hlenu, zvýšená peristaltika, vyprázdnění močového měchýře.

⚠ Symptikus i parasympatikus mají v gangliích tentýž nikotinový receptor — proto ganglioplegika ovlivňují obojí a mají tolik nežádoucích účinků.

37 Přímá cholinomimetika

Přímé cholinomimetikum sedne rovnou na receptor. Účinek = všechno teče a všechno se stahuje: SLUDGE.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kapky

SLUDGE = salivation, lacrimation, urination, diarrhea, GI motility, emesis — typický muskarinový obraz.

Oko

Pilocarpin je terciární amin z rostliny; stahuje musculus sphincter pupillae (mióza) a ciliární sval, čímž otevře komorový úhel — používá se u glaukomu s uzavřeným úhlem a u xerostomie po ozáření.

Měchýř

Bethanechol — karbamátový ester, odolný vůči acetylcholinesteráze; stimuluje močový měchýř a střevo u pooperační atonie.

Atropin

Antidotem předávkování je atropin. Karbachol se používá v oftalmologii; methacholin jen k bronchoprovokačnímu testu.

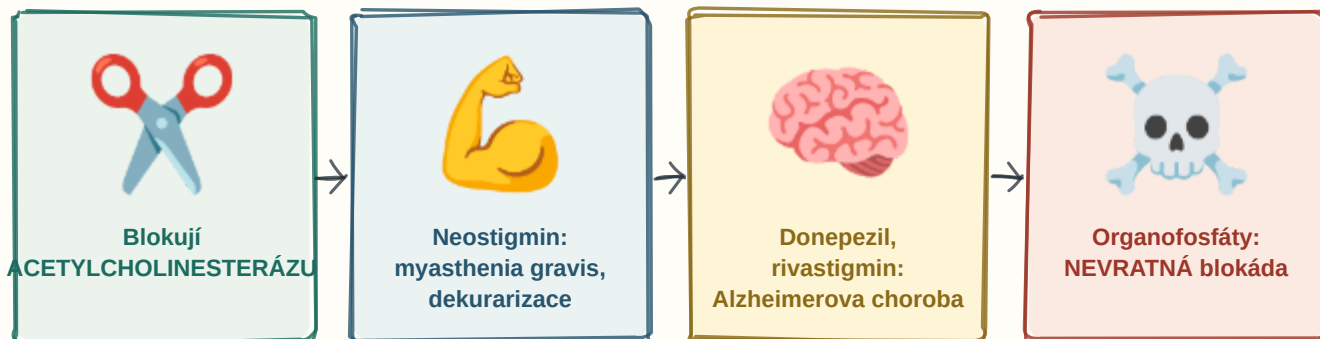
Kontraindikace

Astma a CHOPN (bronchokonstrikce), vředová choroba, bradykardie a poruchy vedení, obstrukce močových cest a střeva.

⚠ Muskarin z muchomůrky červené a strmělek působí týž obraz — otrava se proto léčí atropinem.

38 Nepřímá cholinomimetika

Nepřímé cholinomimetikum receptor nezná — jen ZABRÁNÍ ROZLOŽENÍ acetylcholinu, takže ho v synapsi zůstane víc.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nůžky přeříznuté

Inhibicí acetylcholinesterázy stoupá koncentrace acetylcholinu v synapsi — účinek je tedy nepřímý a závisí na vlastní produkci mediátoru.

Sval

Neostigmin a pyridostigmin jsou kvartérní aminy — do CNS nepronikají; užívají se u myasthenia gravis, k dekurarizaci po nedepolarizujících myorelaxancích a u pooperační atonie. Edrofonium má krátký účinek (dříve diagnostický test).

Mozek

Donepezil, rivastigmin a galantamin jsou terciární aminy — do CNS pronikají, používají se u Alzheimerovy choroby. Fysostigmin je antidotem anticholinergního deliria.

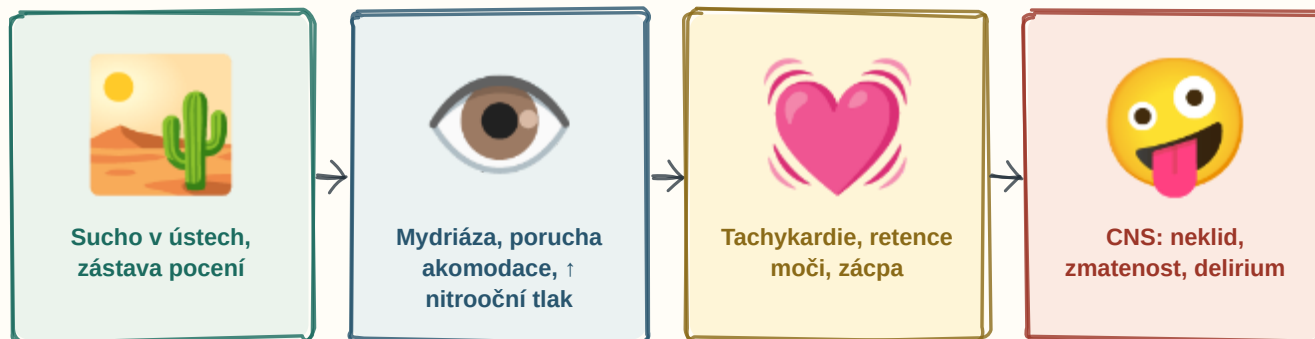
Lebka

Organofosfáty (insekticidy, bojové látky) vážou enzym nevratně — vzniká cholinergní krize: mióza, bronchorea, bronchospasmus, bradykardie, křeče, obrna dýchacích svalů. Antidotem je ATROPIN (blokuje muskarinové účinky) + PRALIDOXIM (reaktivuje enzym, dokud nedojde ke „stárnutí“ vazby).

⚠ Atropin sám organofosfátovou otravu nevyřeší — neúčinkuje na nikotinové receptory, a tedy ani na obrnu dýchacích svalů. Proto se přidává pralidoxim.

39 Parasympatolytika

Atropin dělá pravý opak SLUDGE: „**SUCHÝ** jako kost, **RUDÝ** jako řepa, **HORKÝ** jako pec, **SLEPÝ** jako netopýr, **ŠÍLENÝ** jako kloboučník.“



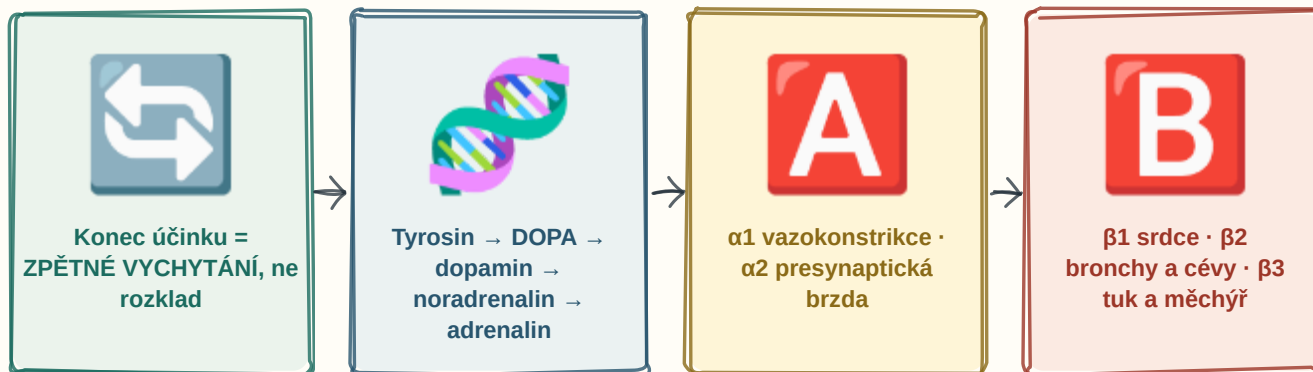
ROZKLÍČOVÁNÍ

Poušť	Blokáda muskarinových receptorů — vysychají sliznice, ustane pocení, a tím stoupá teplota (u dětí nebezpečná hypertermie), kůže je suchá a zarudlá.
Oko	Mydriáza a paralýza akomodace (cykloplegie); ⚠ kontraindikací je glaukom s uzavřeným úhlem, protože rozšířená duhovka uzavře komorový úhel.
Srdce	Tachykardie (blokáda M2), retence moči — proto pozor u hyperplazie prostaty — a zácpa až paralytický ileus.
Zástupci	Atropin (bradykardie, premedikace, antidotum organofosfátů) · butylskopolamin (kvartérní, do CNS nepronikne — spasmolytikum) · ipratropium a tiotropium (inhalačně u CHOPN a astmatu) · tropikamid (oční vyšetření) · biperiden (léková parkinsonská symptomatika) · oxybutynin a solifenacin (hyperaktivní měchýř).
Antidotum	Fysostigmin — terciární amin, který proniká do CNS a zvrátí i centrální anticholinergní delirium.

⚠ Butylskopolamin je kvartérní amin, a proto neseduje ani nevyvolá delirium — atropin a skopolamin (terciární aminy) ano.

40 Adrenergní přenos vzruchu

Noradrenalin se **NEROZKLÁDÁ** v synapsi jako acetylcholin — z 80 % se **VYCHYTÁ ZPĚT** do nervu. Proto na něj útočí kokain i tricyklicka.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kruh

Účinek končí především zpětným vychytáváním (uptake-1) do nervového zakončení; teprve pak látku odbourává MAO a COMT. Kokain, tricyklicka a SNRI tento transportér blokují.

Syntéza

Tyrosin → DOPA (tyrosinhydroxyláza, krok určující rychlost) → dopamin → noradrenalin; v dřeni nadledvin dále na adrenalin.

Alfa

α1 — vazokonstrikce, mydriáza, kontrakce svěrače měchýře a prostaty. α2 — presynapticky tlumí další výlev noradrenalinu (proto klonidin snižuje tlak centrálně).

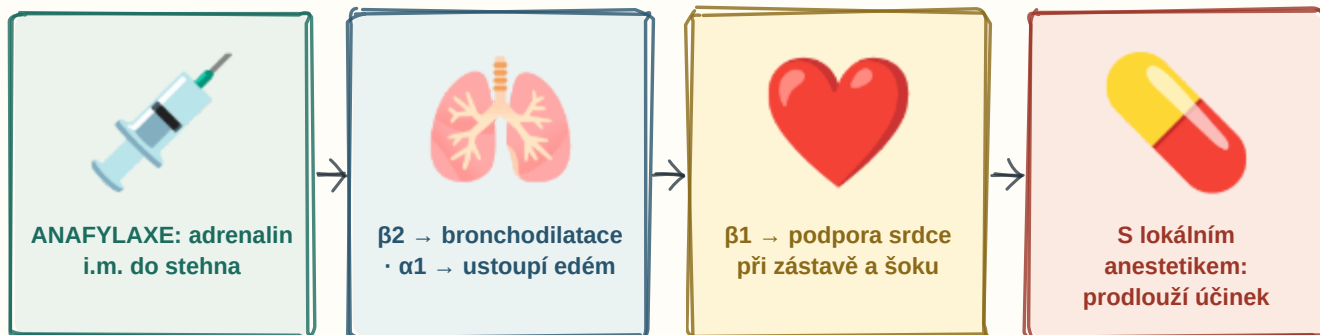
Beta

β1 — srdce: zvýšená frekvence, vodivost a kontraktilita; v ledvině výlev reninu. β2 — bronchodilatace, vazodilatace ve svalech, relaxace dělohy, tremor, hypokalemie. β3 — lipolýza, relaxace detruzoru (mirabegron).

⚠ Adrenalin má afinitu ke všem receptorům, noradrenalin převážně k α a β1 (β2 skoro nestimuluje) — proto noradrenalin zvyšuje tlak vazokonstrikcí, kdežto adrenalin ve vyšší dávce navíc rozšiřuje bronchy.

41 Neselektivní sympatomimetika

ADRENALIN je lék první volby u ANAFYLAXE — a to intramuskulárně do stehna. Žádné antihistaminikum ho nenahradí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Střikačka

Adrenalin působí na α i β receptory. U anafylaxe se podává intramuskulárně do stehna (m. vastus lateralis) — nástup je rychlejší a bezpečnější než subkutánně.

Plíce

β_2 rozšíří bronchy, α_1 stáhne cévy a ustoupí otok sliznice a angioedém — obojí zároveň, což žádný jiný lék neumí.

Srdce

β_1 zvyšuje kontraktilitu a frekvenci; adrenalin se podává při srdeční zástavě a v šoku. Vysoké dávky působí arytmie a hypertenzi.

Anestetikum

Přídavek adrenalinu k lokálnímu anestetiku způsobí vazokonstrikci — zpomalí vstřebávání, prodlouží účinek a sníží krvácení a systémovou toxicitu.

Izoprenalin

Neselektivní β -agonista (β_1 i β_2) — dnes okrajově u bradykardie a AV blokády. Dopamin a dobutamin patří k inotropní podpoře.

⚠ U pacienta na β -blokátoru může být adrenalin méně účinný — pak se u anafylaxe podává glukagon, který srdce stimuluje mimo β -receptor.

42 Sympatomimetika alfa

α_1 = STAHOV CÉVY. Odtud obojí: zvýšení tlaku v šoku i zácpa nosu, která povolí — ale jen na pár dní, pak se vrátí hůř.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Céva

α_1 -agonisté (fenylefrin, noradrenalin, midodrin) stahují cévy, zvyšují periferní odpor a krevní tlak — používají se v šoku, při hypotenzi a k lokální vazokonstrikci.

Nos

Nosní dekongescence (xylometazolin, oxymetazolin, nafazolin) stahují cévy sliznice. ⚠ Jen 5–7 dní — jinak vzniká rhinitis medicamentosa s odrazovým otokem a závislostí na kapkách.

Mozek

α_2 -agonisté (klonidin, methyldopa, brimonidin, dexmedetomidin) působí na PRESYNAPTICKÝ receptor v CNS — tlumí výlev noradrenalinu, a proto tlak SNIŽUJÍ. To je zdánlivý rozpor: agonista, který snižuje tlak.

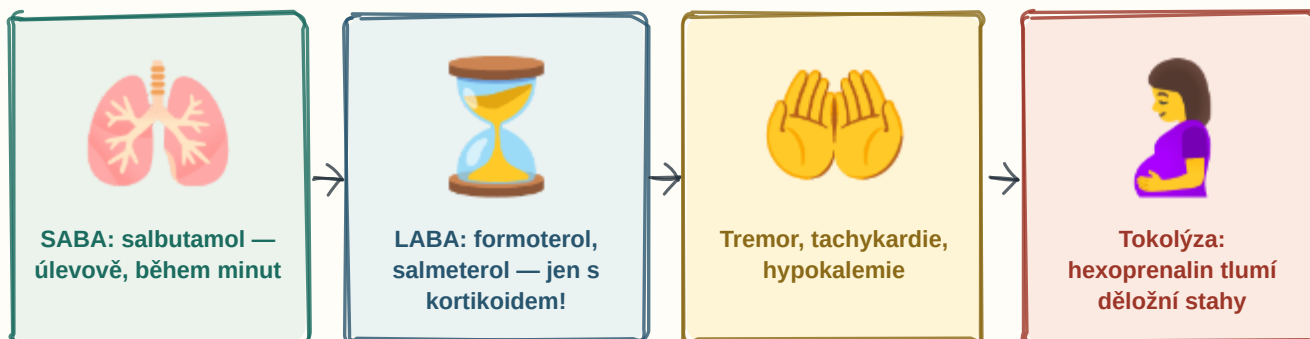
Reflex

Prudký vzestup tlaku vyvolá baroreflexem bradykardii — proto po fenylefrinu srdce zpomalí, ačkoli jde o sympatomimetikum.

⚠ Náhlé vysazení klonidinu vyvolá rebound hypertenzi s tachykardií a pocením — proto se vysazuje postupně.

43 Sympatomimetika beta

β_2 = ROZŠÍŘ BRONCHY. Nežádoucí účinky jsou vždycky stejné trojice: TŘES, TACHYKARDIE, HYPOKALEMIE.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Plíce

β_2 -agonisté relaxují hladký sval bronchu. SABA (salbutamol, fenoterol, terbutalin) působí během minut — úlevová léčba; vysoká spotřeba znamená špatně kontrolované astma.

Přesýpací hodiny

LABA (formoterol, salmeterol, indakaterol) působí 12–24 hodin. ⚠ Nikdy se nepodávají samostatně u astmatu — monoterapie LABA zvyšuje mortalitu; vždy v kombinaci s inhalačním kortikoidem.

Ruce

Tremor (β_2 v kosterním svalu), tachykardie (částečná stimulace β_1 a reflexně), hypokalemie (draslík se přesouvá do buňky) — proto pozor při současné léčbě diuretiky a digoxinem.

Děloha

β_2 -agonisté relaxují dělohu — hexoprenalin se používá k tokolýze při hrozícím předčasném porodu.

β_1 -agonisté

Dobutamin — inotropní podpora u akutního srdečního selhání a kardiogenního šoku.

⚠ β_2 -agonista neléčí zánět, jen uvolní sval — proto astma nikdy nestojí na něm samotném, ale na inhalačním kortikoidu.

44 Nepřímá sympatomimetika

Nepřímé sympatomimetikum na receptor nesedne — VYPLAVÍ noradrenalin ze zásob nebo zablokuje jeho zpětné vychytání. Zásoba se ale vyčerpá.



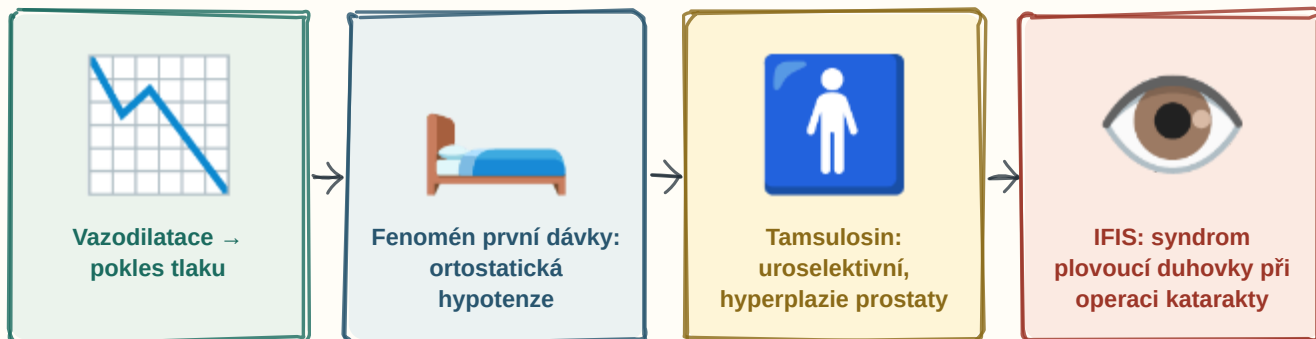
ROZKLÍČOVÁNÍ

Kbelík	Efedrin, pseudoefedrin, amfetamin a metamfetamin obracejí chod transportéru a vyplavují noradrenalin z nervového zakončení.
Zákaz	Kokain, tricyklická antidepresiva a SNRI blokují zpětné vychytávání — mediátor zůstává v synapsi déle.
Blesk	Opakované podání vyčerpá zásobu mediátoru → tachyfylaxe: účinek rychle slábne a zvýšení dávky nepomůže.
Lebka	S inhibitory MAO hrozí hypertenzní krize — MAO nestačí odbourávat vyplavený noradrenalin. Týmž mechanismus má „sýrový efekt“ po potravinách bohatých na tyramin (zrající sýry, uzeniny, červené víno).
Použití	Efedrin a pseudoefedrin jako dekonescencia a při hypotenzi; amfetaminové deriváty terapeuticky u ADHD a narkolepsie, jinak zneužívané.

⚠ Tyramin je nepřímé sympatomimetikum z potravy — normálně ho MAO ve střevě zlikviduje. Při léčbě IMAO se dostane do oběhu a vyplaví noradrenalin náraz.

45 Sympatolytika alfa

α -blokáda uvolní cévy i hrdlo měchýře. Cena za to je PRVNÍ DÁVKA VESTOJE = pád — proto se první tableta bere na noc.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pokles

Blokáda α_1 uvolní hladký sval cév — klesá periferní odpor a tlak. Neselektivní doxazosin a terazosin se používají u hypertenze i u prostaty.

Postel

Fenomén první dávky — prudká ortostatická hypotenze a synkopa; proto se začíná nízkou dávkou na noc.

Prostata

Tamsulosin a silodosin jsou uroselektivní (α_{1A}) — uvolní hladký sval prostaty a hrdla měchýře, tlak ovlivní málo. Nežádoucí je retrográdní ejakulace.

Oko

⚠ IFIS (intraoperative floppy iris syndrome) — před operací katarakty je nutné oftalmologa upozornit na užívání tamsulosinu.

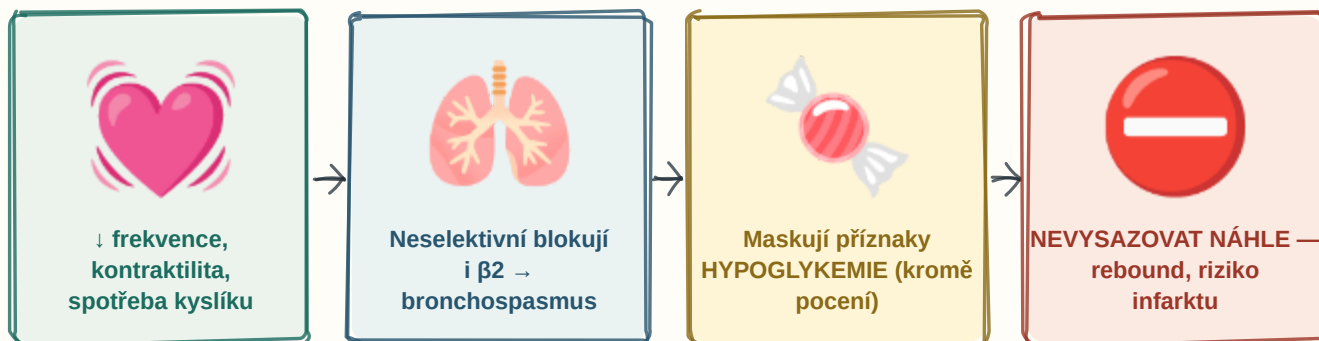
Fenoxybenzamin a fentolamin

Neselektivní α -blokátory používané u feochromocytomu — podávají se před β -blokátorem, jinak by nebrzděná α -stimulace vyvolala hypertenzní krizi.

⚠ U feochromocytomu se nikdy nezačíná β -blokátorem. Nejprve α -blokáda, teprve pak β — jinak zůstane vazokonstrikce bez protiváhy.

46 Sympatolytika beta (betablokátory)

β -blokátor zpomalí a zklidní srdce. Ale nekardioselektivní blokuje i β_2 — a tím STÁHNE BRONCHY. Proto u astmatu pozor.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Srdce

Blokáda β_1 snižuje frekvenci, kontraktilitu, vodivost a spotřebu kyslíku myokardem; snižuje i výlev reninu. Indikace: hypertenze, ischemická choroba, arytmie, srdeční selhání (bisoprolol, karvedilol, metoprolol), tyreotoxikóza, tremor, migréna, glaukom.

Plíce

Neselektivní (propranolol, sotalol) blokují i β_2 — bronchospasmus a periferní vazokonstrikce. Kardioselektivní (bisoprolol, metoprolol, atenolol, nebivolol) jsou bezpečnější, ale selektivita ve vysoké dávce mizí.

Cukr

U diabetika maskují varovné příznaky hypoglykémie (tachykardii, třes) — pocení zůstává; a zpomalují úpravu glykémie.

Zákaz náhlého vysazení

Při dlouhé blokádě dojde k up-regulaci receptorů; náhlé vysazení vyvolá rebound tachykardii, hypertenzi a může vyprovokovat anginu nebo infarkt. Vysazuje se postupně.

Zvláštní

Karvedilol a labetalol blokují i α_1 . Sotalol má navíc antiarytmický účinek III. třídy. Nebivolol uvolňuje oxid dusnatý.

⚠ ⚠ Kombinace β -blokátoru s verapamilem nebo diltiazemem hrozí těžkou bradykardií a AV blokádou — obě skupiny tlumí převodní systém.

47 Myorelaxancia

DEPOLARIZUJÍCÍ nejprve SVAL ROZKMITÁ (fascikulace) a pak ochrne — a dekurarizovat se NEDÁ. Nedepolarizující se zvrátit dá.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Fascikulace

Succinylcholin je depolarizující — chová se jako acetylcholin, který se nerozkládá; nejprve receptor trvale aktivuje (viditelné záškuby), pak nastane blokáda. Působí 5–10 minut, štěpí ho plazmatická cholinesteráza.

Kompetice

Nedepolarizující (rokuronium, vekuronium, atrakurium, cisatracurium) jsou kompetitivní antagonisté nikotinového receptoru na ploténce — sval ochrne bez fascikulací.

Zvrat

Nedepolarizující blok lze zvrátit neostigmimem (zvýší acetylcholin) nebo u rokuronia specificky sugammadexem. ⚠ Depolarizující blok zvrátit nelze — neostigmin by ho prohloubil.

Oheň

Maligní hypertermie — vzácná geneticky podmíněná reakce na succinylcholin a inhalační anestetika: prudký vzestup teploty, rigidita, acidóza. Antidotem je DANTROLEN.

Další rizika succinylcholinu

Hyperkalemie (nebezpečná u popálenin, polytraumat a neuromuskulárních chorob), bolest svalů, vzestup nitroočního tlaku, prodloužená apnoe při atypické pseudocholinesteráze.

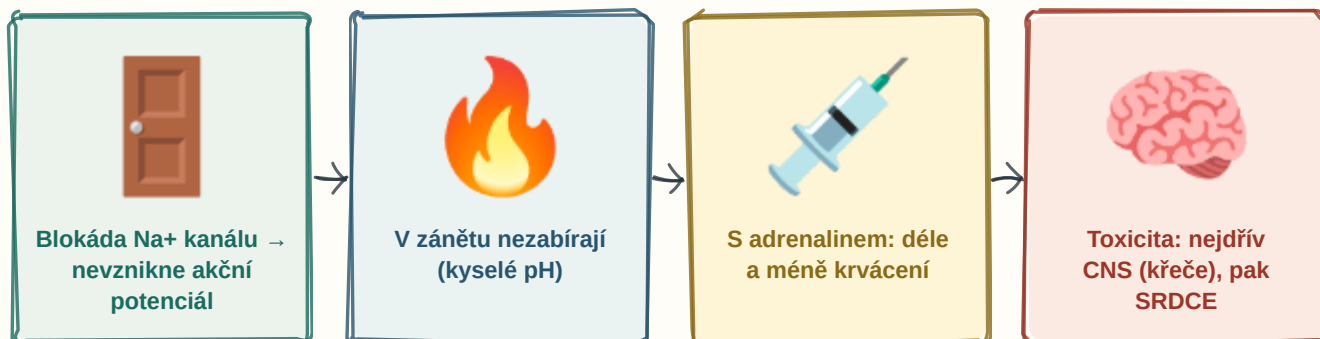
Centrální myorelaxancia

Baklofen (agonista GABA-B), tizanidin, tolperison — na spasticitu, nikoli k anestezii.

⚠ Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest — pacient musí být zároveň uspán a analgetizován, jinak je ochrnutý při vědomí.

48 Lokální anestetika

Blokují SODÍKOVÝ KANÁL zevnitř. V zánětu (kyselé pH) převáží nabitá forma, která dovnitř neprojde — proto tam nezabírají.



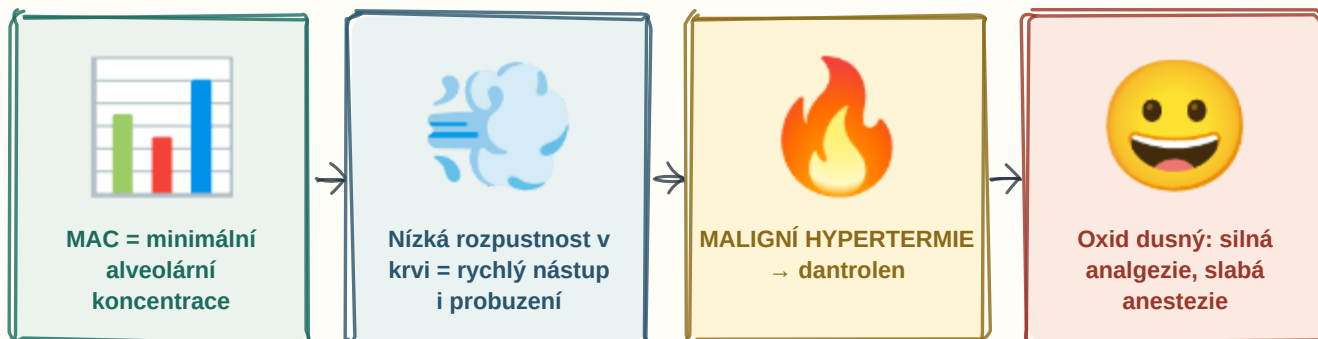
ROZKLÍČOVÁNÍ

Kanál	Vážou se zevnitř na napěťově řízený sodíkový kanál a brání vzniku a šíření akčního potenciálu. Nejdřív vypadne bolest a teplo, pak dotek, nakonec motorika (tenká nemyelinizovaná vlákna první).
Zánět	Anestetikum je slabá zásada; v kyselém prostředí zánětu převáží ionizovaná forma, která neprojde membránou k místu účinku uvnitř kanálu — proto se v zaníceném terénu často nepodaří umrtvit.
Adrenalin	Vazokonstrikce zpomalí vstřebávání: prodlouží účinek, sníží krvácení a systémovou toxicitu. ⚠ Nepodává se do akrálních částí (prsty, nos, ucho) — riziko ischemie.
Toxicita	Systémová toxicita začíná v CNS: kovová chuť, brnění kolem úst, hučení, závrať, křeče — a teprve pak přijde kardiotoxicita (arytmie, zástava). Bupivakain je nejekardiotoxičtější; léčbou je lipidová emulze.
Skupiny	Estery (prokain, benzokain, tetrakain) — štěpí je plazmatické esterázy, častější alergie (metabolit PABA). Amidy (lidokain, mepivakain, artikain, bupivakain, prilokain) — metabolizují se v játrech, alergie vzácná.

⚠ Prilokain a benzokain mohou vyvolat methemoglobinemii (antidotem je methylenová modř). Lidokain je zároveň antiarytmikum třídy Ib.

49 Celková anestetika — inhalační

MAC je „dávka“ inhalačního anestetika: koncentrace, při níž se polovina pacientů nepohne. Čím NIŽŠÍ MAC, tím SILNĚJŠÍ látka.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Graf

MAC — koncentrace, při níž se 50 % pacientů nepohne po kožním řezu; je mírou potence. Nízké MAC = vysoká potence. MAC klesá s věkem, v graviditě a při současném podání opioidů.

Pára

Rychlost nástupu určuje rozpustnost v krvi (koeficient krev/plyn): čím je nižší, tím rychleji stoupá alveolární koncentrace a tím rychlejší je nástup i probuzení. Desfluran a sevofluran nastupují rychle, halothan pomalu.

Oheň

⚠ Halogenovaná anestetika (sevofluran, desfluran, isofluran) mohou spolu se succinylcholinem vyvolat malignitní hypertermii — antidotem je dantrolen. Halothan navíc hepatotoxicitu.

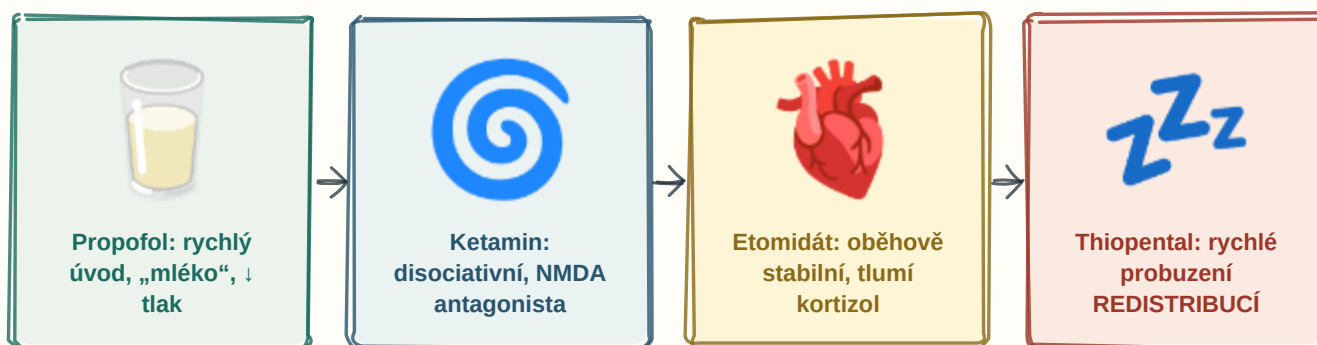
Rajský plyn

Oxid dusný (N₂O) má výbornou analgezii, ale slabý anestetický účinek — používá se jako doplněk. Inaktivuje vitamin B12 (megaloblastová anémie a neuropatie při dlouhé expozici) a difunduje do uzavřených dutin.

⚠ Inhalační anestetika snižují krevní tlak a tlumí dýchání; sevofluran je pro dobrou snášenlivost dýchacími cestami vhodný k úvodu do anestezie u dětí.

50 Celková anestetika — intravenózní

PROPOFOL uspí i probudí rychle. **KETAMIN** je výjimka ze všech pravidel: tlak a dech **NEKLESAJÍ**, analgezie je silná — ale probouzí se z něj s halucinacemi.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Propofol

Nejužívanější — rychlý nástup i odeznění, antiemetický účinek. Nežádoucí: pokles krevního tlaku, útlum dechu, bolest při injekci; při dlouhé vysokodávkované infuzi propofolový infuzní syndrom.

Ketamin

Antagonista NMDA receptoru; vyvolá disociativní anestezii se silnou analgezií. ⚠ Na rozdíl od ostatních neklesá krevní tlak (stoupá) ani dechová aktivita — proto se hodí v šoku a v přednemocniční péči. Nežádoucí jsou halucinace a neklid při probouzení (tlumí je benzodiazepin). Esketamin se používá u farmakorezistentní deprese.

Etomidát

Oběhově velmi stabilní — vhodný u kardiaka; tlumí ale syntézu kortizolu v nadledvině, proto se nepodává v infuzi.

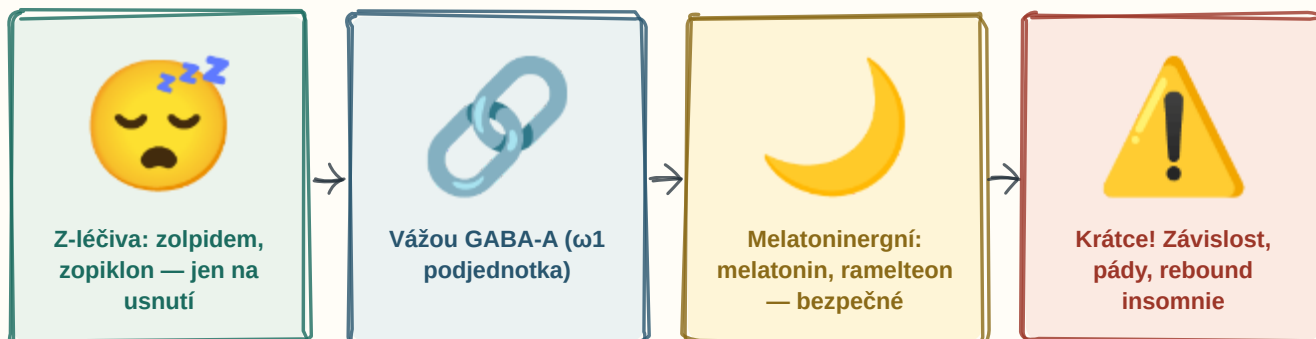
Thiopental

Barbiturát; účinek končí **REDISTRIBUCÍ** do svalů a tuku, nikoli eliminací — proto se pacient probudí rychle, ale látka v těle přetrvává a při opakovaném podání se kumuluje.

⚠ Anestezie se v praxi vede kombinací: hypnotikum + analgetikum (opioid) + myorelaxans. Jedna látka nezvládne všechny tři složky současně.

51 Hypnotika

Z-hypnotika i benzodiazepiny sedají na TÝŽ GABA-A receptor — proto mají stejná rizika: pády, závislost, rebound nespavost.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Spánek

Z-hypnotika (zolpidem, zopiklon, zaleplon) zkracují dobu usnutí; mají krátký poločas, takže ráno méně tlumí než benzodiazepiny. Nežádoucí: amnézie, parasomnie (jízda a jedení ve spánku), pády u seniorů.

Receptor

Vážou se selektivně na $\omega 1$ podjednotku GABA-A receptoru — proto působí hypnoticky, ale mnohem méně anxiolyticky, myorelaxačně a antikonvulzivně než benzodiazepiny. Antidotem je flumazenil.

Měsíc

Melatonin a agonisté melatoninových receptorů upravují cirkadiánní rytmus; jsou bezpečné, nenávykové, ale slabší. Antihistaminika I. generace (prometazin, difenhydramin) sedují za cenu anticholinergních účinků.

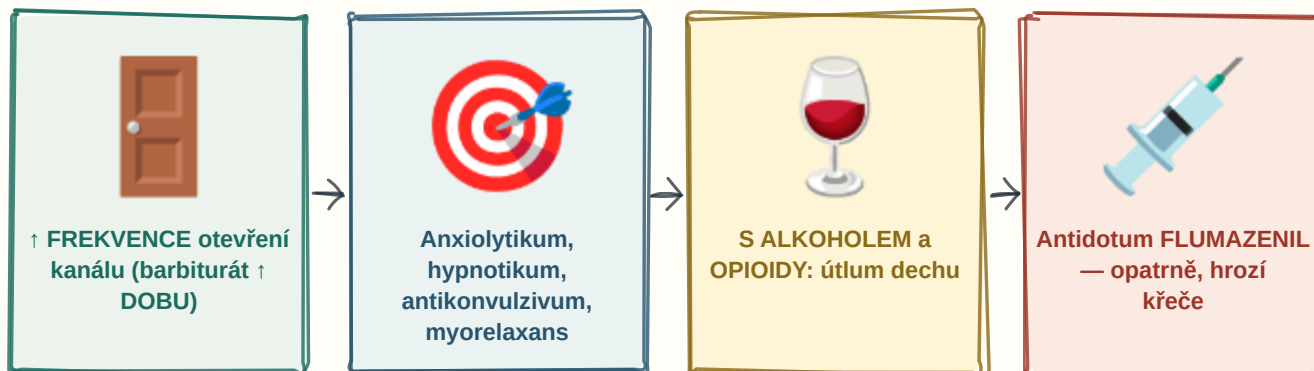
Varování

Podávat co nejkratší dobu; po vysazení hrozí rebound nespavost. Základem léčby nespavosti je spánková hygiena a kognitivně-behaviorální terapie, ne tableta.

⚠ Barbituráty se dnes jako hypnotika nepoužívají — mají úzké terapeutické okno, prohlubují útlum dechu bez stropu a silně indukují CYP450.

52 Benzodiazepiny

Benzodiazepin ZVÝŠÍ FREKVENCI otevírání chloridového kanálu — ale jen tam, kde už GABA je. Proto má strop a sám o sobě nezabíjí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kanál

Benzodiazepiny se vážou na alosterické místo GABA-A receptoru a zvyšují FREKVENCI otevírání chloridového kanálu; barbituráty zvyšují DOBU otevření a ve vysoké dávce kanál otevřou i bez GABA — proto nemají strop a jsou nebezpečnější.

Čtyři účinky

Anxiolytický, hypnotický, antikonvulzivní (lék volby u status epilepticus — diazepam, midazolam) a centrálně myorelaxační; dále anterográdní amnézie (využívá se při výkonech).

Alkohol

⚠ Samotný benzodiazepin dech tlumí málo, ale v kombinaci s alkoholem, opioidy nebo Z-léčivými hrozí smrtelný útlum dechu — to je nejčastější příčina úmrtí.

Flumazenil

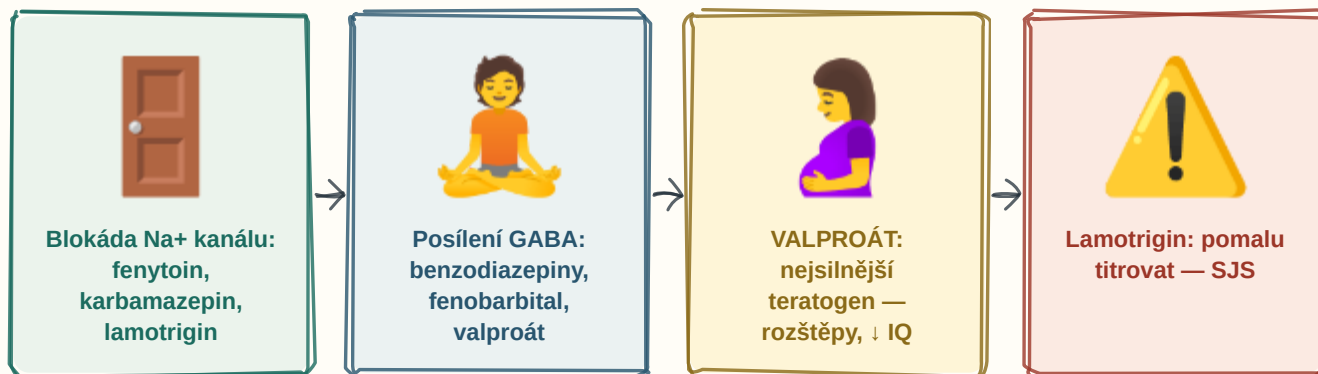
Kompetitivní antagonist; u chronického uživatele nebo při smíšené intoxikaci s tricykly může vyvolat křeče, proto se podává uvážlivě.

Zástupci

Krátce působící midazolam · středně alprazolam, oxazepam, lorazepam (u jatrní léze — jen konjugace) · dlouze diazepam, klonazepam. Odvykací stav je nebezpečný (křeče, delirium) — vysazuje se pomalu.

⚠ U seniorů se preferují krátkodobě působící a jen krátce — dlouhodobě působící benzodiazepiny jsou na seznamu nevhodných léčiv (pády, zmatenost, zlomeniny krčku).

Antiepileptikum brzdí nadměrné výboje: zavře SODÍKOVÝ kanál, nebo posílí GABA. A skoro všechna jsou TERATOGENNÍ — hlavně valproát.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kanál	Blokáda napětově řízených sodíkových kanálů brzdí opakované výboje — fenytoin (saturační kinetika, gingivální hyperplazie, hirsutismus), karbamazepin (indukce CYP450, hyponatremie, agranulocytóza), lamotigin, lakosamid.
Klid	Posílení GABA — benzodiazepiny, fenobarbital, valproát, tiagabin, vigabatrin. Ethosuximid blokuje kalciové kanály typu T a je lékem volby u absencí.
Gravidita	⚠ Valproát je nejsilnější teratogen mezi antiepileptiky (rozštěpy neurální trubice, poruchy vývoje a snížení IQ) — u žen ve fertilním věku se podává jen výjimečně a se spolehlivou kontracepcí. Podává se kyselina listová.
Vyrážka	Lamotigin se musí titrovat velmi pomalu — jinak hrozí Stevensův–Johnsonův syndrom; riziko roste při současném valproátu, který jeho hladinu zvyšuje.
Status epilepticus	Lékem první volby je benzodiazepin (diazepam, midazolam, lorazepam), dále fenytoin nebo valproát nitrožilně.

⚠ Karbamazepin je silný induktor CYP450 — sníží účinnost hormonální kontracepce, warfarinu a mnoha dalších léčiv. Valproát je naopak inhibitor.

54 Antiparkinsonika

V parkinsonském mozku **CHYBÍ DOPAMIN** a převládá acetylcholin. Dopamin sám se podat nedá — neprojde do mozku, proto se dává **LEVODOPA**.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Bariéra

Dopamin neprochází hematoencefalickou bariérou; levodopa ano a v mozku se dekarboxyluje na dopamin.

Štít

Kombinuje se s inhibitory periferní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid) — jinak by se rozložila v těle a způsobila nauzeu, zvracení a hypotenzi. Dále inhibitory COMT (entakapon) a MAO-B (selegilin, rasagilin), které prodlouží její účinek.

Horská dráha

Po několika letech léčby se objevuje kolísání účinku (wearing-off, on-off fenomén) a polékové dyskineze — proto se u mladších začíná agonisty dopaminu a levodopa se oddaluje.

Agonisté

Pramipexol, ropinirol, rotigotin. ⚠ Typickým nežádoucím účinkem jsou poruchy impulzivního chování (hráčství, nakupování, hypersexualita) a náhlé usnutí — na to je nutné pacienta upozornit.

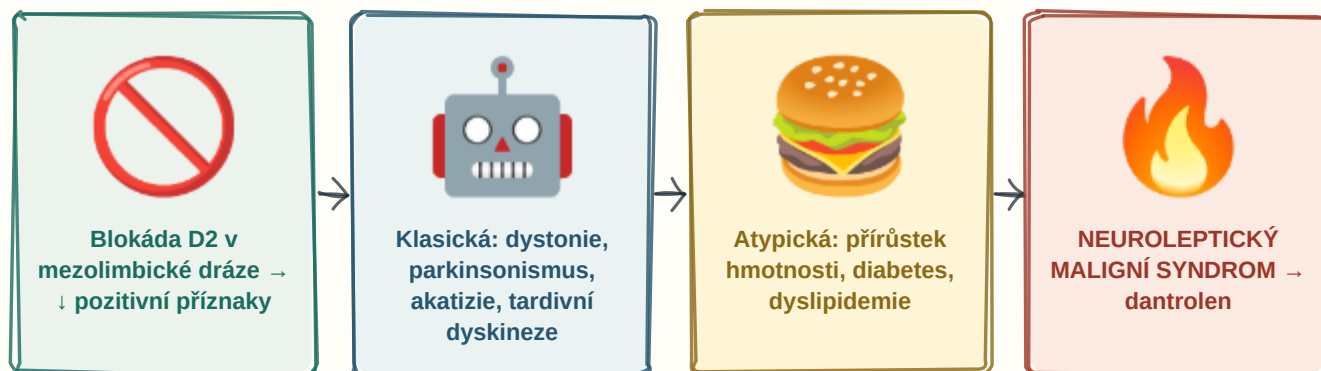
Anticholinergika

Biperiden — pomáhá hlavně na třes, ale u starších působí zmatenost. Amantadin tlumí dyskineze.

⚠ Antipsychotika blokující D2 receptory vyvolají polékový parkinsonský syndrom — a naopak levodopa může u disponovaných vyvolat psychózu. Metoklopramid ze stejného důvodu u parkinsonika nepodávat.

55 Neuroleptika (antipsychotika)

Klasická blokují D2 tvrdě → EXTRAPYRAMIDOVÉ nežádoucí účinky. Atypická blokují i 5-HT_{2A} → méně hybných potíží, zato METABOLICKÝ syndrom.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Blokáda

Účinek na pozitivní příznaky (halucinace, bludy) plyne z blokády D₂ v mezolimbické dráze; blokáda v nigrostriatální dráze působí hybné potíže a v tuberoinfundibulární hyperprolaktinemii (galaktorea, amenorea, gynekomastie).

Robot

Extrapyramidové projevy klasických (haloperidol, flufenazin, chlorpromazin): akutní dystonie (hodiny až dny), parkinsonský syndrom, akatizie (neklid) a po letech tardivní dyskineze, která bývá nevratná.

Metabolika

Atypická (olanzapin, klozapin, risperidon, kvetiapin, aripiprazol) blokují navíc 5-HT_{2A} — méně hybných potíží, ale přírůstek hmotnosti, diabetes 2. typu a dyslipidemie. ⚠ Klozapin působí AGRANULOCYTÓZU — nutné pravidelné kontroly krevního obrazu; je vyhrazen farmakorezistentní schizofrenii.

Oheň

Neuroleptický maligní syndrom — horečka, svalová rigidita, porucha vědomí, vzestup kreatinkinázy. Léčba: vysadit neuroleptikum, dantrolen, bromokriptin, podpůrná péče.

Další

Prodloužení QT (zvláště haloperidol, ziprasidon), sedace, ortostatická hypotenze, anticholinergní účinky.

⚠ Negativní příznaky (oploštění, apatie) reagují na léčbu podstatně hůř než pozitivní — a klasická neuroleptika je mohou dokonce zhoršit.

56 Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

Tricyklicka fungují, ale treťí se do všeho: do histaminu (sedace), do muskarinu (sucho, retence) i do α_1 (pády). A při předávkování ZABÍJEJÍ.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Terč

Tricyklicka (amitriptylin, klomipramin, imipramin, nortriptylin) blokují zpětné vychytávání noradrenalinu i serotoninu — účinná, ale málo selektivní.

Poušť

Blokují navíc muskarinové receptory (sucho v ústech, rozmazané vidění, zácpa, retence moči, u seniorů zmatenost), H1 (sedace, přírůstek hmotnosti) a α_1 (ortostatická hypotenze, pády).

Srdce

⚠ Při předávkování působí bloádou sodíkových kanálů arytmie, rozšíření QRS, křeče a kóma — proto se u suicidálního pacienta nepředepisují ve velkém balení. Dnes se používají spíš u neuropatické bolesti a v profylaxi migrény.

Sýr

Ireverzibilní neselektivní IMAO (tranylcypromin) — při požití potravin bohatých na tyramin (zrající sýry, uzeniny, červené víno) hrozí hypertenzní krize. Moklobemid je reverzibilní selektivní inhibitor MAO-A, a proto podstatně bezpečnější.

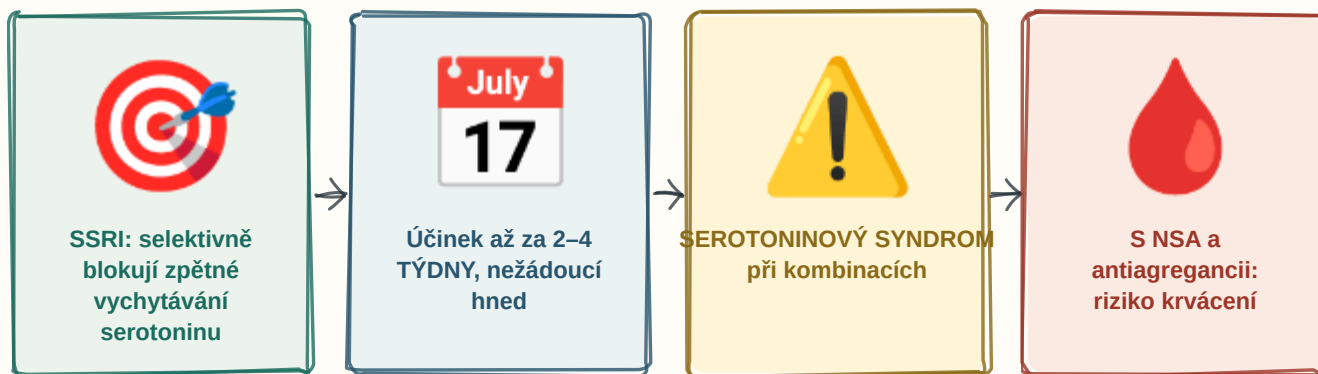
Serotoninový syndrom

⚠ Kombinace IMAO s SSRI, tramadolem nebo triptany — horečka, rigidita, myoklonus, neklid; mezi IMAO a SSRI je nutná několikátýdenní pauza.

⚠ Antidepresivní účinek nastupuje až za 2–4 týdny, zatímco nežádoucí účinky hned první den — to je nejčastější důvod, proč pacient léčbu předčasně ukončí.

57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

SSRI jsou dnes první volbou ne proto, že by byla účinnější, ale protože jsou **BEZPEČNĚJŠÍ** — hlavně při předávkování.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Terč

SSRI (sertralin, escitalopram, citalopram, fluoxetin, paroxetin, fluvoxamin) blokují serotoninový transportér. Nežádoucí: nauzea, nespavost nebo útlum, sexuální dysfunkce (velmi častá), hyponatremie u seniorů, na začátku zvýšení úzkosti.

Kalendář

Nástup účinku 2–4 týdny; na začátku léčby může přechodně stoupnout riziko sebevražedného jednání u mladých — proto se první týdny sleduje častěji.

Serotoninový syndrom

⚠️ Při kombinaci s IMAO, tramadolem, triptany, linezolidem nebo třezalkou: horečka, rigidita, myoklonus, průjem, neklid až kóma.

Krvácení

SSRI snižují vychytávání serotoninu i do destiček — spolu s NSA nebo antiagregancii roste riziko krvácení do trávicího traktu.

SNRI a atypická

Venlafaxin a duloxetin (serotonin + noradrenalin; duloxetin i u diabetické neuropatie) · mirtazapin (sedativní, zvyšuje chuť k jídlu — vhodný u nespavosti a kachexie) · bupropion (dopamin a noradrenalin, snižuje práh křečí, pomáhá při odvykání kouření) · trazodon · agomelatin. ⚠️ Fluoxetin a paroxetin jsou silné inhibitory CYP2D6 — sníží účinek kodeinu a tamoxifenu.

⚠️ SSRI se nevysazují náhle (kromě fluoxetinu s dlouhým poločasem) — hrozí syndrom z vysazení: závratě, „elektrické šoky“, úzkost, chřipkovité příznaky.

58 Anxiolytika, stabilizátory nálady

LITHIUM má tak úzké terapeutické okno, že se hladiny **MĚŘÍ POVINNĚ** — a dehydratace, NSA nebo ACE inhibitor ho vyženou do toxicity.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pravítko

Lithium se používá u bipolární afektivní poruchy — jako jediné prokazatelně snižuje riziko sebevraždy. Terapeutické rozmezí je velmi úzké, proto se hladiny sledují pravidelně.

Voda

Vylučuje se výhradně ledvinami a soupeří se sodíkem — při dehydrataci, zvracení, průjmu, dietě s omezením soli a při současném podání NSA, thiazidů nebo ACE inhibitorů hladina prudce stoupá. Intoxikace: třes, zvracení, ataxie, zmatenost, křeče.

Motýl

Dlouhodobě působí hypotyreózu (sledovat TSH), nefrogenní diabetes insipidus s polyurií a žízní, tremor, přírůstek hmotnosti. ⚠ Je teratogenní (Ebsteinova anomálie).

Alternativy

Valproát (u mánie, ⚠ teratogenní), lamotrigin (spíš na depresivní fázi), karbamazepin, atypická antipsychotika (kvetiapin, olanzapin, aripiprazol).

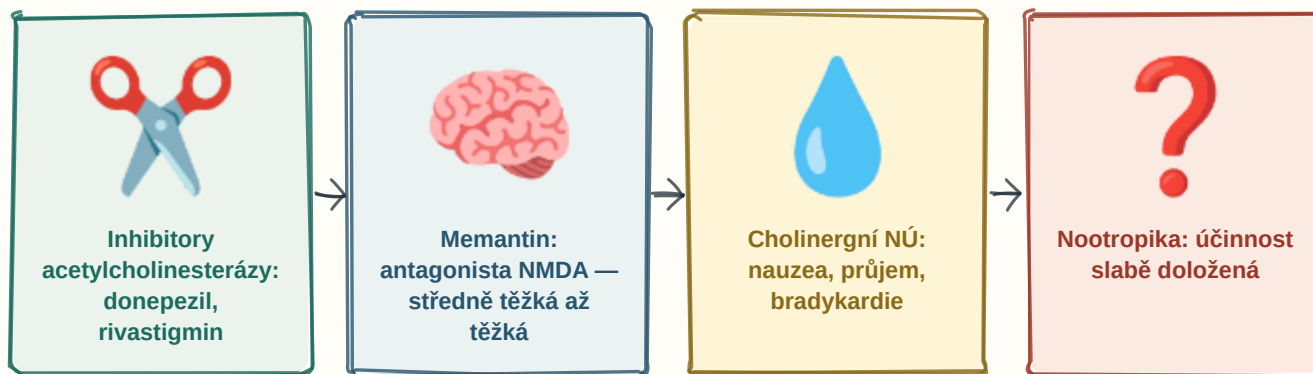
Anxiolytika

Benzodiazepiny jen krátkodobě · buspiron (agonista 5-HT_{1A}, nenávykový, ale pomalý nástup) · hydroxyzin · pro dlouhodobou léčbu úzkostných poruch jsou lékem volby SSRI a SNRI, ne benzodiazepiny.

⚠ U bipolární poruchy se antidepressivum nikdy nepodává samo — může přesmyknout pacienta do mánie; podává se pod clonou stabilizátoru nálady.

59 Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

Léčba Alzheimerovy choroby nemoc NEZASTAVÍ — jen na čas zmírní příznaky. Chybí acetylcholin, tak se brzdí jeho rozklad.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nůžky

Donepezil, rivastigmin a galantamin zvyšují množství acetylcholinu v CNS; jsou indikovány u lehké až středně těžké formy. Zlepší kognici a soběstačnost dočasně, progresi nezastaví.

Mozek

Memantin je antagonist NMDA receptoru — chrání před excitotoxicitou glutamátu; používá se u středně těžké až těžké formy, lze kombinovat.

Kapka

Nežádoucí účinky vyplývají z cholinergní stimulace: nauzea, zvracení, průjem, nechutenství, bradykardie a synkopy (opatrnost u poruch vedení), noční můry, svalové křeče.

Otazník

Nootropika (piracetam, ginkgo biloba, extrakty) mají důkazy o účinnosti slabé; nenahrazují výše uvedenou léčbu.

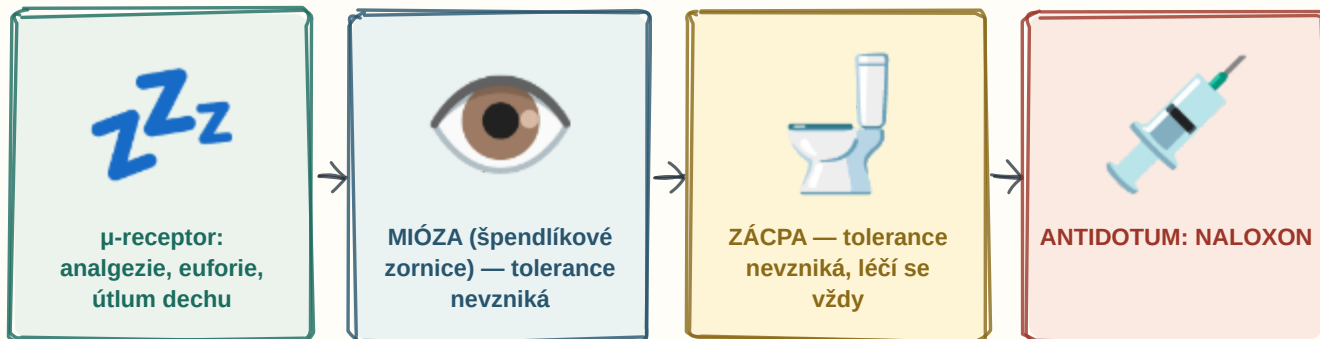
Nefarmakologicky

Kognitivní trénink, pohyb, léčba přidružených chorob a úprava prostředí; u poruch chování se antipsychotika podávají jen krátce a v nízké dávce — ⚠ u demence zvyšují mortalitu a riziko cévní mozkové příhody.

⚠ Anticholinergní léčiva (antihistaminika I. generace, tricyklicka, oxybutynin) kognici u demence zhoršují — působí přesně proti nasazené léčbě.

60 Opium a jeho alkaloidy

MORFIN má jednu vlastnost, která ho dělá nebezpečným: tolerance na euforii a útlum dechu roste rychle, ale na ZÁCPU a MIÓZU prakticky vůbec.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Útlum

Morfin je agonista μ -opioidních receptorů: silná analgezie, euforie, sedace, útlum kašle — a útlum dechového centra, který je hlavní příčinou smrti při předávkování.

Zornice

Mióza je klíčovým příznakem otravy a na rozdíl od ostatních účinků na ni nevzniká tolerance; triáda otravy je útlum vědomí + útlum dechu + mióza.

Zácpa

Vzniká zpomalením peristaltiky přes periferní μ -receptory; tolerance na ni prakticky nevzniká, proto se laxativum podává profylakticky po celou dobu léčby opioidem.

Naloxon

Kompetitivní antagonist; působí krátce, proto je nutné opakované podání a sledování — jinak se útlum dechu vrátí. U závislého vyvolá odvykací stav.

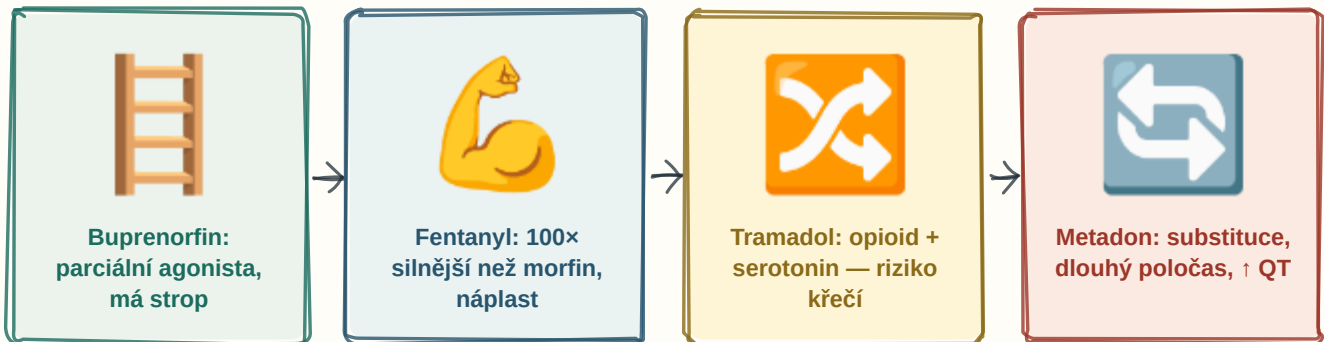
Další alkaloidy opia

Kodein (proléčivo, CYP2D6 → morfin; antitusikum), papaverin (myotropní spasmolytikum, není analgetikum), thebain (výchozí látka pro polosyntetické opioidy).

⚠ Další nežádoucí účinky: nauzea a zvracení (stimulace area postrema), retence moči, svědění a uvolnění histaminu, biliární spasmus. U bolesti při kolice se proto morfin kombinuje se spasmolytikem.

61 Deriváty a náhražky morfinu

Parciální agonista (BUPRENORFIN) má STROP — víc už nepřidá. A když ho dáš na plného agonistu, VYTLAČÍ ho a vyvolá odvykací stav.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Žebřík

Buprenorfin je parciální agonista μ — má stropový efekt (bezpečnější útlum dechu), ale vysokou afinitu; podaný na plného agonistu ho vytěsňuje a vyvolá odvykací stav. Používá se v substituční léčbě a transdermálně u chronické bolesti.

Síla

Fentanyl je asi 100× potentnější než morfin — transdermální náplast u chronické nádorové bolesti, i.v. v anestezii. Sufentanil a remifentanil jsou ještě silnější a kratší.

Tramadol

Slabý opioidní agonista, který navíc blokuje zpětné vychytávání serotoninu a noradrenalinu. ⚠ Snižuje práh křečí a s SSRI hrozí serotoninový syndrom; je proléčivo aktivované CYP2D6.

Metadon

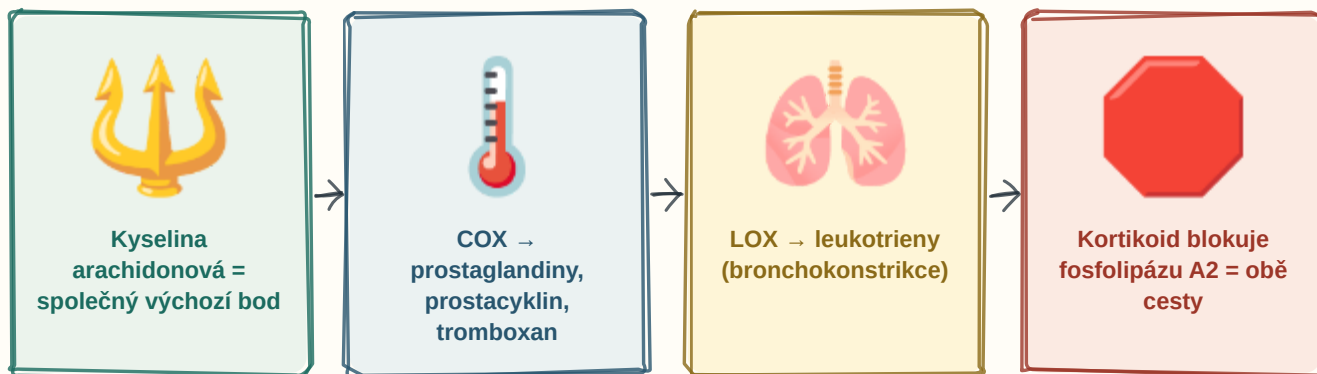
Dlouhý a proměnlivý poločas — vhodný k substituci u závislosti, ale hrozí kumulace a prodloužení QT.

Další

Piritramid, oxykodon (často s naloxonem proti zácpě), hydromorfon, pethidin (metabolit norpethidin je neurotoxický — dnes se nedoporučuje), nalbufin a pentazocin (agonisté-antagonisté).

⚠ Naltrexon je dlouhodobě působící antagonist a užívá se v udržovací léčbě závislosti (i na alkoholu); naloxon slouží akutně při předávkování.

Z kyseliny arachidonové vedou DVĚ cesty: COX dělá prostaglandiny, LOX leukotrieny. Kortikoid zavře OBĚ, NSA jen tu první.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Rozcestí

Fosfolipáza A2 uvolní z membrány kyselinu arachidonovou; z ní vycházejí dvě větve.

COX

Cyklooxygenáza tvoří prostaglandiny (zánět, bolest, horečka, ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinami), prostacyklin PGI₂ (vazodilatace, brzdí agregaci — z endotelu) a tromboxan TXA₂ (vazokonstrikce, podporuje agregaci — z destiček). COX-1 je konstitutivní (ochranná), COX-2 indukovaná zánětem.

LOX

Lipoxygenáza tvoří leukotrieny — silná bronchokonstrikce, zvýšená propustnost cév a chemotaxe; odtud montelukast u astmatu.

Kortikoid

Glukokortikoidy inhibují fosfolipázu A2 (přes lipokortin), a tím zavřou obě větve — proto jsou protizánětlivě účinnější než NSA.

Léčebné využití

Misoprostol (analog PGE₁ — ochrana žaludku, ⚠ kontraindikován v graviditě), latanoprost (glaukom), alprostadil, dinoprost (indukce porodu), epoprostenol (plicní hypertenze).

⚠ Aspirinem indukované astma vzniká právě tady: zablokovaná COX odkloní kyselinu arachidonovou do LOX větve a vzniká nadbytek leukotrienů.

63 Analgetika-antipyretika

PARACETAMOL v terapeutické dávce nedráždí žaludek a neruší srážení — ale při předávkování ZNIČÍ JÁTRA. Hranice je blíž, než se čeká.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Teploměr

Paracetamol působí centrálně (COX v CNS) — analgeticky a antipyreticky; protizánětlivý účinek prakticky nemá, na rozdíl od NSA.

Bezpečnost

Nedráždí žaludeční sliznici, neovlivňuje agregaci destiček a nezhoršuje astma — proto je analgetikem první volby v graviditě, u dětí a u pacientů s vředovou chorobou.

Lebka

Při vyčerpání glutathionu se hromadí toxický metabolit NAPQI a vzniká centrolobulární jaterní nekróza. ⚠ Riziko stoupá u chronického alkoholika, malnutrice a při hladovění; potíže se objeví se zpožděním 1–2 dnů, kdy už může být poškození nevratné.

Antidotum

N-acetylcystein doplní glutathion; účinný je zvláště v prvních hodinách, proto se podává i při pouhém podezření podle nomogramu.

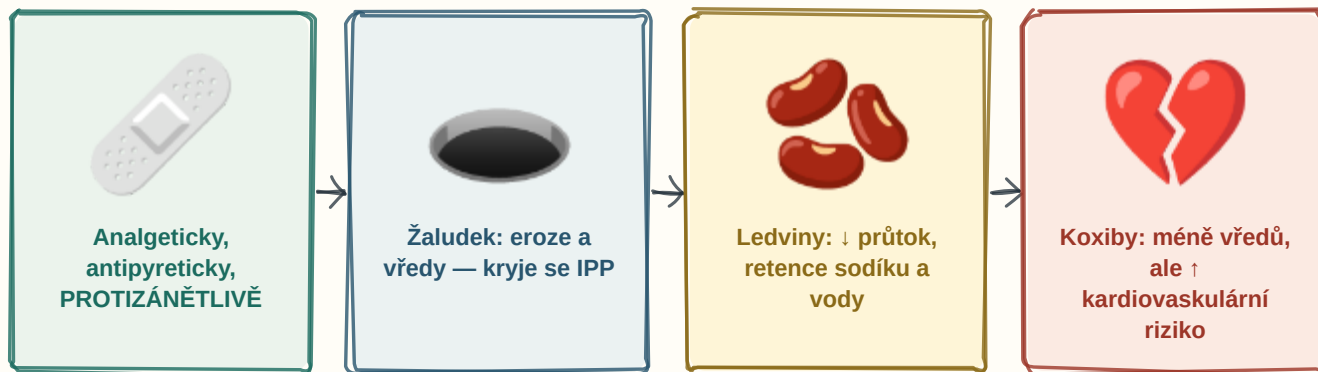
Metamizol

Silné analgetikum se spasmolytickým účinkem (vhodné u kolik). ⚠ Riziko agranulocytózy a hypotenze při rychlém nitrožilním podání.

⚠ Paracetamol je v mnoha kombinovaných přípravcích proti chřipce — pacient si tak snadno nevědomky podá dvojnásobnou denní dávku. Na to se ptej cíleně.

64 Nesteroidní antiflogistika

NSA škodí třemi cestami zároveň: ŽALUDEK (ubude ochranný prostaglandin), LEDVINY (klesne průtok) a SRDCE (roste tlak a riziko příhody).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Účinek

Inhibice COX snižuje tvorbu prostaglandinů — odtud analgezie, antipyreze a protizánětlivý účinek (na rozdíl od paracetamolu).

Vřed

COX-1 tvoří prostaglandiny chránící žaludeční sliznici; jejich úbytek vede k erozím a vředům, které mohou krvácet bez varovné bolesti. U rizikových se přidává inhibitor protonové pumpy.

Ledvina

Prostaglandiny udržují průtok ledvinou; NSA ho snižují — retence sodíku a vody, otoky, vzestup tlaku, zhoršení srdečního selhání a riziko akutního poškození ledvin (zvláště v „trojkombinaci“ s ACE inhibitorem a diuretikem).

Srdce

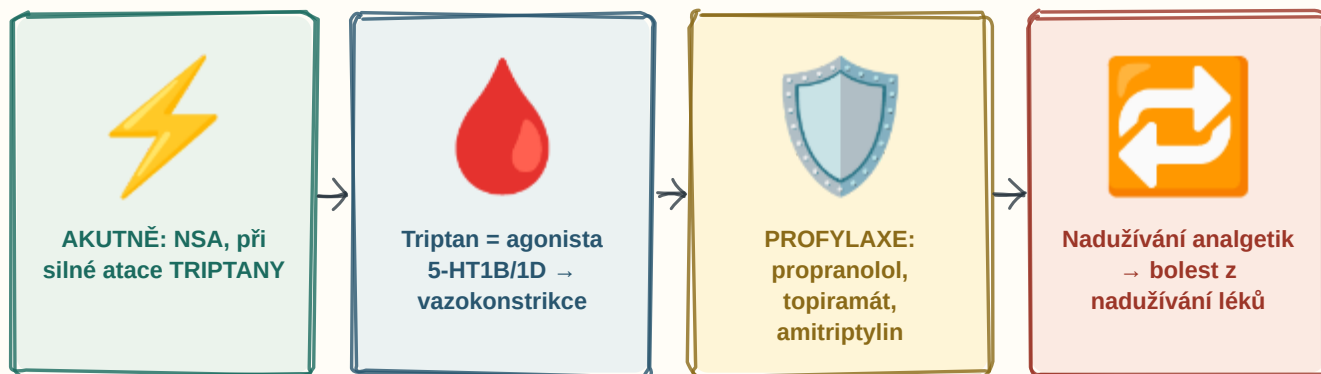
Selektivní inhibitory COX-2 (koxiby) šetří žaludek, ale zvyšují riziko trombotických příhod. Naproxen má z NSA nejnižší kardiovaskulární riziko.

Další

Aspirinem indukované astma, alergie, u dětí s virózou Reyeův syndrom po kyselině acetylsalicylové, ⚠ v třetím trimestru předčasný uzávěr ductus arteriosus. Ibuprofen ruší antiagregační účinek nízkodávkovaného aspirinu, pokud se podá před ním.

⚠ Nízká dávka kyseliny acetylsalicylové (75–100 mg) blokuje COX-1 v destičkách NEVRATNĚ na celou jejich životnost (7–10 dní) — proto působí antiagregačně, ne protizánětlivě.

Migréna má dvě zcela oddělené léčby: **AKUTNÍ záchvat (triptany)** a **PROFYLAXE (β -blokátor, topiramát)**. Záměna je klasická chyba.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Blesk

Lehký záchvat: NSA (ibuprofen, kyselina acetylsalicylová) nebo paracetamol, nejlépe co nejdříve a s prokinetikem (metoklopramid) proti zvracení a zpomalenému vyprazdňování žaludku.

Céva

Triptany (sumatriptan, eletriptan, zolmitriptan) jsou agonisté 5-HT_{1B/1D} — stahují rozšířené intrakraniální cévy a tlumí uvolňování neuropeptidů. ⚠ Kontraindikace: ischemická choroba srdeční, neléčená hypertenze, prodělaná cévní mozková příhoda, hemiplegická migréna. S SSRI hrozí serotoninový syndrom.

Štít

Profylaxe se nasazuje při častých nebo těžkých atakách: β -blokátoři (propranolol, metoprolol), topiramát, valproát (⚠ ne u žen ve fertilním věku), amitriptylin, kandesartan; nově monoklonální protilátky proti CGRP (erenumab) a gepanty.

Kruh

Bolest hlavy z nadužívání léků vzniká při užívání analgetik více než ~10–15 dní v měsíci — léčí se vysazením, ne přidáním.

Ergotamin

Dnes okrajově — silná a dlouhá vazokonstrikce, riziko ergotismu; nikdy se nekombinuje s triptanem.

⚠ Triptan není analgetikum a nefunguje na tenzní bolest hlavy; naopak profylaktikum neuleví od probíhajícího záchvatu.

66 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Digoxin zablokuje sodíko-draselnou pumpu → v buňce zůstane sodík → nevymění se za vápník → **VÍC VÁPNIKU** = silnější stah. A **DRASLÍK** je jeho osud.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zámek

Inhibice Na⁺/K⁺-ATPázy zvýší nitrobuněčný sodík, tím se zpomalí výměník Na⁺/Ca²⁺ a v buňce zůstane více vápníku — odtud pozitivně inotropní účinek.

Šnek

Zároveň zvyšuje tonus vagu — zpomaluje frekvenci a vedení AV uzlem; proto se používá u fibrilace síní s rychlou odpovědí komor a u srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (mortalitu však nesnižuje, jen příznaky).

Draslík

⚠ Digoxin soupeří s draslíkem o totéž vazebné místo — při HYPOKALEMII se váže víc a toxicita prudce roste. Proto pozor při léčbě kličkovými a thiazidovými diuretiky, při zvracení a průjmu. Hyperkalcemie a hypomagnezemie riziko také zvyšují.

Žluté vidění

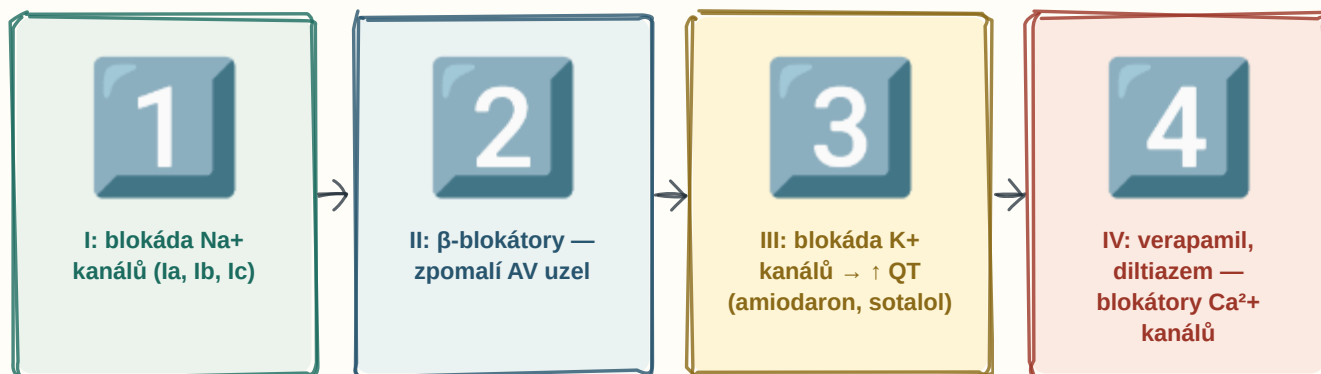
Intoxikace: nauzea, zvracení, průjem, poruchy barevného vidění (žlutozelené vidění, halo), zmatenost a arytmie (bigeminie, AV blokáda). Úzké terapeutické okno — měří se hladiny. Antidotem jsou protilátky (Fab fragmenty).

Další inotropika

Dobutamin (β₁-agonista) a inhibitory fosfodiesterázy III (milrinon) — jen krátkodobě u akutního selhání; levosimendan zvyšuje citlivost myofilament na vápník.

⚠ Digoxin se vylučuje ledvinami — u renální insuficience a u seniorů se dávka snižuje. Amiodaron, verapamil a chinidin jeho hladinu zvyšují.

Vaughanova–Williamsova klasifikace: I = SODÍK, II = BETA-blokátory, III = DRASLÍK, IV = VÁPŇÍK. A skoro každé antiarytmikum umí samo vyvolat arytmií.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Třída I

Blokátory sodíkových kanálů. Ia (chinidin, prokainamid) prodlužují repolarizaci; Ib (lidokain, mexiletin) ji zkracují a působí hlavně na komorové arytmie u ischemie; Ic (propafenon, flekainid) nejsilněji zpomalují vedení — ⚠ kontraindikované po infarktu a při strukturálním poškození srdce (zvyšují mortalitu).

Třída II

β-blokátory zpomalují sinusový uzel a vedení AV uzlem; snižují mortalitu, což většina ostatních antiarytmik neumí.

Třída III

Blokáda draslíkových kanálů prodlužuje repolarizaci a QT. ⚠ AMIODARON je nejúčinnější, ale má rozsáhlou orgánovou toxicitu: plicní fibróza, hepatotoxicita, tyreopatie (obsahuje jod — hypo- i hypertyreóza), depozita v rohovce, fotosenzitivita a šedomodré zbarvení kůže; dlouhý poločas (týdny až měsíce). Sotalol má i účinek II. třídy.

Třída IV

Verapamil a diltiazem zpomalují AV uzel — u supraventrikulárních arytmií. ⚠ Nekombinovat s β-blokátorem (bradykardie, AV blokáda) a nepodávat u srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí.

Mimo klasifikaci

Adenosin (přechodná AV blokáda — ukončí supraventrikulární tachykardii), digoxin, magnezium (u torsade de pointes), ivabradin.

⚠ ⚠ Proarytmogenní účinek: léčiva prodlužující QT (III. třída, ale i makrolidy, chinolony, antipsychotika, ondansetron) mohou vyvolat torsade de pointes — jejich kombinace se počítá.

68 ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

ACE inhibitor blokuje enzym, který dělá DVĚ věci: tvoří angiotensin II a rozkládá bradykinin. Odtud KAŠEL — bradykinin se hromadí.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pokles

Blokádou angiotensin-konvertujícího enzymu klesá angiotensin II — cévy se rozšíří, klesne aldosteron (a s ním retence sodíku a vody). Chrání ledviny u diabetické nefropatie a snižují mortalitu u srdečního selhání a po infarktu.

Kašel

ACE rozkládá i bradykinin; při jeho blokádě se bradykinin hromadí — odtud suchý dráždivý kašel (až 15 % pacientů) a vzácně angioedém. Sartany (losartan, valsartan, telmisartan) blokují receptor AT1 přímo, bradykinin neovlivňují, a proto kašel nevyvolávají.

Varování

Hyperkalemie (⚠️) nekombinovat s kalium šetřícími diuretiky a doplňky draslíku), vzestup kreatininu, hypotenze po první dávce. ⚠️ Kontraindikací je oboustranná stenóza renálních tepen — filtrace v ledvině závisí na angiotensinu II a její blokáda způsobí selhání.

Gravidita

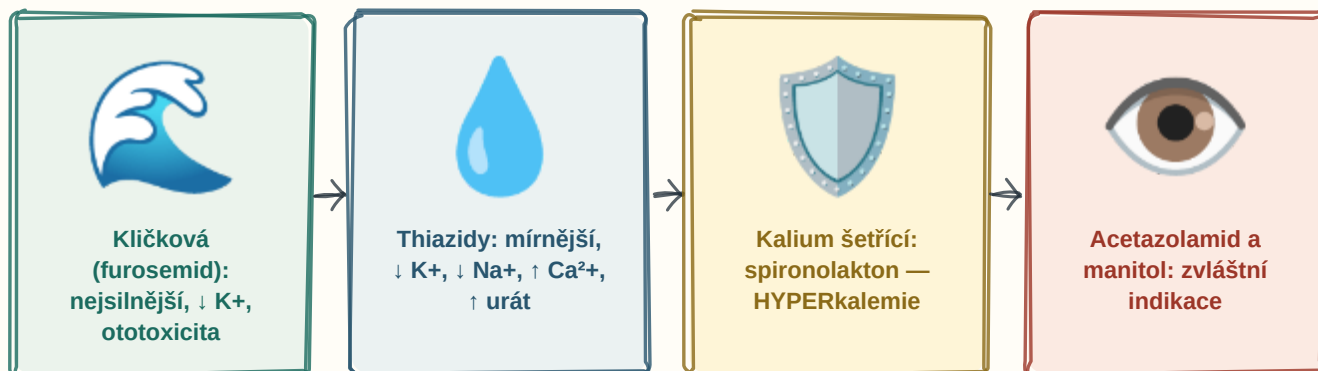
⚠️ ACE inhibitory i sartany jsou v graviditě absolutně kontraindikované — poškozují ledviny plodu, způsobují oligohydramnion a hypoplazii lebky.

Kombinace

ACE inhibitor a sartan se spolu nepodávají (roste riziko bez přínosu). Sakubitril/valsartan (ARNI) je dnes u srdečního selhání účinnější než samotný ACE inhibitor.

⚠️ „Trojkombinace“ ACE inhibitor + diuretikum + NSA je klasická příčina akutního poškození ledvin — na to se u pacienta s otoky ptej cíleně.

Kde v nefronu působí, to určuje sílu i nežádoucí účinek. **KLIČKOVÁ** jsou nejsilnější a ženou draslík ven; **SPIRONOLAKTON** ho naopak šetří.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klička

Furosemid blokuje kotransportér Na-K-2Cl ve vzestupném raménku Henleovy kličky — nejsilnější diuretický účinek, působí i při renální insuficienci. Nežádoucí: hypokalemie, hyponatremie, hypomagnezemie, hypovolemie, metabolická alkalóza, hyperurikemie, ⚠ ototoxicita (zvláště s aminoglykosidy).

Thiazidy

Hydrochlorothiazid, indapamid — blokují Na-Cl kotransportér v distálním tubulu; slabší, ale výhodné u hypertenze. ⚠ Zvyšují vápník v krvi (na rozdíl od kličkových, které ho vylučují), zvyšují kyselinu močovou (mohou vyprovokovat dnu), glykemii a lipidy; způsobují hypokalemii a hyponatremii.

Štít

Spironolakton a eplerenon jsou antagonisté aldosteronu — snižují mortalitu u srdečního selhání; ⚠ hlavním rizikem je HYPERKALEMIE, spironolakton navíc působí gynekomastii (antiandrogenní účinek). Amilorid blokuje sodíkový kanál.

Zvláštní

Acetazolamid (inhibitor karboanhydrázy) — glaukom, výšková nemoc, metabolická alkalóza; manitol (osmotické) — nitrolební hypertenze a edém mozku, ⚠ kontraindikován u srdečního selhání a anurie.

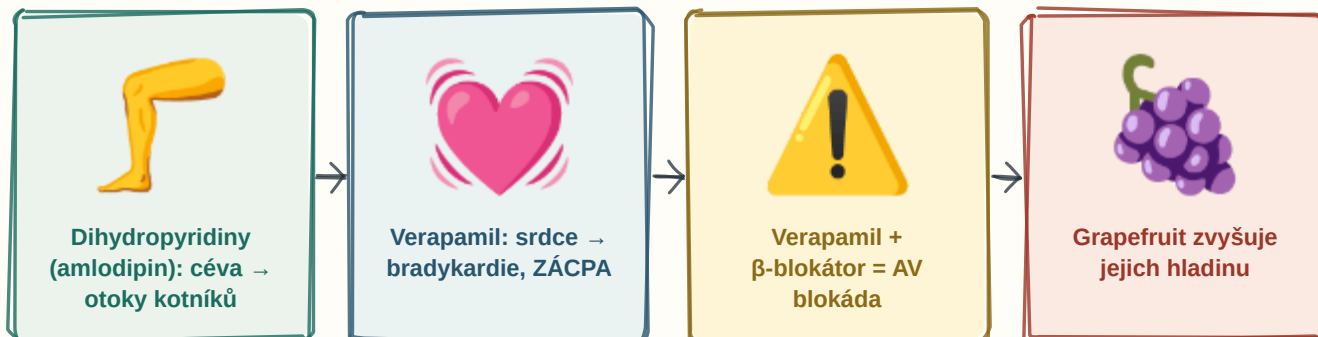
Kombinace

Kličkové s thiazidem působí sekvenční blokádu (velmi silný účinek, riziko těžkých iontových poruch); s kalium šetřícím se draslík vyrovnává.

⚠ ⚠ Hypokalemie po diuretiku zvyšuje toxicitu digoxinu a riziko arytmií — u pacienta na obojím se draslík kontroluje.

70 Blokátoři kalciových kanálů

**DIHYDROPYRIDINY jdou na CÉVU (otoky, návaly, reflexní tachykardie).
VERAPAMIL a DILTIAZEM jdou na SRDCE (bradykardie, zácpa).**



ROZKLÍČOVÁNÍ

Noha

Dihydropyridiny (amlodipin, nifedipin, lerkandipin, nimodipin) působí převážně na hladký sval cév — vazodilatace, pokles tlaku. Nežádoucí: otoky kotníků (nereagují na diuretikum), návaly, bolest hlavy, reflexní tachykardie a gingivální hyperplazie. Nimodipin se používá u vazospasmu po subarachnoidálním krvácení.

Srdce

Verapamil (fenylalkylamin) a diltiazem (benzothiazepin — ⚠ ne benzodiazepin) tlumí i srdce: zpomalují sinusový uzel a vedení AV uzlem, snižují kontraktilitu. Používají se u supraventrikulárních arytmií a anginy. Verapamil typicky působí zácpu.

Zákaz kombinace

⚠ Verapamil ani diltiazem se nekombinují s β -blokátořem — hrozí těžká bradykardie a AV blokáda; nepodávají se ani u srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (negativně inotropní).

Grapefruit

Metabolizují se CYP3A4 — grapefruitová šťáva a azolová antimykotika jejich hladinu prudce zvyšují.

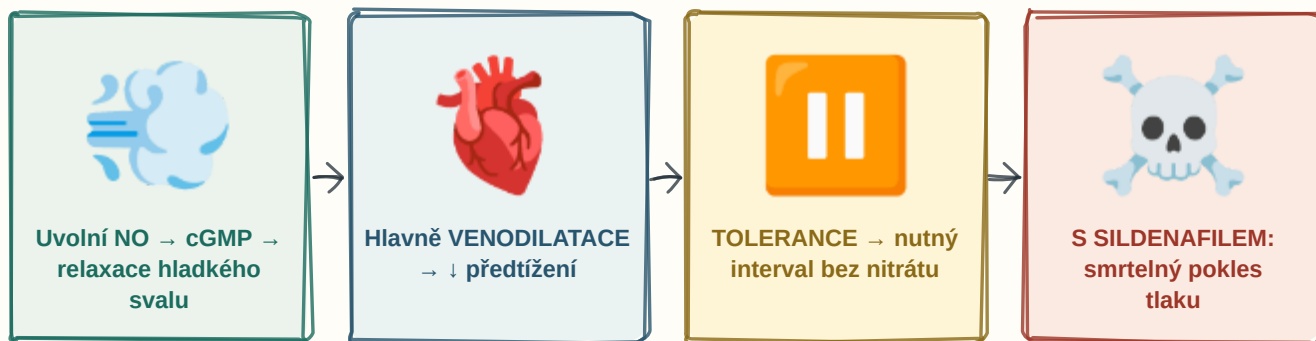
Předávkování

Léčí se kalcie a vysokodávkovaným inzulínem s glukózou.

⚠ Krátkodobě působící nifedipin se u hypertenze nepoužívá — prudký pokles tlaku vyvolá reflexní tachykardii a může vyprovokovat ischemii.

71 Nitrity a nitráty

Nitrát se v cévě mění na OXID DUSNATÝ → rozšíří hlavně ŽÍLY → do srdce se vrátí méně krve → srdce má méně práce. A po pár dnech přestane fungovat — proto NOČNÍ PAUZA.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Plyn

Nitráty jsou zdrojem oxidu dusnatého, který zvýší cyklický GMP a relaxuje hladký sval cévy.

Srdce

Převažuje dilatace žil — klesá žilní návrat a předtížení, a tím spotřeba kyslíku myokardem; ve vyšších dávkách i dilatace tepen a koronární vazodilatace. Odsud úleva při angině pectoris.

Pauza

⚠ Při trvalé hladině vzniká během dní tolerance — proto se ponechává denní interval 8–12 hodin bez nitrátu (náplast se na noc sundává, isosorbid-mononitrát se dává asymetricky).

Zákaz

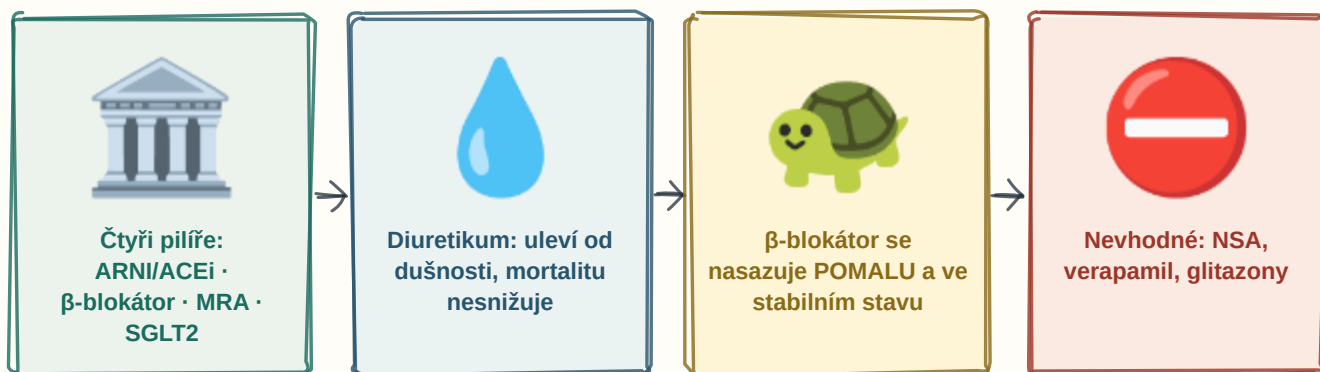
⚠ Kombinace s inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil) je absolutně kontraindikovaná — obě látky zvyšují cGMP a spolu způsobí těžkou, život ohrožující hypotenzi.

Zástupci a nežádoucí účinky

Nitroglycerin sublingválně u akutní ataky (za minuty), isosorbid-dinitrát a -mononitrát dlouhodobě, nitroprusid sodný v infuzi u hypertenzní krize. Nežádoucí: pulzující bolest hlavy, návaly, ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie. Kontraindikací je hypertrofická obstrukční kardiomyopatie a těžká aortální stenóza.

⚠ Dusitany (nitrity) navíc oxidují hemoglobin na methemoglobin — proto se dusitan sodný používá jako antidotum otravy kyanidy: methemoglobin na sebe kyanid naváže.

Cílem není „posílit srdce“, ale **ODLEHČIT MU**. Mortalitu snižují jen ACE inhibitor/ARNI, β -blokátor, antagonist aldosteronu a glifloziny — ne diuretikum.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pilíře

U selhání se sníženou ejekční frakcí snižují mortalitu: ACE inhibitor (nebo sakubitril/valsartan — ARNI), β -blokátor (bisoprolol, karvedilol, metoprolol-sukcinát, nebivolol), antagonist mineralokortikoidních receptorů (spironolakton, eplerenon) a glifloziny (dapagliflozin, empagliflozin).

Kapka

Klíčková diuretika odstraní městnání a dušnost —lepší příznaky, ale prognózu nezmění. Dávka se titruje podle hmotnosti a otoků.

Želva

β -blokátor se zahajuje až u stabilizovaného pacienta a velmi nízkou dávkou s pomalým zvyšováním — na začátku může selhání přechodně zhoršit, přestože z dlouhodobého hlediska prodlužuje život.

Zákaz

⚠ NSA (retence sodíku a vody, zhoršení funkce ledvin), verapamil a diltiazem (negativně inotropní), glitazony, většina antiarytmik I. třídy.

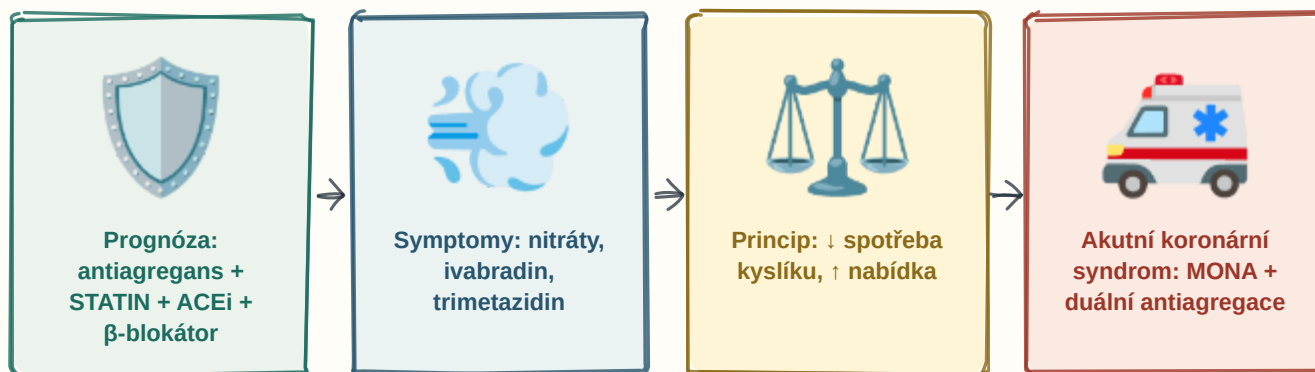
Doplňkově

Digoxin (příznaky a kontrola frekvence u fibrilace síní), ivabradin (při vysoké frekvenci na sinusovém rytmu), hydralazin s nitrátem při nesnášenlivosti ACE inhibitorů.

⚠ U selhání se zachovanou ejekční frakcí je průkaz účinku slabší — zůstávají glifloziny, léčba městnání diuretikem a důsledná léčba přidružených chorob.

73 Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Léčba má dvě oddělené větve: **PROGNOSTICKOU** (aspirin, statin, ACE inhibitor, β -blokátor — prodlužují život) a **SYMPTOMATICKOU** (nitráty — jen uleví).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Štít

Prognózu zlepšují: kyselina acetylsalicylová (nebo klopido­gre­l), statin ve vysoké dávce bez ohledu na výchozí cholesterol, ACE inhibitor a β -blokátor (zvláště po infarktu).

Úleva

Nitráty (sublingválně akutně, dlouhodobě s intervalem bez nitrátu), β -blokátory a blokátory kalciových kanálů snižují spotřebu kyslíku; ivabradin zpomaluje sinusový uzel bez ovlivnění kontraktility; trimetazidin mění metabolismus myokardu.

Rovnováha

Vše směřuje k jedinému: snížit spotřebu kyslíku myokardem (frekvence, kontraktilita, napětí stěny) a zlepšit jeho nabídku.

Akutně

Při akutním koronárním syndromu: kyslík (jen při hypoxii), nitrát, morfin, kyselina acetylsalicylová + druhý antiagregans (tikagrelor, prasugrel, klopido­gre­l), antikoagulace, statin, β -blokátor a co nejrychlejší revaskularizace.

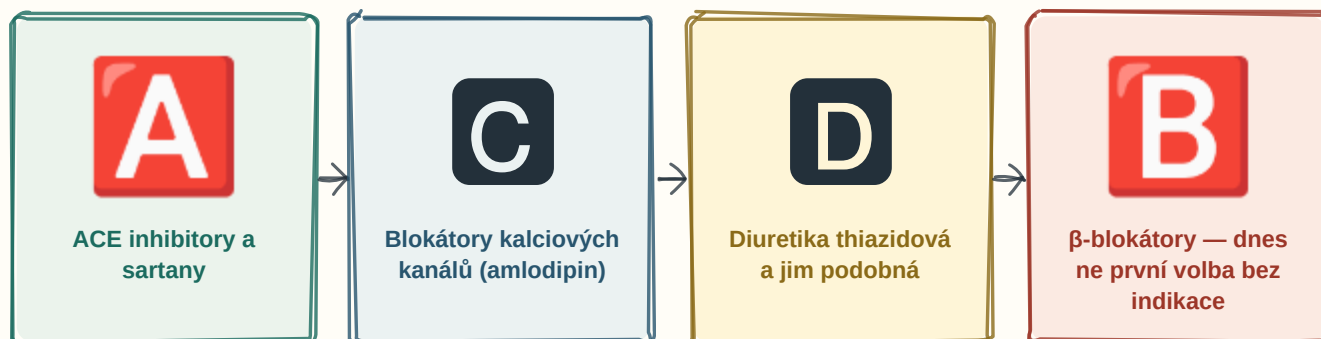
Vazospastická angina

Prinzmetalova — lékem volby jsou blokátory kalciových kanálů a nitráty; ⚠ β -blokátory ji mohou zhoršit.

⚠ Nitrát neprodlužuje život — pacientovi uleví od bolesti, ale statin a antiagregans jsou to, co rozhoduje o prognóze. To je nejčastější doplňující otázka.

74 Antihypertenziva

Pět základních skupin: ACEi/sartan, blokátor kalciových kanálů, thiazid, β -blokátor. Dnes se začíná rovnou DVOJKOMBINACÍ v jedné tabletě.



ROZKLÍČOVÁNÍ

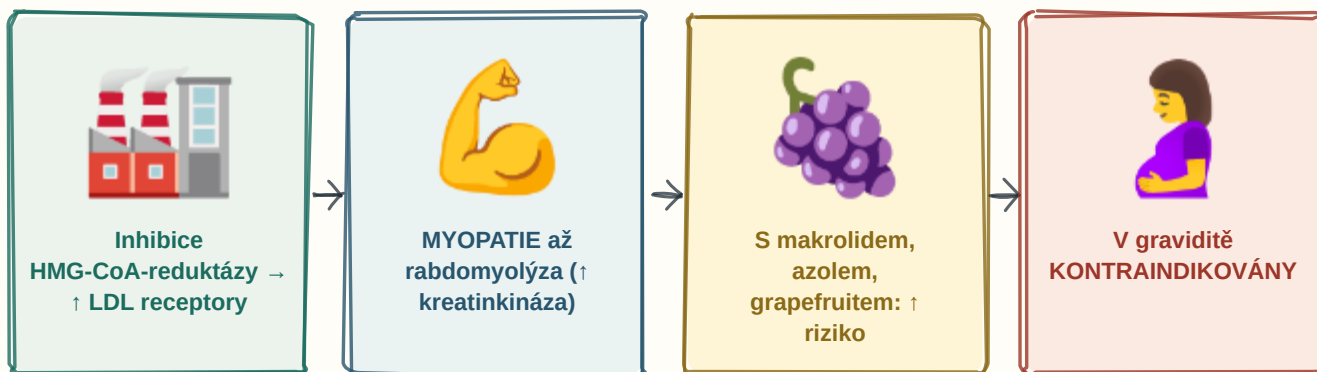
- A** ACE inhibitory a sartany — první volba u mladších, u diabetu, nefropatie, srdečního selhání a po infarktu. ⚠ V graviditě kontraindikovány.
- C** Blokátory kalciových kanálů (amlodipin) — vhodné u starších a u izolované systolické hypertenze; nežádoucí otoky kotníků.
- D** Thiazidy a indapamid — účinné, levné; pozor na hypokalemii, hyperurikemii a zhoršení glykemie.
- B** β -blokátory dnes nejsou první volbou u nekomplikované hypertenze; nasazují se, existuje-li další důvod (ischemická choroba, srdeční selhání, arytmie, tyreotoxikóza).

Kombinace

Zahajuje se fixní dvojkombinací (ACEi/sartan + blokátor kalciových kanálů nebo diuretikum) — účinnější a lépe se dodržuje. ⚠ ACE inhibitor a sartan se spolu nekombinují. Rezistentní hypertenze: přidat spironolakton. Dále centrální α 2-agonisté (methyldopa — lék volby v graviditě), α -blokátory, přímý inhibitor reninu.

⚠ V graviditě jsou lékem volby methyldopa, labetalol a nifedipin. Naopak ACE inhibitory, sartany a atenolol jsou kontraindikované.

STATIN blokuje HMG-CoA-reduktázu, klíčový krok tvorby cholesterolu. Játra na to odpoví tím, že si nasadí VÍC LDL receptorů — a ty vytáhnou LDL z krve.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Továrna

Statiny (atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin) blokují krok určující rychlost syntézy cholesterolu v játrech; buňka reaguje zvýšením počtu LDL receptorů, které vychytávají LDL z krve. Snižují mortalitu a mají i protizánětlivý, plakstabilizující účinek.

Sval

⚠ Nejvýznamnějším nežádoucím účinkem je myopatie — bolest svalů se vzestupem kreatinkinázy, vzácně rabdomyolýza s akutním selháním ledvin. Dále vzestup jaterních testů a mírně zvýšené riziko diabetu.

Interakce

Riziko myopatie prudce stoupá při současném podání inhibitorů CYP3A4 (klarithromycin, itraconazol, verapamil, grapefruit) a fibrátů (zvláště gemfibrozilu). Rosuvastatin a pravastatin jsou přes CYP3A4 metabolizovány méně.

Gravidita

⚠ Statiny jsou v graviditě a při kojení kontraindikované — cholesterol je nezbytný pro vývoj plodu.

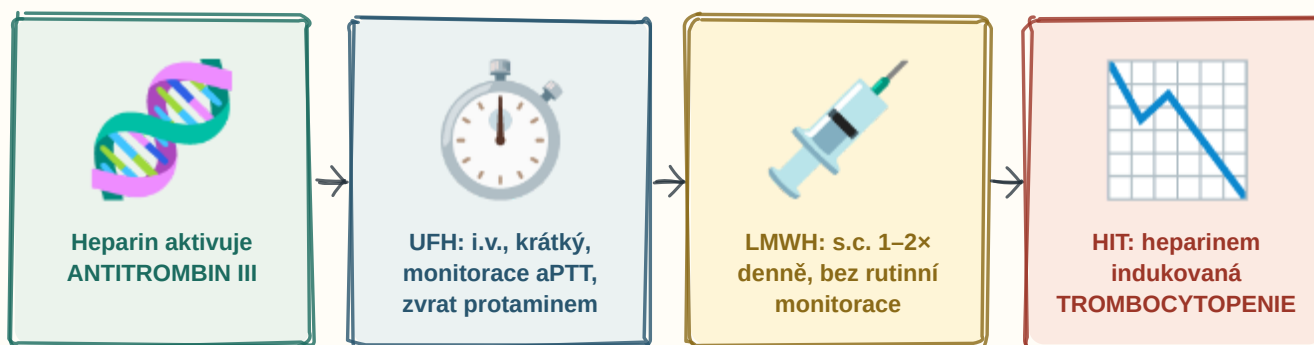
Další léčiva

Ezetimib (blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě) · inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab — injekčně, velmi účinné) · fibráty (hlavně na triglyceridy) · pryskyřice (kolestyramin — váže žlučové kyseliny, zhoršuje vstřebávání jiných léčiv a vitaminů) · omega-3 mastné kyseliny.

⚠ Bolest svalů při statinu bývá i nocebo — proto se ověřuje kreatinkináza a zkouší se jiný statin nebo nižší dávka, než se skupina opustí úplně.

76 Parenterální antikoagulancia

Nefrakcionovaný heparin má **KRÁTKÝ** účinek, měří se **aPTT** a dá se zvrátit **PROTAMINEM**. Nízkomolekulární je pohodlnější, ale zvrátit se dá jen zčásti.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Antitrombin

Heparin sám nesráží — mnohonásobně zesiluje účinek antitrombinu III, který inaktivuje trombin (IIa) a faktor Xa.

UFH

Nefrakcionovaný heparin: nitrožilně, krátký poločas, účinek se sleduje aPTT. Výhodou je rychlá ovladatelnost a použitelnost při renálním selhání; antidotem je PROTAMIN-SULFÁT.

LMWH

Nízkomolekulární hepariny (enoxaparin, nadroparin, dalteparin) působí hlavně na faktor Xa; podávají se subkutánně, mají předvídatelný účinek a nevyžadují rutinní monitorování (jen anti-Xa u gravidity, obezity a renální insuficience). ⚠ Vylučují se ledvinami — u renální insuficience se dávka snižuje. Protamin je zvrátí jen částečně.

HIT

⚠ Heparinem indukovaná trombocytopenie je imunitně podmíněná reakce (typ II, 5.–10. den) — paradoxně vede k TROMBÓZE, nikoli ke krvácení. Heparin se okamžitě vysadí a nahradí argatrobanem nebo fondaparinuxem.

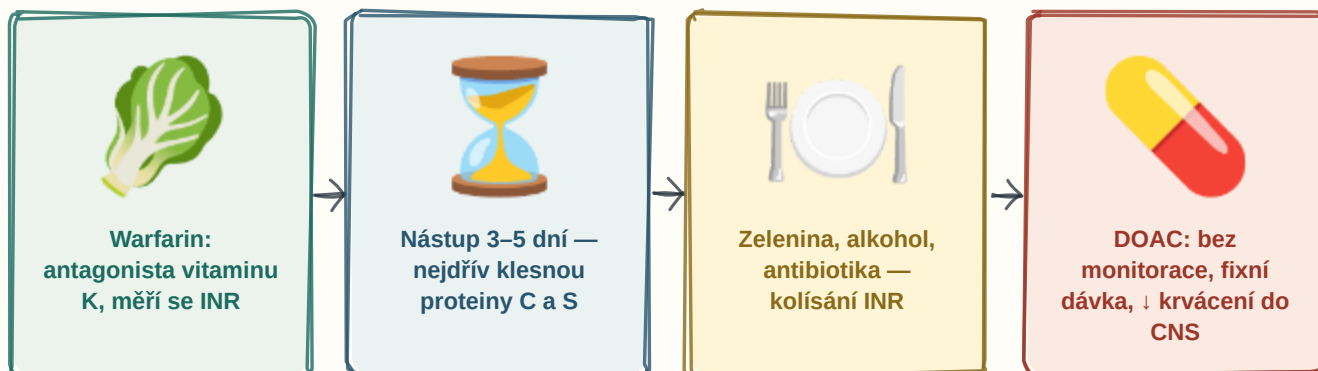
Další

Fondaparinux (selektivní inhibitor Xa), přímé inhibitory trombinu (bivalirudin, argatroban). Hepariny neprocházejí placentou — proto jsou antikoagulanciem volby v graviditě.

⚠ Dlouhodobé podávání heparinu způsobuje osteoporózu a vzestup jaterních testů; u LMWH je riziko nižší než u nefrakcionovaného.

77 Perorální antikoagulancia

WARFARIN blokuje vitamin K → chybí faktory II, VII, IX, X. Ale nejdřív vypadnou PROTEINY C a S — proto na začátku hrozí paradoxně TROMBÓZA.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zelenina

Warfarin blokuje vitamin K-epoxidreduktázu, a tím γ -karboxylaci faktorů II, VII, IX a X. Účinek se sleduje pomocí INR (u fibrilace síní cíl 2–3). Antidotem je vitamin K a při závažném krvácení koncentrát protrombinového komplexu.

Přesýpací hodiny

Nástup trvá 3–5 dní, než se spotřebují dříve vytvořené faktory. ⚠ Nejkratší poločas mají proteiny C a S, které srážení tlumí — proto na začátku převládá prokoagulační stav (warfarinová kožní nekróza) a překrývá se heparinem.

Interakce

Velmi četné: potraviny bohaté na vitamin K (listová zelenina, brokolice) účinek snižují; antibiotika likvidují střevní bakterie produkující vitamin K a účinek zvyšují; amiodaron, metronidazol, azoly, NSA a alkohol zvyšují riziko krvácení. ⚠ Warfarin je v graviditě teratogenní.

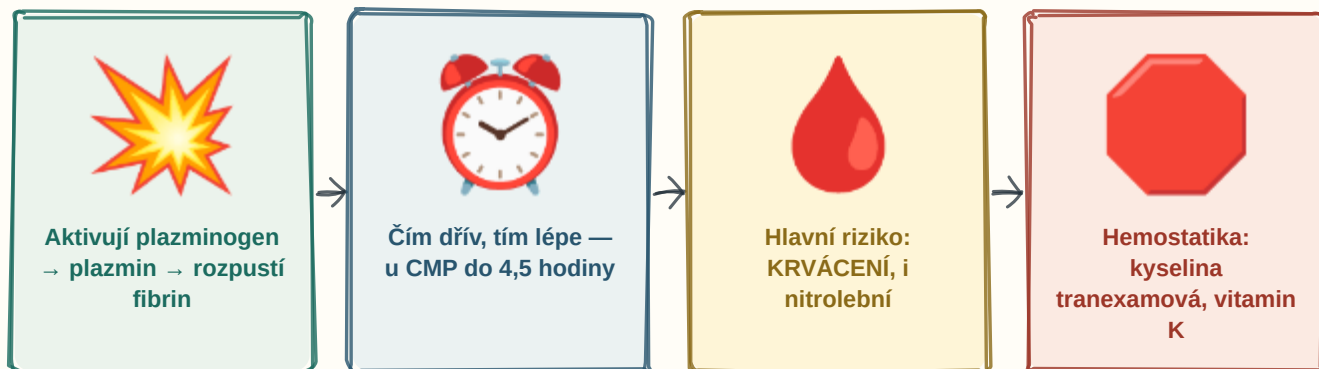
DOAC

Přímá perorální antikoagulancia: dabigatran (přímý inhibitor trombinu, antidotum idarucizumab) a xabany — rivaroxaban, apixaban, edoxaban (inhibitory faktoru Xa, antidotum andexanet alfa). Fixní dávka, bez rutinní monitorace, méně interakcí a nižší riziko nitrolebního krvácení. ⚠ Nepoužívají se u mechanické chlopenní náhrady a u těžké renální insuficience.

⚠ U mechanické chlopně a u antifosfolipidového syndromu zůstává warfarin jedinou možností — DOAC tam selhávají.

78 Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Trombolitikum umí jediné: ROZPUSTIT už vzniklý trombus. Zaplatí se to rizikem krvácení — a čas rozhoduje o všem.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Rozpouštění

Alteplasa, tenekteplasa (tkáňový aktivátor plazminogenu) a streptokináza mění plazminogen na plazmin, který štěpí fibrin. Indikace: akutní infarkt myokardu (není-li dostupná katetrizace), ischemická cévní mozková příhoda, masivní plicní embolie.

Hodiny

Účinek prudce klesá s časem — u ischemické cévní mozkové příhody je okno zhruba 4,5 hodiny od začátku příznaků. ⚠ Vždy je nutné nejprve vyloučit krvácení zobrazením.

Krvácení

⚠ Kontraindikace: prodělané nitrolební krvácení, nádor či cévní malformace mozku, cévní mozková příhoda v posledních měsících, nedávná velká operace nebo trauma, aktivní krvácení, těžká nekontrolovaná hypertenze, disekce aorty.

Hemostatika

Působí opačně: kyselina tranexamová (inhibitor fibrinolýzy) u traumatu, poporodního krvácení a menoragie; vitamin K u předávkování warfarinem; koncentrát protrombinového komplexu a čerstvá mražená plazma; desmopresin u hemofilie A a von Willebrandovy choroby (uvolní faktor VIII a vWF ze zásob); lokálně fibrinové lepidlo, želatinová pěna, oxidovaná celulóza.

Substitute

U hemofilie A koncentrát faktoru VIII, u hemofilie B faktoru IX; emicizumab u hemofilie A profylakticky.

⚠ Hemofilie A je VROZENÝ (X-vázaný) defekt faktoru VIII — nikoli získaný. To je častá chyba ve studentských zpracováních.

79 Antiagregancia

Aspirin blokuje COX-1 v destičce NEVRATNĚ — a destička si nový enzym vyrobit neumí. Proto účinek trvá celých 7–10 dní, dokud se destičky nevymění.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zámek

Nízká dávka kyseliny acetylsalicylové (75–100 mg) ireverzibilně acetyluje COX-1 v destičce, čímž zablokuje tvorbu tromboxanu A2 a agregaci.

Kalendář

Destička nemá jádro a nový enzym nevytvoří — účinek proto trvá po celou její životnost (7–10 dní). Před operací se z toho vychází při rozhodování o vysazení.

P2Y12

Klopidogrel, prasugrel a tikagrelor blokují destičkový ADP receptor P2Y12. Klopidogrel je PROLÉČIVO aktivované CYP2C19 — u pomalých metabolizátorů účinkuje málo; tikagrelor a prasugrel působí spolehlivěji a rychleji.

Interakce

⚠ Omeprazol inhibuje CYP2C19 a snižuje účinnost klopidogrelu — volí se pantoprazol. ⚠ Ibuprofen podaný před aspirinem zabrání jeho vazbě na COX-1 a ruší antiagregační účinek.

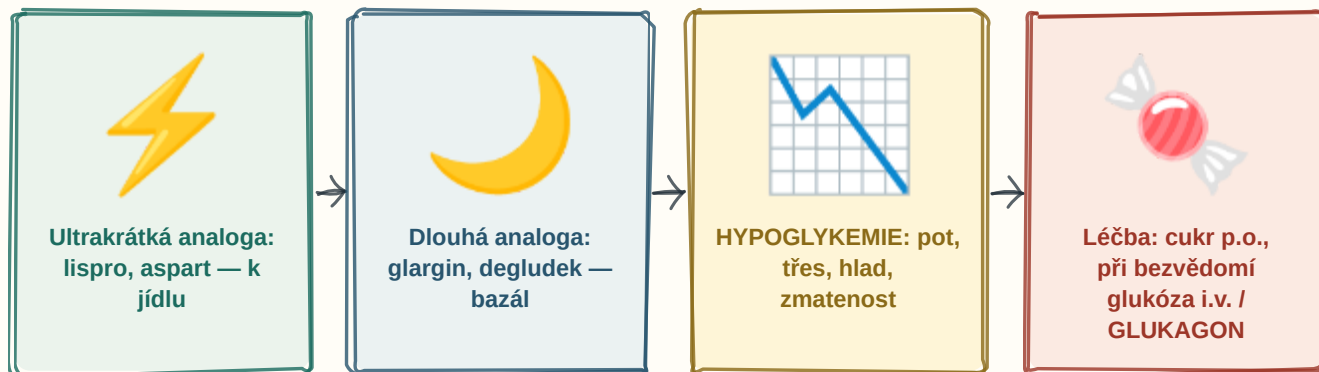
Další

Inhibitory glykoproteinu IIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) nitrožilně při katetrizaci; dipyridamol; cilostazol u ischemické choroby dolních končetin. Duální antiagregace (ASA + inhibitor P2Y12) se podává po akutním koronárním syndromu a po implantaci stentu po stanovenou dobu.

⚠ Antiagregans působí na destičku (arteriální trombóza), antikoagulans na plazmatické faktory (žilní trombóza a embolie) — záměna indikací je typická chyba.

80 Inzulin, jeho analoga a glukagon

Bazál drží glykemii mezi jídly, bolus pokrývá jídlo. A nejnebezpečnější komplikace není hyperglykemie, ale HYPOGLYKEMIE.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Bolus

Ultrakrátké působící analoga (lispro, aspart, glulisin) nastupují za minuty a podávají se těsně před jídlem; krátký humánní inzulin dříve 30 minut předem.

Bazál

Dlouhodobě působící analoga (glargin, detemir, degludek) mají plochý profil bez vrcholu — nižší riziko noční hypoglykemie než NPH inzulin. Režim bazál-bolus napodobuje fyziologickou sekreci.

Hypoglykemie

Nejčastější a nejnebezpečnější komplikace: pocení, třes, palpitace, hlad (adrenergní) a poté zmatenost, porucha chování, křeče, kóma (neuroglykopenické). ⚠️ β-blokátory adrenergní varovné příznaky maskují — kromě pocení.

Léčba

Při vědomí cukr ústy; při bezvědomí glukóza nitrožilně, případně GLUKAGON i.m. nebo intranazálně (glukagon nepůsobí při vyčerpaných jaterních zásobách glykogenu — např. u alkoholika).

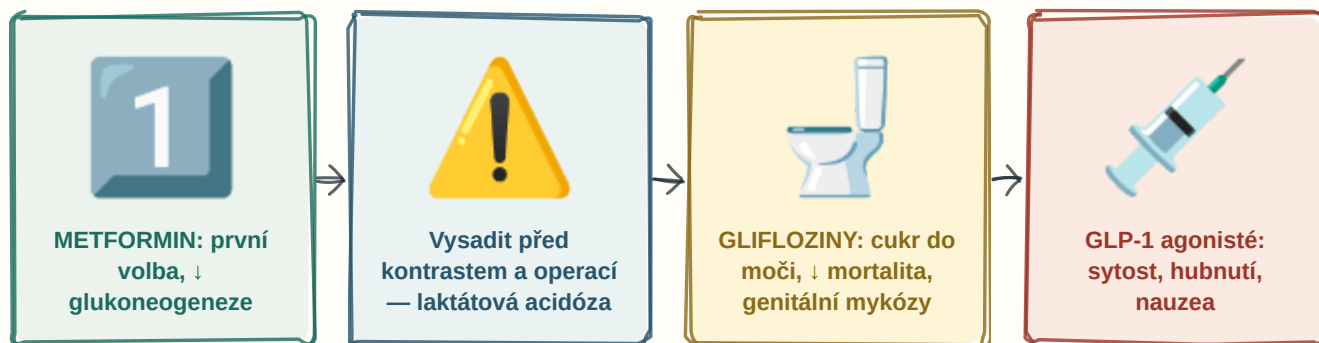
Další

Inzulin vede k přírůstku hmotnosti, lipodystrofii v místě vpichu (nutné střídat místa) a hypokalemii (přesun draslíku do buňky — využívá se v léčbě hyperkalemie).

⚠️ Glukagon působí opačně než inzulin: štěpí glykogen a zvyšuje glykemii; používá se i jako antidotum při předávkování β-blokátory, protože stimuluje srdce mimo β-receptor.

81 Perorální antidiabetika

METFORMIN je první volba u každého diabetika 2. typu: nezpůsobuje hypoglykemii ani přírůstek hmotnosti. Jeho jediné vážné riziko je LAKTÁTOVÁ ACIDÓZA.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Metformin

Biguanid — snižuje jaterní glukoneogenezi a zvyšuje citlivost k inzulinu. Nezpůsobuje hypoglykemii ani přírůstek hmotnosti, mírně snižuje hmotnost. Nežádoucí: průjem a nauzea (proto pomalá titrace), deficit vitamínu B12.

Varování

⚠ Kontraindikací je renální insuficience, hypoxie, těžké jaterní onemocnění a alkoholismus — hrozí laktátová acidóza. Před podáním jodové kontrastní látky a před operací se vysazuje.

Glifloziny

Inhibitory SGLT2 (dapagliflozin, empagliflozin) blokují zpětné vstřebávání glukózy v tubulu — cukr odchází močí. Snižují hmotnost, tlak a mortalitu u srdečního selhání a chrání ledviny. Nežádoucí: genitální mykózy a urogenitální infekce, vzácně euglykemická ketoacidóza.

Inkretiny

Agonisté GLP-1 receptoru (liraglutid, semaglutid, dulaglutid) — zpomalují vyprazdňování žaludku, zvyšují sytost, snižují hmotnost a kardiovaskulární riziko; nežádoucí nauzea, riziko pankreatitidy. Gliptiny (sitagliptin, linagliptin) inhibují DPP-4 a jsou hmotnostně neutrální.

Sekretagoga

Deriváty sulfonylurey (gliklazid, glimepirid) zavírají draslíkový kanál β -buňky a vyplavují inzulin — ⚠ způsobují HYPOGLYKEMII a přírůstek hmotnosti. Glinidy působí krátce k jídlu. Pioglitazon zvyšuje citlivost, ale působí retenci tekutin a je kontraindikován u srdečního selhání.

⚠ Hypoglykemii z perorálních antidiabetik způsobují prakticky jen deriváty sulfonylurey a glinidy — metformin, glifloziny, gliptiny ani GLP-1 agonisté samy o sobě ne.

BAKTERICIDNÍ zabíjí, BAKTERIOSTATICKÉ jen brzdí množení a zbytek musí dodělat imunita. U neutropenického a u endokarditidy proto musí být baktericidní.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Meč

Baktericidní: betalaktamy, glykopeptidy, aminoglykosidy, chinolony, metronidazol. Bakteriostatické: makrolidy, tetracykliny, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol. ⚠ U imunokompromitovaného, u endokarditidy a meningitidy je nutná baktericidní léčba.

Terč

Empirická léčba se zahajuje podle nejpravděpodobnějšího původce a lokální epidemiologie — ale odběr na kultivaci se dělá PŘED prvním podáním. Po výsledku se deeskaluje na co nejužší spektrum.

Hodiny

Betalaktamy zabíjejí časově závisle — rozhoduje doba nad minimální inhibiční koncentrací, proto se podávají častěji nebo v prodloužené infuzi. Aminoglykosidy a chinolony koncentračně závisle — podávají se jednou denně ve vysoké dávce.

Rezistence

Vzniká mutací nebo přenosem plazmidu. Zásady: nepodávat na virózu, dodržet dávku a délku, nezaměňovat kolonizaci za infekci, používat co nejužší spektrum a podle možnosti deeskalovat.

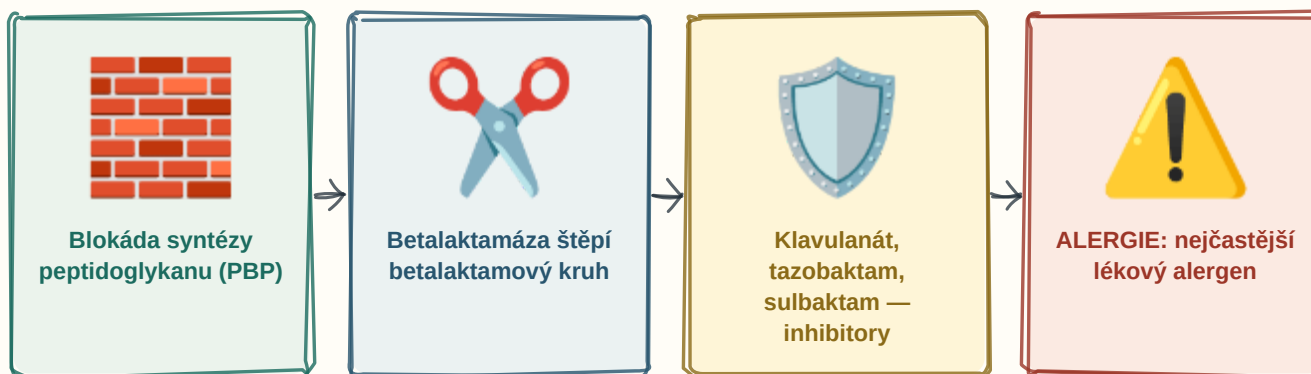
Kombinace

Má smysl u těžkých infekcí, k rozšíření spektra, k prevenci rezistence (tuberkulóza) a při synergii. ⚠ Baktericidní se zpravidla nekombinuje s bakteriostatickým — to by účinek oslabilo.

⚠ Profylaxe má být krátká a cílená: chirurgická jedna dávka před výkonem. Delší podávání nechrání víc, jen selektuje rezistentní kmeny.

83 Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Betalaktam rozbije BUNĚČNOU STĚNU. Bakterie se brání enzymem betalaktamázu, který mu rozštěpí kruh — proto se přidává INHIBITOR, který enzym zablokuje.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Cihly

Peniciliny blokují transpeptidázy (penicilin vázající proteiny) a znemožní stavbu peptidoglykanu — buňka praskne osmotickým tlakem. Působí baktericidně a jen na rostoucí bakterie.

Nůžky

Betalaktamáza je hlavní mechanismus rezistence — enzymem se rozštěpí betalaktamový kruh a antibiotikum přestane působit.

Štít

Kyselina klavulanová, sulbaktam a tazobaktam samy antibakteriální účinek prakticky nemají — obětují se enzymu a chrání antibiotikum (amoxicilin/klavulanát, piperacilin/tazobaktam).

Skupiny

Přirozené (penicilin G i.v., V p.o.) — streptokoky, spirochéty (lék volby u syfilis), anaeroby dutiny ústní. Protistafylokokové (oxacilin) odolné penicilináze. Aminopeniciliny (amoxicilin, ampicilin) — širší spektrum, s klavulanátem i na H. influenzae a anaeroby. Protipseudomonádové (piperacilin).

Alergie

⚠ Peniciliny jsou nejčastějším lékovým alergenem; anafylaxe v anamnéze je kontraindikací celé skupiny. Zkřížená alergie s cefalosporiny existuje, ale je nižší, než se dříve uvádělo. ⚠ Ampicilin u infekční mononukleózy vyvolá exantém, který není alergií.

⚠ Peniciliny mají velmi široké terapeutické okno a jsou i v graviditě bezpečné; hlavním nežádoucím účinkem je průjem a alergie, nikoli orgánová toxicita.

84 Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

S rostoucí generací cefalosporinů roste účinek na GRAM-NEGATIVNÍ a klesá na stafylokoky. A žádný běžný cefalosporin nezabírá na enterokoka.



ROZKLÍČOVÁNÍ

První

Cefazolin, cefalexin — dobře na gram-pozitivní; cefazolin je standardem chirurgické profylaxe.

Třetí

Ceftriaxon, cefotaxim, ceftazidim — silné na gram-negativní, pronikají do CNS; ceftriaxon je lékem volby u bakteriální meningitidy a kapavky. Ceftazidim pokrývá *Pseudomonas*. IV. generace cefepim, V. generace ceftarolin (účinný i na MRSA).

Karbapenemy

Meropenem, imipenem, ertapenem — nejširší spektrum včetně ESBL producentů a anaerobů; rezervní antibiotika pro těžké a rezistentní infekce. ⚠ Imipenem snižuje práh křečí; ertapenem nepokrývá *Pseudomonas*.

Mezery ve spektru

⚠ Běžné cefalosporiny nepůsobí na enterokoky, MRSA, listerie a atypické patogeny — to je klasická zkušební otázka.

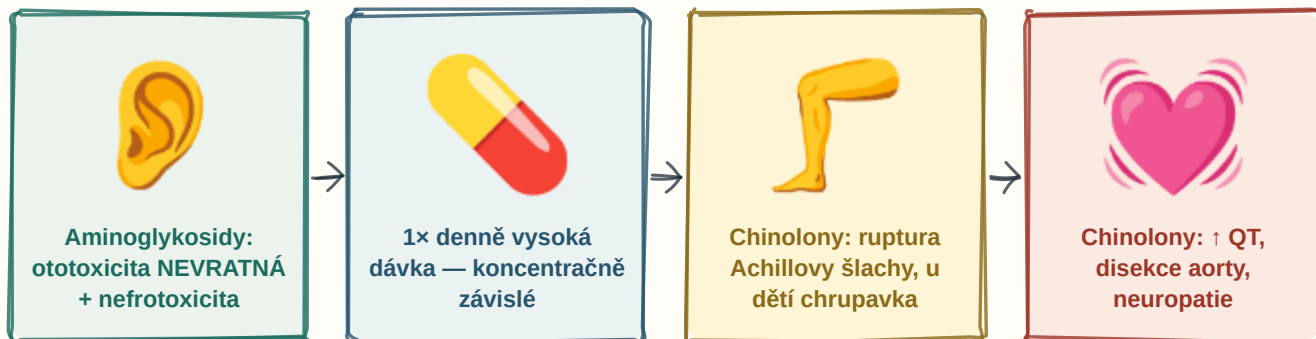
Monobaktamy

Aztreonam působí pouze na gram-negativní aeroby; nemá zkříženou alergii s peniciliny, proto je volbou u těžké alergie na betalaktamy.

⚠ Cefalosporiny širokého spektra silně narušují střevní mikroflóru — patří k nejrizikovějším antibiotikům z hlediska klostridiové kolitidy.

85 Aminoglykosidy, chinolony

Aminoglykosid je NEFROTOXICKÝ a OTOTOXICKÝ — a hluchota je NEVRATNÁ. Chinolon poškozuje ŠLACHY a CHRUPAVKU — proto ne dětem.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ucho

Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin, tobramycin, streptomycin) blokují 30S podjednotku ribozomu, působí baktericidně na gram-negativní bakterie. ⚠ Ototoxicita (kochleární i vestibulární) bývá NEVRATNÁ, nefrotoxicita zpravidla reverzibilní; riziko stoupá s furosemidem a vankomycinem. Nutná monitorace hladin.

Dávkování

Podávají se jednou denně ve vysoké dávce — zabíjejí koncentračně závisle a mají postantibiotický efekt; tento režim je zároveň méně toxický. Nevstřebávají se ze střeva, proto jen parenterálně (nebo lokálně). Zesilují nervosvalovou blokádu.

Šlacha

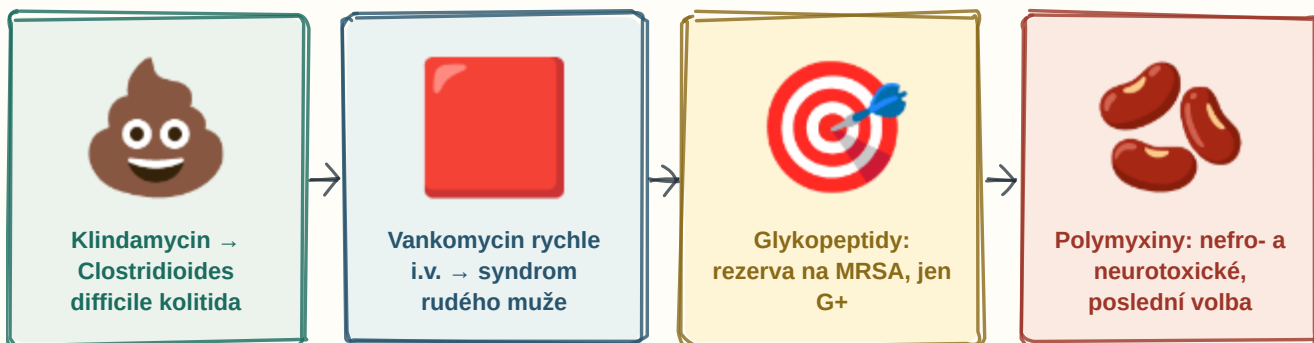
⚠ Fluorochinolony (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin) inhibují bakteriální TOPOIZOMERÁZU II (DNA-gyrázu) a IV — nikoli DNA-polymerázu. Působí tendinitidu a rupturu Achillovy šlachy (riziko roste s kortikoidy a věkem) a u dětí poškozuji chrupavku, proto se jim nepodávají.

Další rizika chinolonů

Prodloužení QT, fotosenzitivita, periferní neuropatie, neuropsychické reakce, riziko disekce aorty, klostridiová kolitida. ⚠ Chelatace s vápníkem, hořčíkem a železem snižuje vstřebání — nezapíjet mlékem, s odstupem od antacid. Ciprofloxacin je inhibitor CYP1A2 (zvýší hladinu theofylinu).

⚠ Kvůli závažným nežádoucím účinkům se dnes chinolony nemají používat u nekomplikovaných infekcí, kde existuje jiná volba.

KLINDAMYCIN je hlavní viník **KLOSTRIDIOVÉ KOLITIDY**. **VANKOMYCIN** podaný rychle vyvolá „**SYNDROM RUDÉHO MUŽE**“ — a to není alergie, ale výlev histaminu.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klindamycin

Linkosamid, blokuje 50S podjednotku ribozomu; dobře proniká do kostí a působí na anaeroby a stafylokoky. ⚠ Z antibiotik nejčastěji vyvolává pseudomembranózní kolitidu způsobenou *Clostridioides difficile*.

Rudý muž

⚠ Vankomycin podaný rychlou infuzí uvolní histamin — zarudnutí obličeje a trupu, svědění, hypotenze. Není to alergie; řeší se zpomalením infuze a antihistaminikem.

Glykopeptidy

Vankomycin a teikoplanin blokují stavbu buněčné stěny (vazba na D-alanyl-D-alanin) — působí pouze na gram-pozitivní bakterie. Rezerva na MRSA a těžké infekce. ⚠ Nefrotoxicita a ototoxicita, nutná monitorace hladin. Perorální vankomycin se nevstřebává a používá se právě na klostridiovou kolitidu.

Polymyxiny

Kolistin (polymyxin E) narušuje membránu gram-negativních bakterií jako detergent; ⚠ výrazně nefrotoxický a neurotoxický — používá se jako poslední možnost u multirezistentních kmenů.

Klostridiová kolitida

Léčí se perorálním vankomycinem nebo fidaxomicinem, případně metronidazolem; při recidivách transplantací fekální mikroflóry.

⚠ Léčba klostridiové kolitidy vankomycinem funguje jen perorálně — nitrožilně se do střevního lumen nedostane.

87 Tetracykliny, amfenikoly

Tetracyklin je ZLODĚJ VÁPŇÍKU: ukradne ho z mléka, zazdí se do rostoucí kosti a zubu a obarví je zevnitř — vybělit už to nejde.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zloděj vápníku

Chelatace s Ca^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} a Fe — nezapíjet mlékem, neužívat s antacidami, železem ani vápníkem.

Zub a kost

Ukládají se do mineralizující tkáně; zbarvení je uvnitř skloviny a dentinu, nikoli na povrchu, a proto se nedá odstranit bělením ani leštěním. Odtud kontraindikace do 8 let, v graviditě a při kojení.

30 = TRicátá

⚠ Tetracyklin blokuje 30S podjednotku ribozomu, tedy PROTEOSYNTÉZU — nikoli buněčnou stěnu. Působí bakteriostaticky, spektrum je široké včetně atypických (chlamydie, mykoplazmata, borrelie, rickettsie). Doxycyklin je dnes hlavní zástupce.

Další nežádoucí účinky

Fotosenzitivita, ezofagitida (zapíjet velkým množstvím vody a nelehát si), hepatotoxicita ve vysokých dávkách.

Amfenikoly

Chloramfenikol blokuje 50S podjednotku. ⚠ Systémově se prakticky nepoužívá pro aplastickou anemii (typ B — nezávislá na dávce, nepředvídatelná) a gray baby syndrom u novorozence s nezralou glukuronidací. Zůstal v očních kapkách a mastech.

⚠ ⚠ Ve zdroji katedry je u tetracyklinů uvedena inhibice buněčné stěny — to je chyba. Stěnu blokují betalaktamy a glykopeptidy.

Makrolidy pokrývají ATYPICKÉ patogeny a jsou náhradou při alergii na penicilin. Jejich největší problém nejsou nežádoucí účinky, ale INTERAKCE.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Atypické

Blokují 50S podjednotku ribozomu, působí bakteriostaticky. Pokrývají mykoplasmata, chlamydie, legionelu a původce černého kašle — tedy patogeny bez buněčné stěny, na které betalaktamy nefungují.

Alergie

Jsou alternativou u pacientů s alergií na penicilin (bez zkřížené reakce).

Interakce

⚠️ Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4 — zvyšují hladiny statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení), cyklosporinu, karbamazepinu a blokátorů kalciových kanálů.

Azithromycin

CYP3A4 prakticky neinhibuje — proto je volbou u polymorbidního pacienta na mnoha léčích. Má velmi dlouhý tkáňový poločas, takže třídní kúra působí ještě řadu dní.

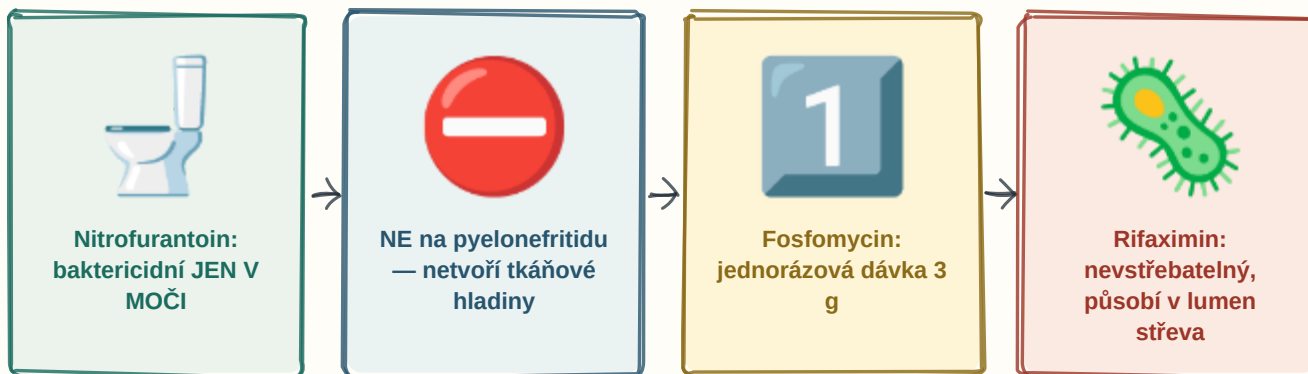
Další nežádoucí účinky

⚠️ Prodloužení QT (sčítá se s chinolony, antipsychotiky, ondansetronem) a gastrointestinální nesnášenlivost. Erythromycin dráždí žaludek přes MOTILINOVÝ receptor — této vlastnosti se využívá, když se podává jako prokinetikum u gastroparézy.

⚠️ Makrolidy jsou bakteriostatické — u endokarditidy a u neutropenického pacienta nestačí; tam je nutná baktericidní léčba.

89 Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

Tyhle látky se **KONCENTRUJÍ V MÍSTĚ INFEKCE** — v moči nebo ve střevním lumen — a systémově skoro nepůsobí. Odtud jejich síla i jejich limit.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Močový měchýř

Nitrofurantoin se aktivuje bakteriálními nitroreduktázami na radikály poškozující DNA; účinné hladiny má pouze v moči — proto se hodí na nekomplikovanou cystitidu.

Zákaz

⚠ Nesmí se použít u pyelonefritidy (netvoří tkáňové hladiny) a je kontraindikován při renální insuficienci (nedostane se do moči) a v posledním trimestru gravidity. Dlouhodobě hrozí plicní fibróza a polyneuropatie.

Jedna dávka

Fosfomycin blokuje ranou fázi syntézy peptidoglykanu a podává se jako jednorázová dávka 3 g u nekomplikované cystitidy. Dále se používají kotrimoxazol a u komplikovaných infekcí chinolony.

Střevo

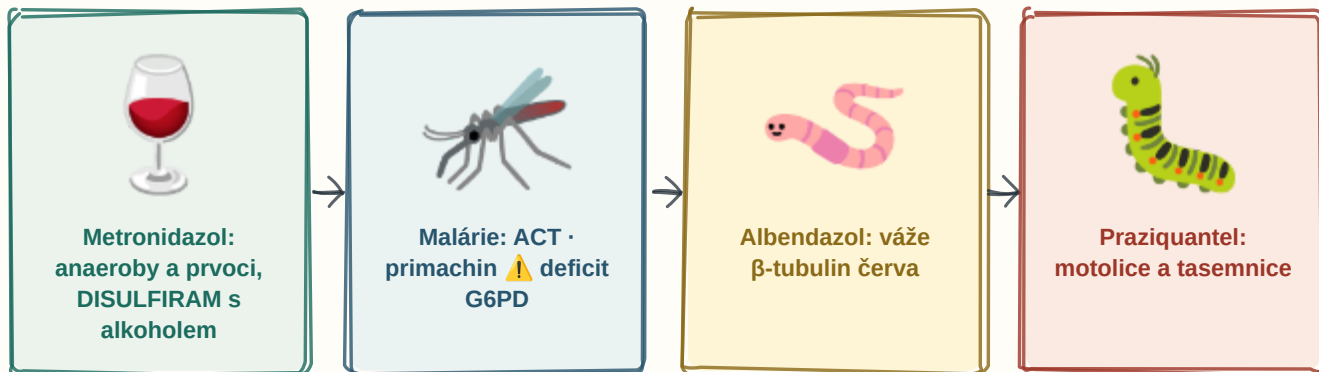
Rifaximin je nevstřebatelný derivát rifamycinu — u cestovatelského průjmu a v prevenci JATERNÍ ENCEFALOPATIE (snižuje střevní produkci amoniaku). Nifuroxazid je střevní nitrofuran.

Klostridium

Perorální vankomycin se nevstřebává a je léčbou klostridiové kolitidy, stejně jako fidaxomicin. Metronidazol pokrývá anaeroby a améby.

⚠ Princip je vždy stejný: lék, který se nevstřebá, nemá systémové nežádoucí účinky — ale ani systémový účinek. Proto se nehodí, jakmile infekce překročí sliznici.

Antiparazitikum zasahuje strukturu, kterou SAVČÍ BUŇKA NEMÁ: mikrotubuly červa, jeho chloridové kanály nebo anaerobní metabolismus prvoka.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Sklenka

Metronidazol (a tinidazol) se aktivuje v anaerobním prostředí na radikály štěpící DNA — účinkuje na trichomonádu, lamblie, améby a anaerobní bakterie. ⚠ Má disulfiramový efekt s alkoholem a kovovou pachutí.

Komár

Antimalarika: artemisininové kombinace (ACT) jsou lékem volby u falciparové malárie; chlorochin, atovakvon/proguanil a doxycyklin v profylaxi. ⚠ PRIMACHIN ničí játerní hypnozoity, ale je kontraindikován při deficitu G6PD (hemolýza).

Červ

Albendazol a mebendazol vážou β -tubulin červa a blokují příjem glukózy — široké spektrum hlístic. Ivermektin otevírá glutamátém řízené chloridové kanály.

Motolice

Praziquantel zvyšuje propustnost membrány parazita pro vápník — motolice a tasemnice.

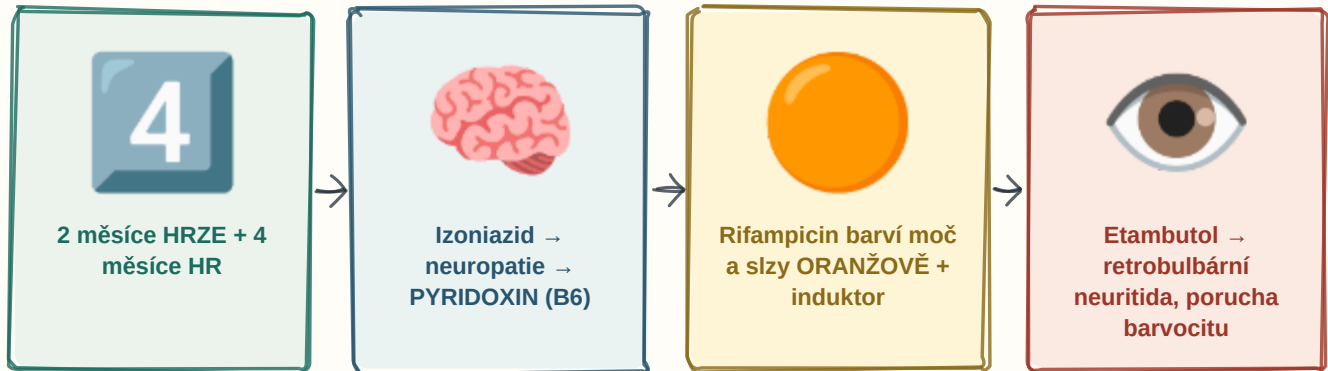
Ostatní

Toxoplazmóza: pyrimethamin se sulfadiazinem a kyselinou listovou. Ektoparazitika: permethrin a ivermektin na svrab a veš.

⚠ Selektivní toxicita je tu klíčová: co poškodí červa, nesmí poškodit hostitele — proto se cílí na struktury, které se od savčích liší.

91 Antituberkulotika a antileprotika

Tuberkulóza se NIKDY neléčí jedním lékem — mykobakterie se dělí pomalu a rychle si vytvoří rezistenci. Vždy čtyřkombinace: HRZE, 2 měsíce, pak HR na 4.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Čtyřkombinace

Vždy nejméně čtyři léčiva a dlouhé podávání pod přímým dohledem (DOT) — mykobakterie se dělí pomalu, tvoří dormantní populace a monoterapie by okamžitě vybrala rezistentní kmen.

H — izoniazid

Blokuje syntézu kyseliny mykolové. ⚠ Působí periferní neuropatii — prevencí je PYRIDOXIN (vitamin B6) — a hepatotoxicitu.

R — rifampicin

Inhibuje bakteriální RNA-polymerázu. ⚠ Je silným INDUKTOREM CYP450 — sníží účinek kontraceptiv, warfarinu, antiretrovirotik. Barví moč, slzy a pot oranžově (varovat pacienta, barví kontaktní čočky).

Z a E

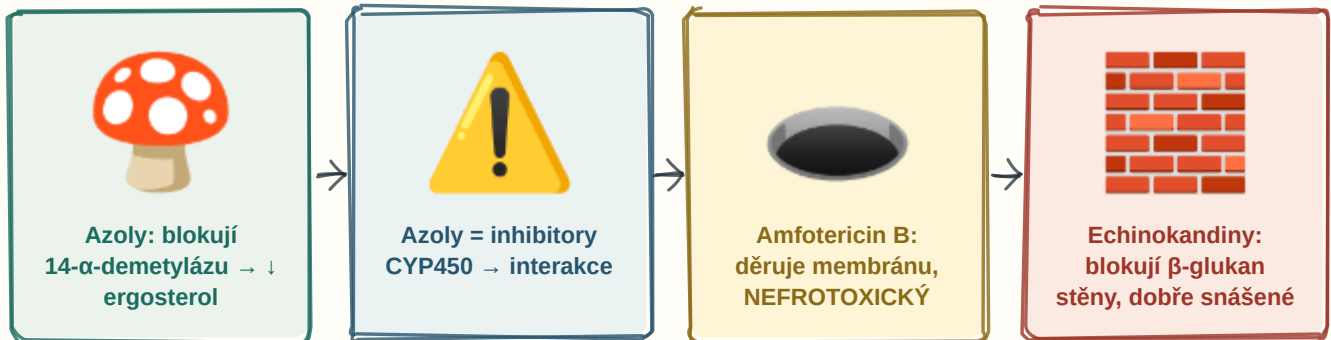
Pyrazinamid působí v kyselém prostředí makrofágu, zvyšuje kyselinu močovou a je hepatotoxický. ⚠ Etambutol blokuje arabinosyltransferázu a způsobuje retrobulbární neuritidu — porucha barvocitu a ostrosti; nutné oční kontroly.

Rezervní a lepra

Streptomycin, fluorochinolony, bedachilin, linezolid. Lepra: dapson + rifampicin + klofazimin, léčba trvá roky.

⚠ Tři ze čtyř základních antituberkulotik jsou hepatotoxická (H, R, Z) — proto se jaterní testy kontrolují pravidelně po celou dobu léčby.

Houba má v membráně **ERGOSTEROL**, člověk **cholesterol**. Celá skupina stojí na tomhle jediném rozdílu — nebo míří na stěnu z **glukanu**, kterou člověk nemá vůbec.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ergosterol

Azoly (flukonazol, itakonazol, vorikonazol, posakonazol; lokálně klotrimazol, mikonazol) inhibují 14- α -demetylázu, tedy syntézu ergosterolu. Působí fungistaticky.

Interakce

⚠️ Hlavním rizikem azolů jsou interakce — inhibují CYP3A4, a tím zvyšují hladiny statinů, warfarinu, cyklosporinu a takrolimu.

Díra

Amfotericin B (polyen) se váže přímo na ergosterol a děruje membránu — fungicidní, vyhrazený pro těžké systémové mykózy. ⚠️ Silně nefrotoxický, působí horečku a třesavku při infuzi; lipozomální forma je snášena lépe. Nystatin je polyen jen k lokálnímu a perorálnímu (nevstřebatelnému) použití — kandidóza dutiny ústní a střeva.

Stěna

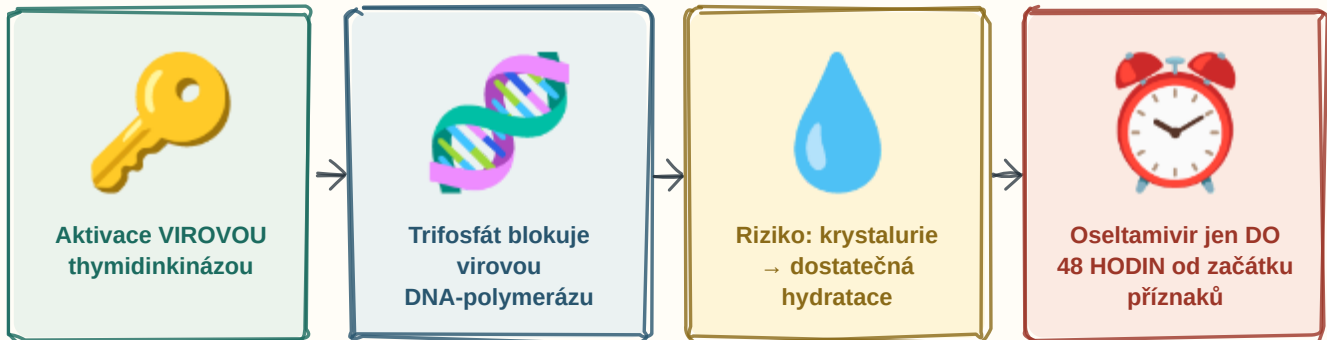
Echinokandiny (kaspofungin, anidulafungin, mikafungin) blokují syntézu β -glukanu buněčné stěny — lidská buňka stěnu nemá, proto jsou velmi dobře snášené; lék volby u invazivní kandidózy.

Další

Terbinafin inhibuje skvalenepoxidázu — onychomykózy a dermatofytózy. Flucytosin se vestavuje do RNA, kombinuje se s amfotericinem u kryptokokové meningitidy.

⚠️ Systémová antimykotika vyžadují dlouhou léčbu (onychomykóza měsíce) — proto se u nich hlídají jaterní testy a interakce, ne jen účinnost.

ACIKLOVIR je bezpečný proto, že ho AKTIVUJE VIROVÁ thymidinkináza — zapne se jen v infikované buňce. Zdravé buňky ho nechají být.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Klíč

Aciklovir je proléčivo fosforylované virovou thymidinkinázou — proto se aktivuje pouze v infikované buňce, což vysvětluje jeho vysokou bezpečnost. Valaciklovir má lepší biologickou dostupnost.

Polymeráza

Aktivní trifosfát blokuje virovou DNA-polymerázu a působí jako terminátor řetězce. ⚠️ Antivirotika jsou převážně virostatická — potlačí replikaci, ale latentní virus nevymýtí, proto herpetické infekce recidivují.

Kapka

Nefrotoxicita a krystalurie při nedostatečné hydrataci — proto se při nitrožilním podání zajišťuje dostatečný přívod tekutin.

Chřipka

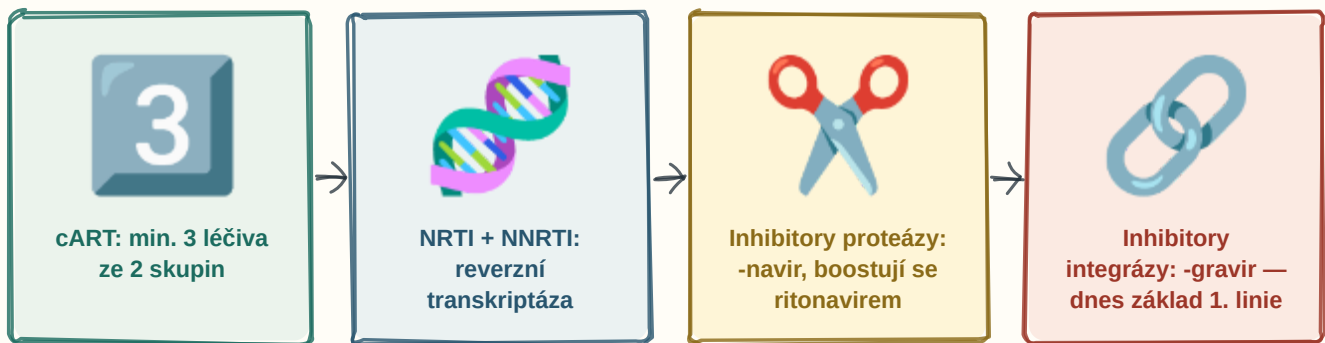
Oseltamivir a zanamivir blokují NEURAMINIDÁZU, a brání tak uvolnění nových virionů z buňky — účinné jen do 48 hodin od začátku příznaků.

Ostatní

Cytomegalovirus: ganciklovir a valganciklovir (myelosuprese), rezervně foscarnet a cidofovir (nefrotoxické). Hepatitida C: přímo působící antivirotika (sofosbuvir, ledipasvir, glekaprevir) vyléčí naprostou většinu nemocných. Hepatitida B: tenofovir, entekavir, peginterferon.

⚠️ Rezistence na aciklovir vzniká nejčastěji ztrátou virové thymidinkinázy — pak se podává foscarnet, který aktivaci nepotřebuje.

HIV se léčí VŽDY kombinací nejméně tří léčiv ze dvou skupin (cART). Monoterapie během týdnů vybere rezistentní kmen — proto se nikdy nepodává sama.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kombinace

Léčba potlačí virovou nálož pod mez detekce, ale infekci nevyлéčí — provirus přetrvává v paměťových buňkách.

Reverzní transkriptáza

NRTI (tenofovir, emtricitabin, abakavir, lamivudin) terminují řetězec.
 ⚠ Abakavir smí být podán až po vyšetření HLA-B*5701 (hypersenzitivita); starší NRTI působí mitochondriální toxicitu a laktátovou acidózu. NNRTI (efavirenz, rilpivirin, doravirin) se vážou alostericky — interagují přes CYP450, efavirenz působí neuropsychicky.

Proteáza

Darunavir, atazanavir blokují štěpení polyproteinu; boostují se ritonavirem nebo kobicistatem (inhibitory CYP3A4). Působí dyslipidemií a lipodystrofií.

Integráza

Dolutegravir, bictegravir, raltegravir — dnes základ první linie: rychlý pokles nálože a málo interakcí.

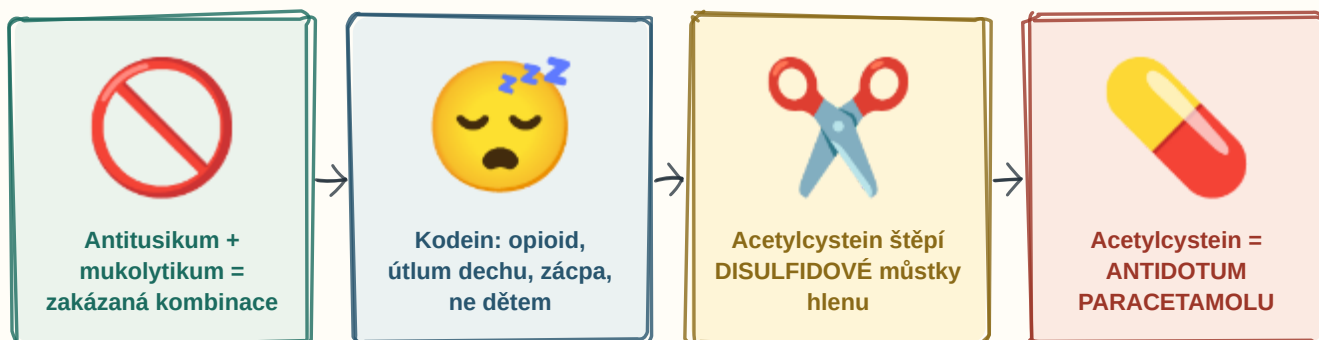
Ostatní

Inhibitory vstupu: maravirok (CCR5), enfuvirtid. PrEP (preexpoziční profylaxe): tenofovir s emtricitabinem.

⚠ Adherence u HIV musí být téměř stoprocentní — vynechané dávky nevedou jen k selhání léčby, ale k výběru rezistentního kmene, který zůstane napořád.

95 Antitusika, mukolytika, expektorancia

Produktivní kašel se NETLUMÍ — je to obrana. A antitusikum se NIKDY nekombinuje s mukolytikem: uvolnil bys hlen a zároveň zakázal ho vykašlat.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Zákaz

Kašel je obranný reflex — tlumí se jen suchý dráždivý kašel. Kombinace antitusika s mukolytikem by vedla k hromadění hlenu v dýchacích cestách.

Kodein

Centrální opioidní antitusikum; proléčivo metabolizované CYP2D6 na morfin. ⚠️ Působí zácpu, útlum dechu, je návykové a u dětí kontraindikované. Dextromethorfan není analgetický ani v běžné dávce návykový, ve vysokých dávkách je disociativní. Butamirát je neopioidní centrální antitusikum.

Nůžky

N-acetylcystein štěpí disulfidové můstky mukoproteinů, a tím hlen zředí. Ambroxol a bromhexin zvyšují tvorbu řidšího hlenu a sekreci surfaktantu; dornáza alfa štěpí DNA v hnisavém sputu u cystické fibrózy.

Antidotum

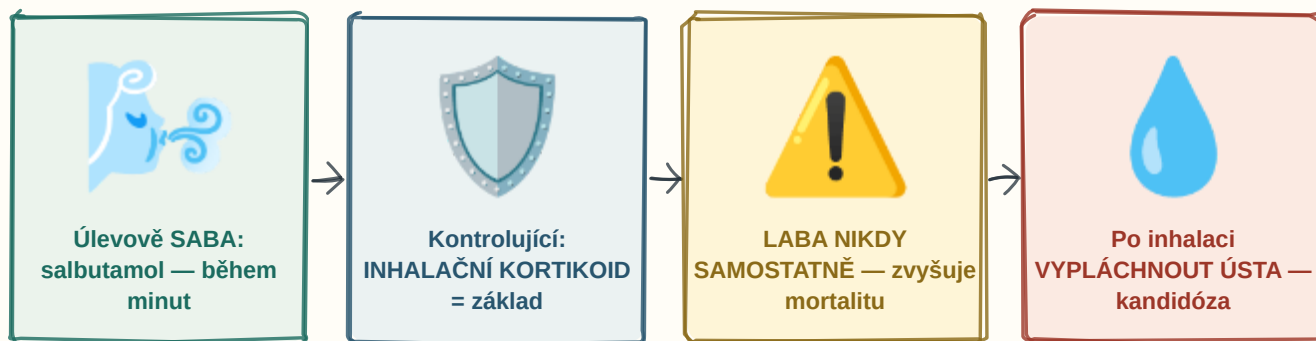
⚠️ N-acetylcystein doplňuje glutathion, a je proto antidotem otravy paracetamolem — to je jeho druhá, zcela odlišná indikace.

Expektorancia

Guaifenesin, sílice, břechťan zvyšují objem sekretu a usnadňují vykašlání; základem zůstává dostatečná hydratace.

⚠️ U dětí do dvou let se antitusika ani expektorancia zpravidla nepodávají — poměr rizika a prospěchu je nepříznivý.

Astma je CHRONICKÝ ZÁNĚT — proto je základem léčby INHALAČNÍ KORTIKOID, ne bronchodilatátor. Vysoká spotřeba SABA je známka, že léčba nefunguje.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Úleva

SABA (salbutamol, fenoterol) relaxují hladký sval bronchu během minut. Nežádoucí: tremor, tachykardie, hypokalemie. Vysoká spotřeba znamená špatně kontrolované astma.

Štít

Inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikason, beklometason) potlačují zánět a jsou základem léčby — bez nich astma nelze kontrolovat.

Zákaz

⚠ LABA (formoterol, salmeterol) se u astmatu nikdy nepodávají samostatně — monoterapie zvyšuje mortalitu. Dnešní standard je fixní kombinace inhalační kortikoid + formoterol, používaná i jako úlevová léčba.

Ústa

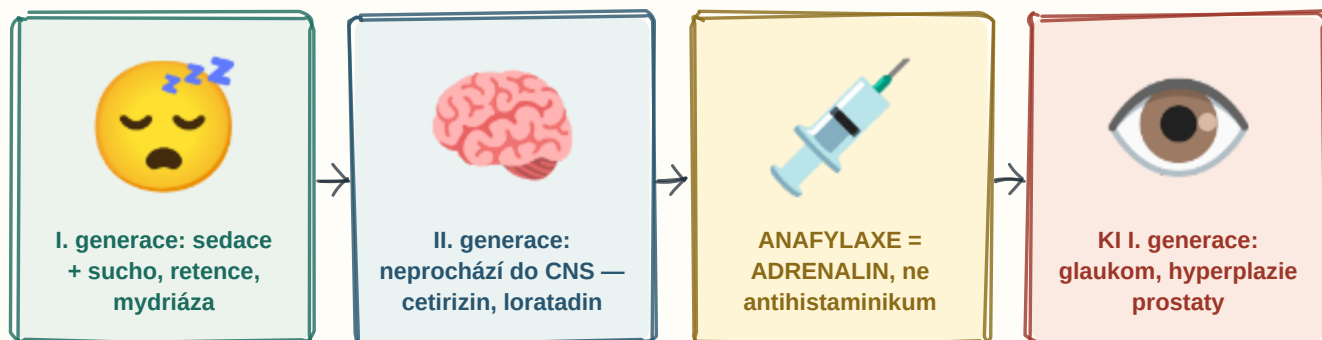
Lokální nežádoucí účinky inhalačního kortikoidu jsou orofaryngeální kandidóza a dysfonie — brání jim výplach úst po inhalaci a použití nástavce.

Další

LAMA (tiotropium), antileukotrieny (montelukast — ⚠ neuropsychické reakce), theofylin (úzké terapeutické okno), biologika (omalizumab anti-IgE, mepolizumab anti-IL-5) u těžkého astmatu.

⚠ ⚠ Neselektivní β -blokátory (i v očních kapkách — timolol) mohou u astmatika vyvolat těžký bronchospasmus.

I. generace PROCHÁZÍ do mozku → sedace a anticholinergní účinky. II. generace neprochází → nesesdaje. A na ANAFYLAXI nestačí ani jedna — tam patří adrenalin.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Spánek

I. generace (bisulepin, prometazin, difenhydramin, hydroxyzin) prochází hematoencefalickou bariérou — sedace (nesmí se řídit, nepít alkohol). Sedativní a antiemetický efekt se využívá cíleně u kinetózy, nočního svědění a v premedikaci.

Anticholinergně

Sucho v ústech, retence moči, rozmazané vidění, zácpa, u starších zmatenost. ⚠ Kontraindikací je glaukom s uzavřeným úhlem a hyperplazie prostaty.

Adrenalin

⚠ H1-antihistaminika tlumí svědění, kopřivku, rýmu a kýchání, ale na bronchokonstrikci u astmatu ani na anafylaxi nestačí — lékem první volby u anafylaxe je ADRENALIN i.m.

Druhá generace

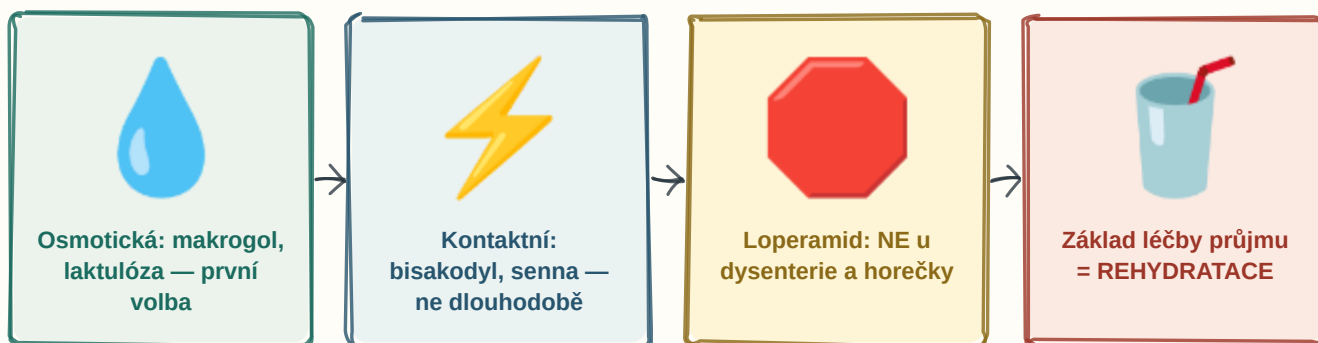
Cetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin, bilastin do CNS prakticky neprocházejí — nesesdávají a nemají anticholinergní účinky; jsou volbou pro denní léčbu. Starší preparáty skupiny (terfenadin, astemizol) byly staženy pro prodloužení QT.

H2

Famotidin a další H2-antihistaminika tlumí sekreci žaludeční kyseliny — jiná indikace, tatáž třída receptorů.

⚠ H1-antihistaminika jsou vlastně inverzní agonisté — netlumí jen navázaný histamin, ale i bazální aktivitu receptoru.

LOPERAMID se nesmí podat u DYSENTERIE a horečnatého průjmu — zadržel bys patogen ve střevě a hrozí toxické megakolon. A rehydratace je vždy důležitější než lék.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Osmotická

Makrogol (polyethylenglykol) váže vodu bez dráždění — dnes lék volby. LAKTULÓZA je nevstřebatelný disacharid, který střevní bakterie štěpí na kyseliny; táhne vodu a snižuje vstřebávání amoniaku — proto se používá u JATERNÍ ENCEFALOPATIE.

Kontaktní

Bisakodyl, senna a pikosíran dráždí myenterický plexus. ⚠️ Při chronickém zneužívání hrozí hypokalemie a atonie tračníku — nehodí se k trvalému užívání.

Loperamid

Agonista periferních μ -opioidních receptorů, zpomaluje peristaltiku, do CNS neproniká. ⚠️ Nesmí se podat u dysenterie (krvavý průjem) a horečnatého průjmu — riziko toxického megakolon.

Rehydratace

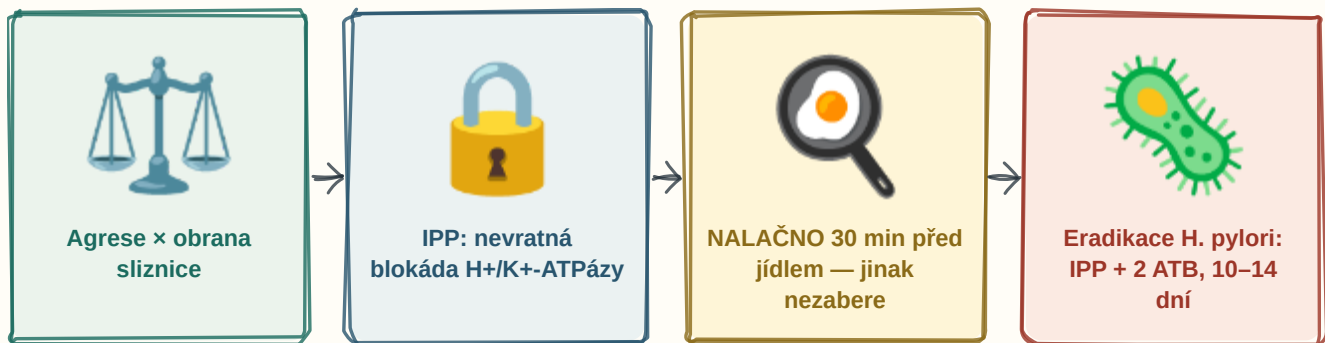
U průjmu je zásadní perorální rehydratační roztok, nikoli zástava peristaltiky. Dále adsorbencia (diosmektit, aktivní uhlí) a probiotika.

Ostatní laxativa

Objemová (psyllium — nutný dostatečný příjem tekutin), změkčující (dokusát), parafinový olej (⚠️ zhoršuje vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích), periferní antagonisté opioidů (methylnaltrexon, naloxegol) na zácpu při opioidech.

⚠️ ⚠️ Laxativa se nikdy nepodávají při podezření na střevní obstrukci nebo náhlou příhodu břišní. Základem léčby zácpy zůstává vláknina, tekutiny a pohyb.

Vřed = převaha AGRESE (kyselina, pepsin, H. pylori, NSA) nad OBRANOU (hlen, bikarbonáty, prostaglandiny). IPP se musí brát NALAČNO, 30 minut před jídlem.

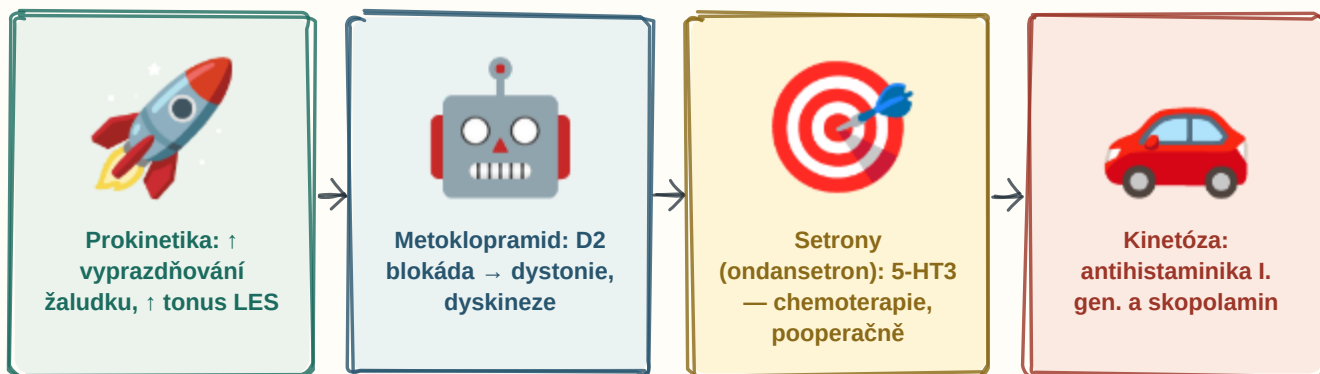


ROZKLÍČOVÁNÍ

Váhy	Léčba tlumí kyselinu, eradikuje bakterii a odstraní vyvolávající lék (NSA).
Zámek	Inhibitory protonové pumpy (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol) ireverzibilně blokují H ⁺ /K ⁺ -ATPázu parietální buňky — poslední společný krok sekrece, proto nejúčinnější.
Nalačno	Aktivují se jen na sekretující pumpě — podávají se 30 minut před jídlem. ⚠ Dlouhodobě: hypomagnezémie, deficit vitamínu B12, zvýšené riziko klostridiové kolitidy a zlomenin. Omeprazol inhibuje CYP2C19 a snižuje účinek KLOPIDOGRELU — volí se pantoprazol.
Eradikace	IPP + amoxicilin + klarithromycin (nebo metronidazol), běžně jako čtyřkombinace s bismutem, 10–14 dní.
Ostatní	H ₂ -antihistaminika (famotidin) tlumí sekreci slaběji — vhodná na noční příznaky. Antacida neutralizují rychle, ale krátce a ⚠ vážou jiná léčiva (podávat s odstupem). Protektiva: sukralfát tvoří film na spodině vředu; misoprostol (analog prostaglandinu) chrání před NSA, ale ⚠ je kontraindikován v graviditě.

⚠ Vřed po NSA může krváčet bez varovné bolesti — NSA totiž bolest tlumí. Proto se u rizikových pacientů podává IPP profylakticky.

METOKLOPRAMID prochází do CNS, a proto působí **EXTRAPYRAMIDOVÉ** potíže — akutní dystonii, po delším podávání tardivní dyskinezi. Odsud omezení dávky i délky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Prokinetika

Metoklopramid (antagonista D2), itoprid a domperidon (do CNS pronikají málo, ⚠ domperidon prodlužuje QT). Erythromycin působí přes motilinový receptor u gastroparézy.

Extrapyramidové projevy

⚠ Metoklopramid prochází do CNS — akutní dystonie (hodiny až dny, častěji u mladých), po dlouhém podávání tardivní dyskineze. Proto je omezena dávka i délka podávání a u parkinsonika se nepodává vůbec.

Setrony

Ondansetron blokuje 5-HT3 receptory v area postrema a ve střevě — základ léčby zvracení po cytostatikách a ozáření a po operaci. Nežádoucí: zácpa, bolest hlavy, ⚠ prodloužení QT.

Podle příčiny

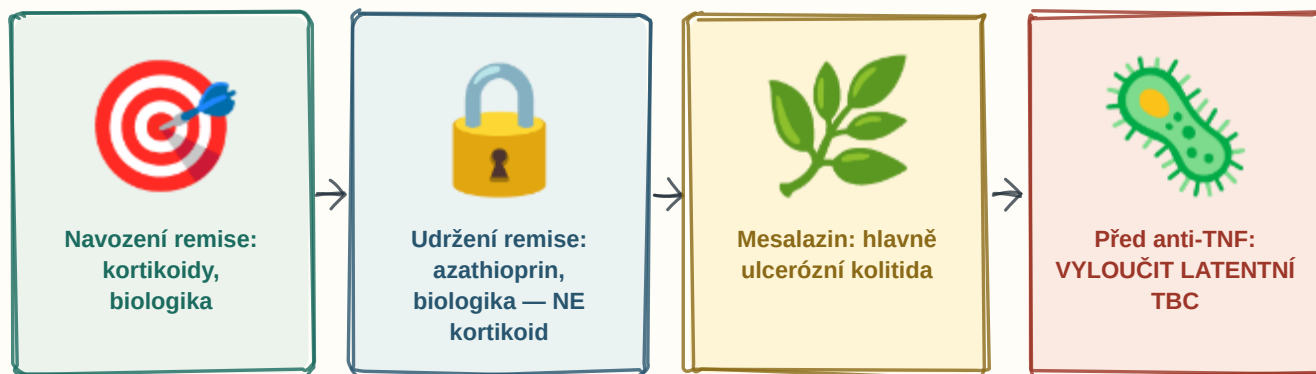
Antagonisté NK1 (aprepitant) proti pozdní fázi po chemoterapii · kortikosteroidy (dexametazon) v kombinaci · antihistaminika I. generace (prometazin) a anticholinergika (skopolamin) u kinetózy · neuroleptika (haloperidol, levomepromazin) v paliativní péči · kanabinoidy rezervně.

Emetika

⚠ Ipekakuanha a apomorfin se dnes při otravách prakticky nepoužívají — vyvolávat zvracení se nedoporučuje pro riziko aspirace; volí se aktivní uhlí.

⚠ Antiemetikum se volí podle mechanismu zvracení, ne podle jeho intenzity — proto ondansetron nefunguje na kinetózu a skopolamin nefunguje po chemoterapii.

Léčba má dvě fáze: **NAVODIT remisi (kortikoid) a UDRŽET ji (imunosupresivum)**. ⚠️ Kortikoid se k udržení remise **NIKDY** nepoužívá.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Navození

Kortikosteroidy (prednison; u ileocékální lokalizace BUDESONID s vysokým first-pass efektem, a tedy nižší systémovou toxicitou) rychle potlačí aktivitu a slouží jako „most“, než začnou působit ostatní léky.

Udržení

⚠️ Kortikoidy se k udržení remise nepoužívají pro nežádoucí účinky. Azathioprin a 6-merkaptopurin — ⚠️ před nasazením se vyšetřuje aktivita TPMT kvůli riziku myelosuprese; dále metotrexát.

Aminosalicyláty

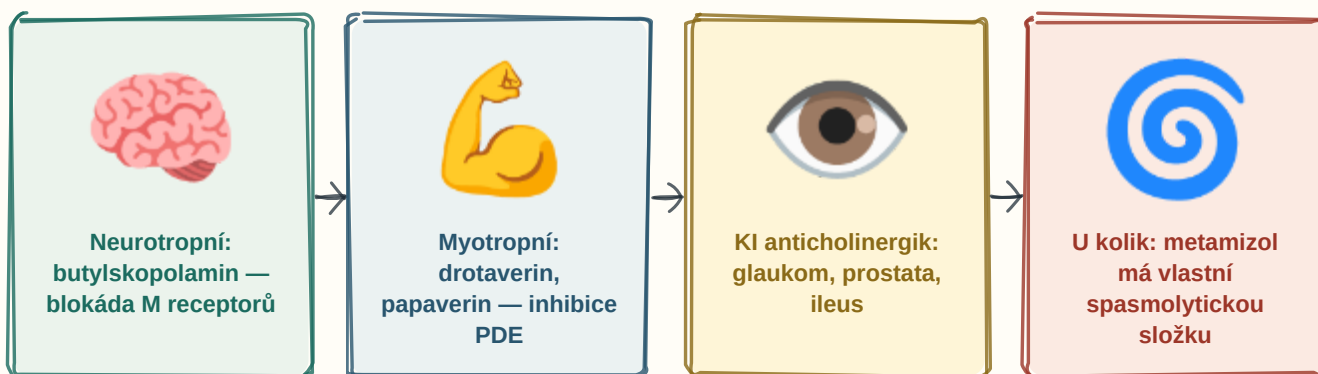
Mesalazin (5-ASA) se uvolňuje v tlustém střevě a působí lokálně protizánětlivě — základ u **ULCERÓZNÍ KOLITIDY**, u Crohnovy nemoci má malý účinek. Sulfasalazin způsobuje nauzeu, vyrážku a reverzibilní oligospermii.

Biologika

Anti-TNF- α (infliximab, adalimumab) u těžkých a fistulujících forem. ⚠️ Před nasazením je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace. Dále vedolizumab (anti-integrin, střevně selektivní), ustekinumab a inhibitory JAK.

⚠️ Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida se léčí odlišně: mesalazin je účinný hlavně u kolitidy, kdežto u Crohnovy nemoci se dříve sahá po imunosupresi a biologikách.

Dvě cesty ke stejnému cíli: **NEUROTROPNÍ** přeruší nervový povel (anticholinergně), **MYOTROPNÍ** působí přímo na sval — a nemá anticholinergní nežádoucí účinky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Neurotropní

Butylskopolamin je KVARTÉRNÍ amin — neprochází hematoencefalickou bariérou, a proto neseduje. Blokuje muskarinové receptory hladkého svalů.

Myotropní

Drotaverin a papaverin inhibují fosfodiesterázu, zvyšují cAMP a přímo relaxují sval — nemají anticholinergní nežádoucí účinky, a jsou proto vhodnější u pacienta s glaukomem nebo hyperplazií prostaty.

Kontraindikace

⚠ U anticholinergik: glaukom s uzavřeným úhlem, hyperplazie prostaty, tachyarytmie, paralytický ileus. Nežádoucí účinky: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, retence moči, zácpa.

Kolika

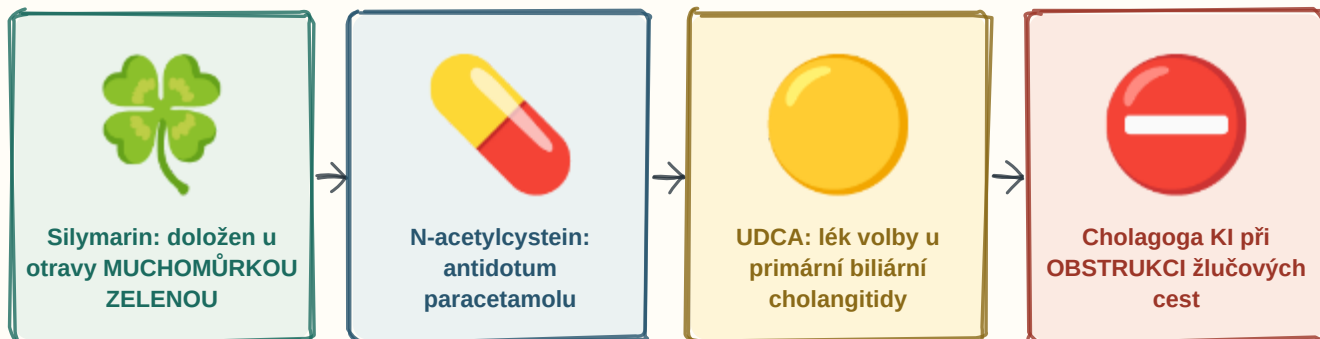
Metamizol má vlastní spasmolytickou složku, proto se hodí u ledvinné a žlučnickové koliky. ⚠ Riziko agranulocytózy a hypotenze při rychlém i.v. podání.

Dráždivý tračník

Mebeverin, pinaveriumbromid (blokátor kalciových kanálů střeva) a pepermintový olej (přes kalciové kanály).

⚠ Spasmolytikum tlumí viscerální bolest tím, že odstraní její příčinu — křeč. Proto u koliky často funguje lépe než čisté analgetikum.

U většiny hepatoprotektiv je důkaz účinnosti SLABÝ. Základem léčby jater zůstává odstranění příčiny — ne tableta.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Ostropestřec

Silymarin působí antioxidačně a stabilizuje membránu hepatocytu; jeho jedinou doloženou indikací je otrava muchomůrkou zelenou (*Amanita phalloides*), kde silibinin nitrožilně brání vstupu amanitinu do buňky.

Antidotum

N-acetylcystein doplňuje glutathion, na němž závisí zneškodnění toxického metabolitu NAPQI — antidotum otravy paracetamolem.

UDCA

Kyselina ursodeoxycholová je hydrofilní žlučová kyselina, která nahrazuje toxické žlučové kyseliny — lék volby u primární biliární cholangitidy; rozpouští i drobné cholesterolové konkrementy.

Zákaz

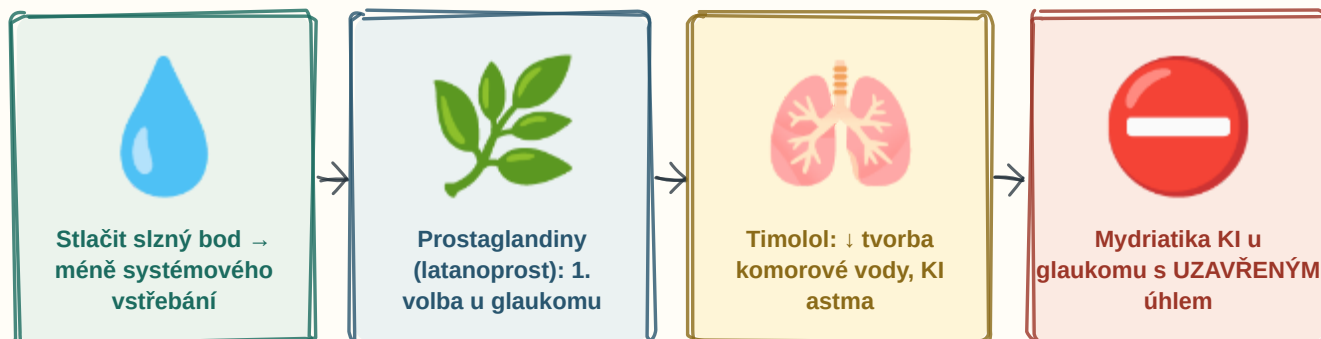
⚠ Cholagoga (choleretika zvyšují tvorbu žluči, cholekinetika vyprazdňování žlučníku) jsou kontraindikována při obstrukci žlučových cest.

Encefalopatie

Ornithin-aspartát a laktulóza snižují amoniak u jaterní encefalopatie; rifaximin snižuje jeho střevní produkci.

⚠ Nejúčinnějším „hepatoprotektivem“ je vysazení alkoholu a hepatotoxického léku, léčba viru a redukce hmotnosti u steatózy.

**Kapka do oka NENÍ jen místní léčba — část se vstřebá spojivkou a nosem.
Timolol z kapek umí vyvolat bradykardii i bronchospasmus.**



ROZKLÍČOVÁNÍ

Kapka

Část léčiva se vstřebá spojivkou a nosní sliznicí — proto i kapky mají systémové nežádoucí účinky. Vstřebávání sníží stlačení slzného bodu po nakapání.

Prostaglandiny

Latanoprost a bimatoprost zvyšují uveosklerální odtok komorové vody — první volba u glaukomu. Barví duhovku a prodlužují řasy.

β-blokátory

Timolol snižuje tvorbu komorové vody. ⚠ Kontraindikací je astma, CHOPN a bradykardie. Dále inhibitory karboanhydrázy (dorzolamid lokálně, acetazolamid celkově), α2-agonisté (brimonidin) a pilokarpin (parasymptomimetikum — mióza, otevře úhel; u akutního záchvatu).

Mydriatika

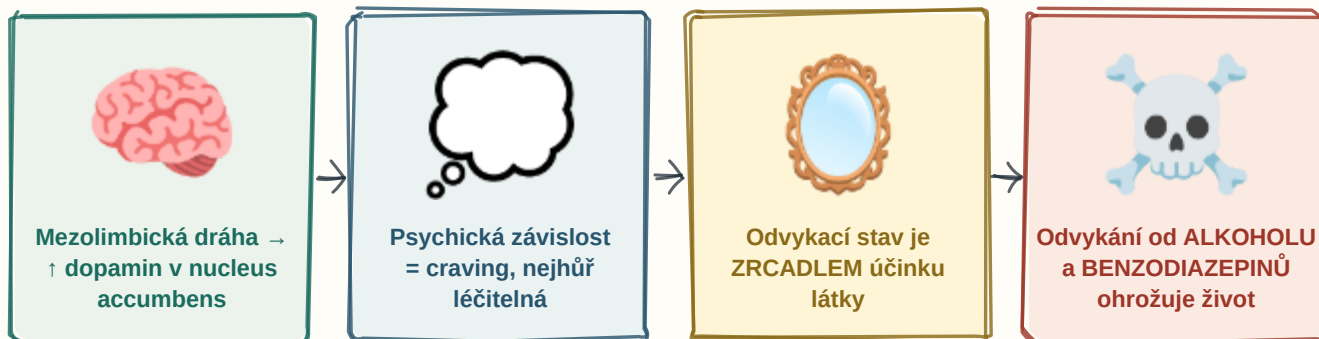
Tropikamid, atropin (anticholinergika) a fenylefrin k vyšetření očního pozadí. ⚠ Kontraindikované u glaukomu s uzavřeným úhlem — rozšířená duhovka uzavře komorový úhel.

Ostatní

Lokální anestetika (oxybuprokain). ⚠ Kortikosteroidy tlumí zánět, ale zvyšují nitrooční tlak, urychlují kataraktu a zhoršují herpetickou keratitidu. Anti-VEGF (ranibizumab, aflibercept) intravitreálně u vlhké makulární degenerace.

⚠ Glaukom s otevřeným a s uzavřeným úhlem mají odlišnou léčbu — pilokarpin je určen k otevření úhlu při akutním záchvatu, ne k dlouhodobé léčbě otevřeného glaukomu.

Všechny návykové látky mají jedno společné: ZVYŠUJÍ DOPAMIN v nucleus accumbens. Odvykací stav bývá ZRCADLEM účinku látky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Dopamin

Ventrální tegmentum → nucleus accumbens; všechny návykové látky přímo či nepřímo zvyšují dopamin, což upevňuje chování.

Craving

Psychická závislost (bažení, ztráta kontroly) je nejhůř léčitelná; fyzická závislost se projeví odvykacím stavem. Diagnostická kritéria: craving, ztráta kontroly, tolerance, odvykací stav, zanedbávání zájmů a pokračování přes následky.

Zrcadlo

Po opioidech (které dělají miózu, zácpu a útlum) přijde mydriáza, průjem, slzení a bolesti. Po alkoholu a benzodiazepinech (tlumivých) přijde třes, tachykardie a neklid.

Nebezpečí

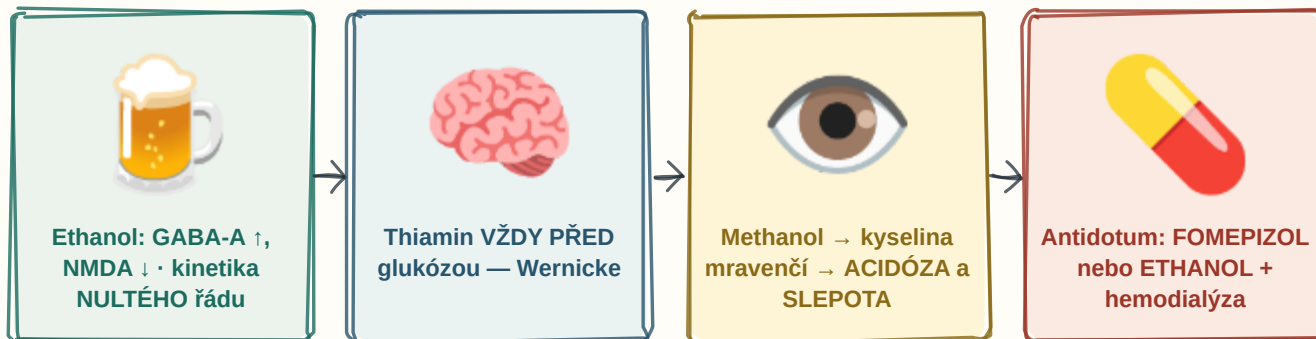
⚠ Odvykací stav po alkoholu a benzodiazepinech může vyústit v epileptické záchvaty a DELIRIUM TREMENS — je život ohrožující a léčí se benzodiazepiny. Odvykání od opioidů je nepříjemné, ale samo o sobě obvykle neohrožuje život.

Léčba

Substituce (metadon, buprenorfin, nikotinové náhrady) · averzivní (disulfiram) · snížení cravingu (naltrexon, akamprosát, vareniklin) · psychoterapie. Tolerance může být farmakodynamická i metabolická; zkřížená tolerance existuje mezi látkami stejného mechanismu.

⚠ Tolerance na různé účinky téže látky se vyvíjí různě rychle — u opioidů rychle na euforii a útlum dechu, ale téměř vůbec na zácpu a miózu.

METHANOL sám toxický není — zabíjejí jeho METABOLITY. Proto se léčí tak, že se enzymu podstrčí něco jiného: FOMEPIZOL nebo ETHANOL.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pivo

Ethanol potencuje GABA-A a inhibuje NMDA receptory. Odbourává se alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd a dále na acetylát; ⚠ kinetikou NULTÉHO ŘÁDU — konstantní množství za hodinu (0,1–0,15 ‰/h), rychlost nelze urychlit. Chronicky se uplatní CYP2E1 (indukce → tolerance).

Thiamin

⚠ U alkoholika se thiamin podává VŽDY PŘED glukózou — jinak se vyprovokuje Wernickeova encefalopatie (zmatenost, ataxie, oftalmoplegie). Dále hypoglykemie, steatóza → hepatitida → cirhóza, pankreatitida, kardiomyopatie, polyneuropatie, fetální alkoholový syndrom.

Slepotu

Methanol se alkoholdehydrogenázou mění na FORMALDEHYD a KYSELINU MRAVENČÍ — těžká metabolická acidóza a poškození očního nervu se slepotou. Latence bývá několik hodin.

Antidotum

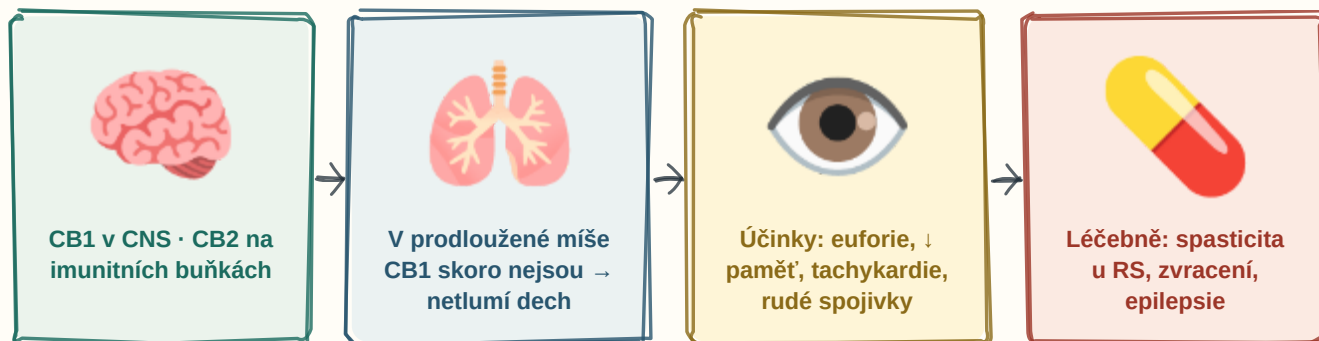
Kompetiční blokáda tvorby metabolitů: FOMEPIZOL (inhibitor alkoholdehydrogenázy) nebo ETHANOL, dále hemodialýza, korekce acidózy bikarbonátem a kyselina listová. ⚠ Stejný princip platí u ethylenglykolu (oxalátové krystaly, selhání ledvin).

Odvykací stav

Může vyústit v delirium tremens — léčí se benzodiazepiny.

⚠ Léčit methanolovou otravu ethanolem není paradox: obě látky soupeří o týž enzym, a dokud ho ethanol obsazuje, methanol se na toxické metabolity nepřemění.

CB1 receptorů je v prodloužené míše minimum — proto konopí NETLUMÍ DECH, na rozdíl od opioidů. To je klíčový rozdíl obou skupin.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Receptory

CB1 je hojný v bazálních gangliích, hipokampu, mozečku a kůře — odtud psychotropní účinky; CB2 je na buňkách imunitního systému. THC je parciální agonista CB1, kanabidiol (CBD) psychoaktivní není.

Dech

⚠ V prodloužené míše se CB1 prakticky nevyskytuje — proto konopí netlumí dechové centrum, na rozdíl od opioidů. Předávkování konopím samo o sobě nebývá smrtelné.

Účinky

Euforie, změněné vnímání času, poruchy krátkodobé paměti a pozornosti, zhoršená koordinace (⚠ riziko při řízení), tachykardie, překrvení spojivek, sucho v ústech, zvýšená chuť k jídlu. Ve vyšších dávkách úzkost, panika, u disponovaných psychotická ataka.

Rizika

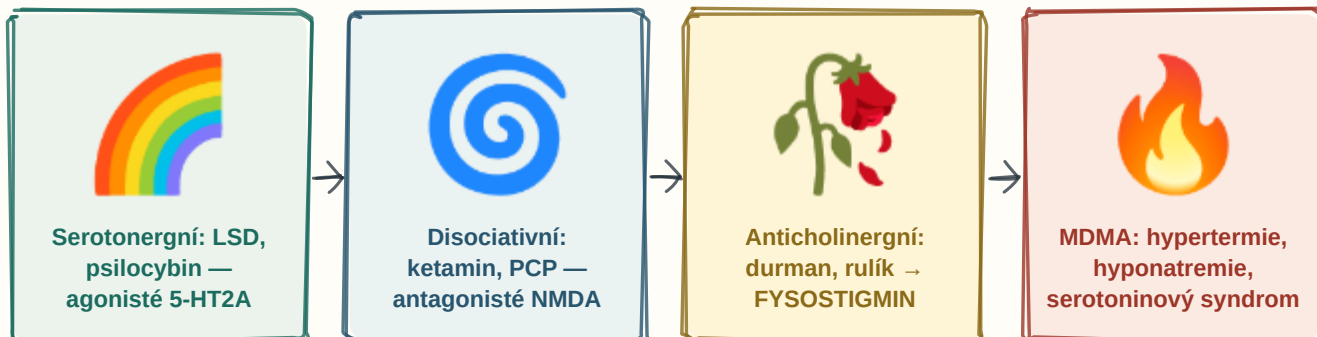
Užívání v dospívání zvyšuje riziko schizofrenie; vzniká psychická závislost a amotivační syndrom; při chronickém užívání kanabinoidní hyperemetický syndrom.

Terapeuticky

Nabiximols (THC/CBD) u spasticity u roztroušené sklerózy · dronabinol a nabilon proti zvracení po chemoterapii a při kachexii · kanabidiol u farmakorezistentní epilepsie (Dravetové a Lennoxův–Gastautův syndrom).

⚠ Kanabidiol není jen „slabší THC“ — nemá psychotropní účinek a má vlastní antikonvulzivní a anxiolytické působení, proto má i vlastní indikace.

Tři skupiny podle mechanismu: SEROTONERNÍ (5-HT_{2A}), DISOCIATIVNÍ (blokáda NMDA) a ANTICHOLINERNÍ (delirium). Každá se léčí jinak.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Serotonergní

LSD, psilocybin, meskalin a DMT jsou agonisté 5-HT_{2A} receptorů v kůře. Mydriáza, tachykardie, hypertenze, hypertermie. Vzniká rychlá tolerance, ale ⚠ nevyvolávají fyzickou závislost. Rizikem je „bad trip“ (zvládá se klidným prostředím a benzodiazepiny) a flashbacky (HPPD).

Disociativní

Ketamin, fencyklidin (PCP) a dextromethorfan ve vysokých dávkách jsou antagonisté NMDA receptoru — pocit odloučení od těla, analgezie, amnézie. PCP navíc agresivita, hypertenze a nystagmus. ⚠ Ketamin se používá terapeuticky jako anestetikum a (esketamin) u farmakorezistentní deprese.

Anticholinergní

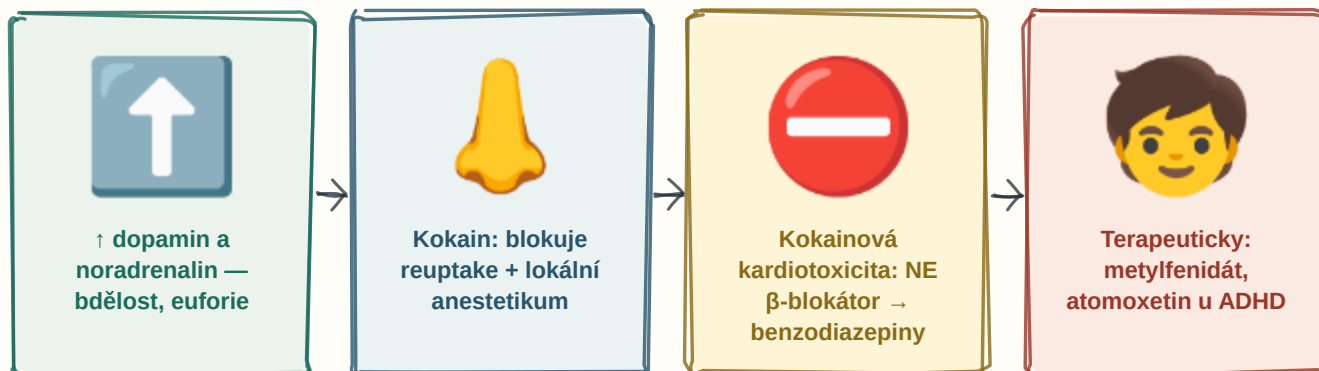
Atropin, skopolamin a rostliny rulík zlomocný, durman a blín vyvolávají DELIRIUM: mydriázu, suchou horkou červenou kůži, tachykardii a retenci moči. ⚠ Antidotem je FYSOSTIGMIN.

MDMA

Masivně uvolňuje serotonin — ⚠ hrozí hypertermie, hyponatremie (z nadměrného pití vody) a serotoninový syndrom.

⚠ Rozlišení skupin má praktický dopad: anticholinergní delirium má antidotum (fysostigmin), serotonergní „bad trip“ se tlumí benzodiazepinem a antidotum nemá.

Stimulancia zesilují DOPAMIN a NORADRENALIN. U kokainové kardiotoxicity se ⚠️ β -BLOKÁTORY NEPODÁVAJÍ — nebrzděná α -stimulace by zhoršila spasmus.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Mechanismus

Amfetamin a metamfetamin (pervitin) obracejí chod transportérů a vyplavují katecholaminy; kokain blokuje jejich zpětné vychytávání.

Kokain

Je zároveň lokálním anestetikem (blokádá sodíkových kanálů) — proto působí vazokonstrikci s nekrózou nosní přepážky a rizikem infarktu při koronárním spasmu.

Zákaz

⚠️ U kokainové kardiotoxicity se β -blokátory nepodávají — zablokováním β zůstane α -stimulace bez protiváhy a spasmus se prohloubí. Volí se benzodiazepiny, nitráty a blokátory kalciových kanálů.

ADHD

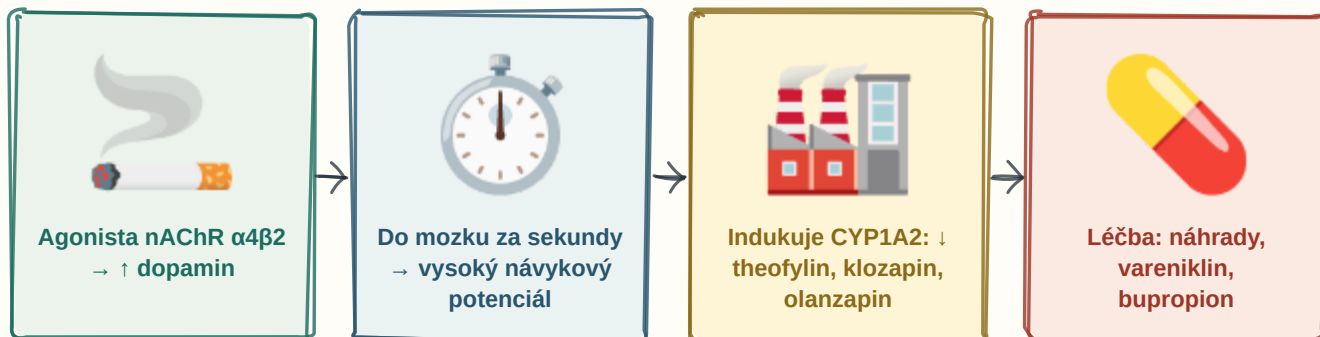
Metylfenidát, lisdexamfetamin a atomoxetin (inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu, nenávykový); modafinil u narkolepsie. Do skupiny patří i kofein a efedrin.

Toxicita

Euforie, nespavost, nechutenství, mydriáza, tachykardie a hypertenze; při předávkování hypertermie, arytmie, infarkt, cévní mozková příhoda a křeče. Chronicky toxická psychóza s paranoiou (léčí se antipsychotiky), kachexie, poškození chrupu a silná psychická závislost s těžkým „dojezdem“.

⚠️ Metylfenidát u ADHD nepůsobí paradoxně — zvýšení dopaminu a noradrenalinu v prefrontální kůře zlepší schopnost útlumu a soustředění.

Nikotin je agonista nAChR $\alpha\beta 2$ → dopamin v nucleus accumbens. ⚠ Za většinu škod kouření ale odpovídá DEHET a OXID UHELNATÝ, ne nikotin sám.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Receptor

Nikotin je alkaloid tabáku a agonista nikotinových acetylcholinových receptorů, v CNS zejména $\alpha\beta 2$; jejich aktivace vede k výlevu dopaminu v nucleus accumbens.

Rychlost

Vstřebává se plicemi a mozku dosáhne během sekund — to posiluje návyk; návykový potenciál je srovnatelný s heroinem.

Indukce

⚠ Nikotin indukuje CYP1A2 — kouření snižuje hladiny theofylinu, klozapinu a olanzapinu; po zanechání kouření je nutné dávky upravit.

Léčba

Nikotinová substituce (náplasti, žvýkačky, pastilky) · vareniklin (parciální agonista $\alpha\beta 2$ — tlumí craving a zároveň blokuje odměnu z cigarety) · bupropion (inhibitor zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu, ⚠ snižuje práh křečí).

Účinky a otrava

V nízkých dávkách tachykardie, hypertenze, vazokonstrikce, snížená chuť k jídlu, zvýšená bdělost. Ve vysokých dávkách depolarizační blokáda ganglií s křečemi, zvracením a zástavou dechu — ⚠ akutní otrava u dětí po požití cigaret nebo náplně e-cigarety.

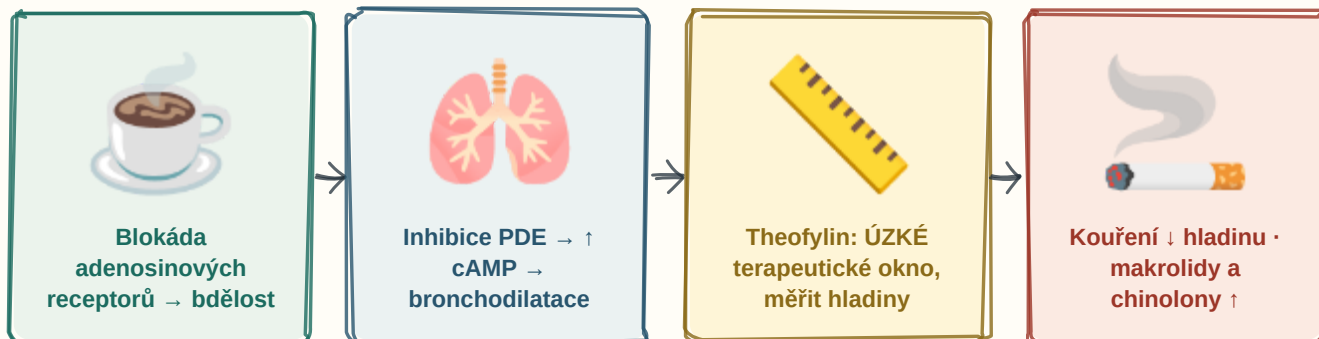
Odvykací stav

Neodolatelná touha kouřit, podrážděnost, úzkost, nesoustředěnost, zvýšená chuť k jídlu a přírůstek hmotnosti.

⚠ Nikotinová substituce je bezpečnější než kouření právě proto, že dodá nikotin bez dehtu a oxidu uhelnatého — tedy bez látek působících nádory a aterosklerózu.

111 Metylxantiny a jejich deriváty

Dva mechanismy: blokáda ADENOSINOVÝCH receptorů (proto bdělost — adenosin je látka útlumu) a inhibice FOSFODIESTERÁZY (proto bronchodilatace).



ROZKLÍČOVÁNÍ

Káva

Kofein, theofylin a theobromin jsou purinové alkaloidy kávy, čaje a kakaa. Antagonismus adenosinových receptorů vysvětluje bdělost — adenosin je látka útlumu a spánku.

Plíce

Ve vyšších koncentracích inhibují fosfodiesterázu, roste cAMP — odtud bronchodilatace a stimulace srdce. Dále mírná diuréza, zvýšení sekrece žaludeční kyseliny a stimulace dechového centra.

Pravítko

⚠ Theofylin (a aminofylin) je antiastmatikum druhé volby s úzkým terapeutickým oknem — nutná monitorace hladin; projevem předávkování jsou arytmie a křeče.

Interakce

Metabolizuje se CYP1A2: ⚠ kouření hladinu SNIŽUJE (indukce), zatímco erythromycin, klarithromycin, ciprofloxacin, fluvoxamin a srdeční selhání ji ZVYŠUJÍ.

Kofein a pentoxifylin

Kofein se terapeuticky používá u apnoe nedonošených, v kombinaci s analgetiky zesiluje jejich účinek a u postpunkční bolesti hlavy. Pentoxifylin zlepšuje deformabilitu erytrocytů u ischemické choroby dolních končetin. Vysoké dávky metyloxantinů: nespavost, třes, úzkost, tachyarytmie, křeče.

⚠ Adenosin se naopak používá jako antiarytmikum — a u pacienta po kávě může být méně účinný, protože kofein jeho receptory blokuje.

NSA a kortikoid uleví, ale nemoc NEZASTAVÍ. Průběh mění jen DMARDs — a proto se nasazují co nejdřív. METOTREXÁT se podává JEDNOU TÝDNĚ.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Symptomatická léčba

NSA tlumí bolest, otok a ranní ztuhlost, ale nemají vliv na průběh. Kortikosteroidy rychle potlačí aktivitu a slouží jako „most“, než začnou působit DMARDs; k dlouhodobému podávání se nehodí.

DMARDs

Chorobu modifikující léčiva zpomalují destrukci kloubu — proto se nasazují co nejdříve po stanovení diagnózy.

Metotrexát

⚠ Lék první volby u revmatoidní artritidy; podává se JEDNOU TÝDNĚ (denní podání je závažná chyba s rizikem úmrtí) a doplňuje se kyselinou listovou. Je hepatotoxický, myelotoxický a kontraindikovaný v graviditě. Dále leflunomid, sulfasalazin, hydroxychlorochin (⚠ retinopatie — oční kontroly).

Biologika

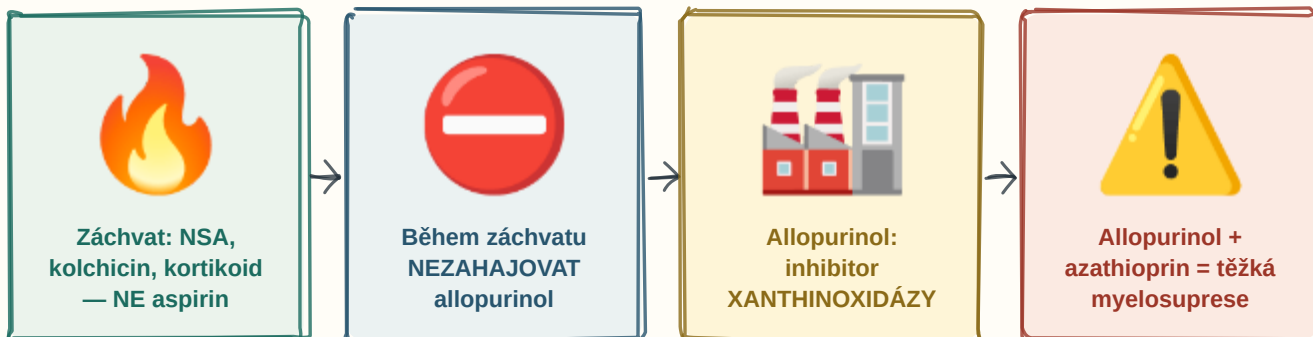
Anti-TNF- α (infliximab, adalimumab, etanercept), rituximab (anti-CD20), tocilizumab (anti-IL-6), abatacept. ⚠ Před nasazením je nutné vyloučit latentní tuberkulózu a hepatitidu B — hrozí reaktivace; obecně zvyšují riziko infekcí.

Cílené syntetické

Inhibitory JAK (tofacitinib, baricitinib) — ⚠ pozor na trombembolie a kardiovaskulární riziko.

⚠ Bolest u revmatoidní artritidy může být pod kontrolou i při pokračující destrukci kloubu — proto se úspěch léčby neposuzuje jen podle úlevy, ale podle aktivity nemoci.

Dva režimy, které se NESMÍ zaměnit: AKUTNÍ ZÁCHVAT se tlumí protizánětlivě, HYPOURIKEMICKÁ léčba se během záchvatu NEZAHAJUJE.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Záchvat

NSA (indometacin, naproxen — ⚠ nikoli kyselina acetylsalicylová, která v nízké dávce retenci urátů zhoršuje), kolchicin (blokuje polymeraci mikrotubulů, a tím migraci neutrofilů; limitující je dávkově závislý průjem) a kortikosteroidy systémově nebo do kloubu.

Zákaz

⚠ Během akutního záchvatu se hypourikemická léčba NEZAHAJUJE — každá změna urikemie záchvat prodlužuje. Pokud ji pacient už užívá, nevysazuje se.

Allopurinol

Inhibuje xanthinoxidázu, a snižuje tak tvorbu kyseliny močové; je lékem volby. Zahajuje se nízkou dávkou pod clonou kolchicinu nebo NSA, protože jinak vyprovokuje záchvat. Nežádoucí: vyrážka až závažný hypersenzitivní syndrom (riziko u HLA-B*5801). Febuxostat je alternativou.

Interakce

⚠ Allopurinol blokuje odbourávání azathioprinu a 6-merkaptopurinu — hrozí těžká myelosuprese; dávku je nutné výrazně snížit nebo kombinaci nepoužít.

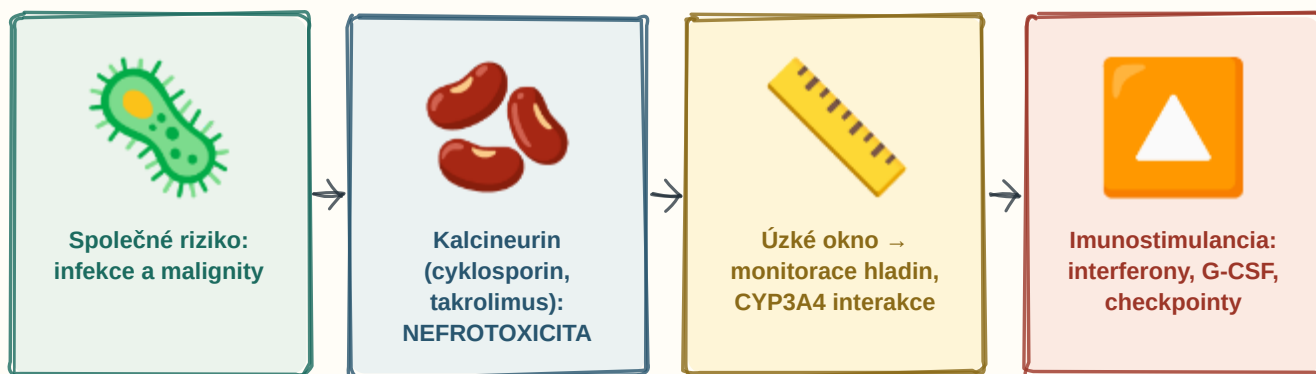
Urikosurika

Probenecid zvyšuje vylučování urátů ledvinami; ⚠ nesmí se podat při urátové nefrolitiáze a vyžaduje dostatečný příjem tekutin. Rasburikáza (urikáza) u syndromu nádorového rozpadu.

⚠ Bezpříznaková hyperurikemie se sama o sobě neléčí — indikací k hypourikemické léčbě jsou opakované záchvaty, tofy, urátová nefropatie nebo litiáza.

114 Imunosupresiva, imunostimulancia

Společné riziko VŠECH imunosupresiv je INFEKCE a NÁDOR. Proto se kombinují v nižších dávkách — víc mechanismů, méně toxicity každého z nich.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Infekce

Všechna imunosupresiva zvyšují riziko infekcí a nádorů — proto se kombinují v nižších dávkách.

Kalcineurin

Cyklosporin A a takrolimus blokují přenos signálu v T-lymfocyty, a tím tvorbu interleukinu-2; jsou základem transplantační imunosuprese. ⚠ Zásadní je NEFROTOXICITA a úzké terapeutické okno; metabolizují se CYP3A4 (interakce s azoly, makrolidy, grapefruitem). Cyklosporin navíc působí hypertenzi, hirsutismus a GINGIVÁLNÍ HYPERPLAZII; takrolimus je neurotoxický a diabetogenní.

Antiproliferativní

Azathioprin (⚠ před nasazením vyšetřit TPMT), mykofenolát mofetil (blokuje syntézu purinů v lymfocytech, ⚠ teratogenní), metotrexát. Inhibitory mTOR (sirolimus, everolimus) nefrotoxicke nejsou, ale zhoršují hojení a působí dyslipidemií.

Biologika

Anti-TNF- α , rituximab, basiliximab, antithymocytární globulin; kortikosteroidy jako univerzální základ.

Imunostimulancia

Interferony (α u hepatitid, β u roztroušené sklerózy), filgrastim (G-CSF), interleukin-2, bakteriální lyzáty a ⚠ inhibitory kontrolních bodů (nivolumab, pembrolizumab), jejichž typickým nežádoucím účinkem jsou autoimunitní reakce.

⚠ Inhibitory kontrolních bodů jsou opakem imunosuprese — uvolňují brzdu imunity, a proto jejich nežádoucí účinky vypadají jako autoimunitní onemocnění (kolitida, tyreoiditida, hepatitida).

115 Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

Klíč k celé otázce: PULZNÍ podání GnRH stimuluje, TRVALÉ podání receptory desenzitizuje a vede k ÚTLUMU. Jedna látka, dva opačné výsledky.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Pulzně	Pulzní podání GnRH napodobuje fyziologii a stimuluje osu — používá se v léčbě neplodnosti.
Trvale	Depotní analoga GnRH (goserelin, leuprorelin, triptorelin) receptory desenzitizují a navodí chemickou kastraci — karcinom prostaty a prsu, endometrióza, myomy, předčasná puberta.
Flare-up	⚠ Na začátku dojde k přechodnému vzplanutí sekrece — u karcinomu prostaty se kryje antiandrogenem. Antagonisté GnRH (degarelix, cetorelix) tlumí ihned, bez vzplanutí.
Prolaktin	Tlumí se AGONISTY DOPAMINU (kabergolin, bromokriptin) — protože dopamin je fyziologickým inhibitorem prolaktinu. Indikace: prolaktinom, potlačení laktace.
Ostatní	Somatostatinová analoga (oktreotid, lanreotid) tlumí růstový hormon — akromegalie, neuroendokrinní nádory, krvácení z varixů; pegvisomant je antagonist receptoru pro GH; somatropin při nedostatku GH u dětí. Neurohypofýza: oxytocin (děložní kontrakce), vasopresin a desmopresin (diabetes insipidus, noční pomočování, hemofilie A a von Willebrandova choroba), terlipresin (krvácení z varixů), tolvaptan (hyponatremie).

⚠ Metoklopramid a antipsychotika blokují D2 receptory — a tím zvyšují prolaktin. Odtud galaktorea, amenorea a gynekomastie při jejich užívání.

LEVOTYROXIN se bere NALAČNO, 30–60 minut před snídaní — železo, vápník, antacida a IPP jeho vstřebání zhoršují. A tyreostatika působí AŽ ZA TÝDNY.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Nalačno

Levotyroxin se podává jednou denně nalačno; ⚠️ potrava, železo, vápník, antacida a inhibitory protonové pumpy zhoršují jeho vstřebávání. T4 je proléčivo, které se v tkáních deioduje na účinnější T3, což zajišťuje stabilní hladinu. TSH je hlavním ukazatelem úspěšnosti léčby.

Opatrně

⚠️ U starších a u ischemické choroby srdeční se začíná nízkou dávkou — jinak hrozí vyprovokování anginy nebo arytmie. Předávkování se projeví jako tyreotoxikóza (tachykardie, hubnutí, osteoporóza, fibrilace síní). V graviditě potřeba levotyroxinu stoupá.

Tyreostatika

Thiamazol (metimazol) a propylthiouracil inhibují tyreoidální peroxidázu, tedy jodaci tyrosinu. ⚠️ Účinek nastupuje se zpožděním týdnů, protože se musí vyčerpat zásoba hormonu ve žláze.

Agranulocytóza

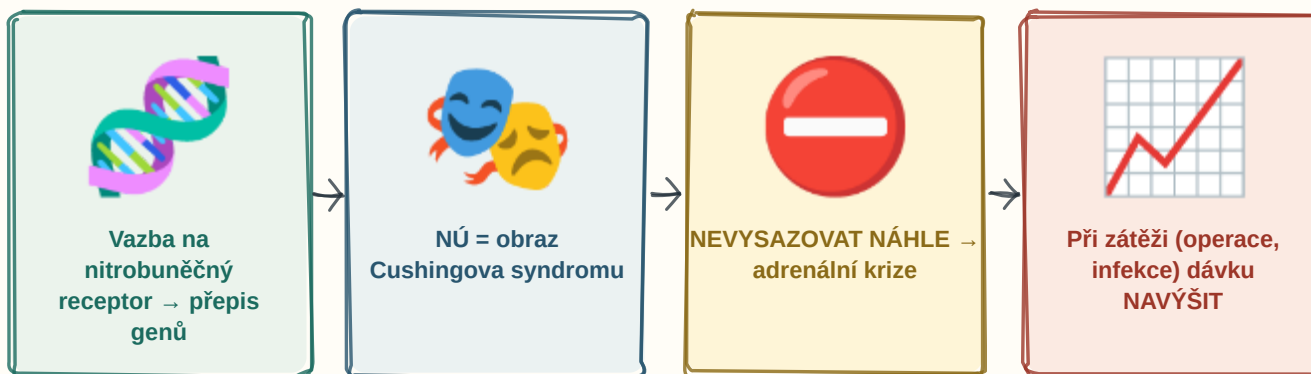
⚠️ Nejzávažnější nežádoucí účinek tyreostatik — při horečce a angíně je nutné okamžitě vyšetřit krevní obraz. Dále hepatotoxicita.

Zvláštnosti

Propylthiouracil navíc blokuje periferní konverzi T4 na T3 a je volbou v prvním trimestru gravidity a u tyreotoxické krize. β-blokátory (propranolol) rychle tlumí příznaky. Radiojod (¹³¹I) ničí tkáň žlázy a ⚠️ je kontraindikován v graviditě.

⚠️ Amiodaron obsahuje jod a může vyvolat hypotyreózu i hypertyreózu — proto se u pacientů na amiodaronu funkce štítné žlázy pravidelně kontroluje.

Kortikoidy mění PŘEPIS GENŮ — odtud pomalý nástup. A po podávání delším než dva týdny se ⚠ NIKDY nevysazují náhle: osa je utlumená.



ROZKLÍČOVÁNÍ

Geny

Kortikosteroidy se vážou na nitrobuňčový receptor a mění přepis genů — odtud pomalý nástup a široké působení. Tlumí zánět a imunitu: potlačují fosfolipázu A2, tvorbu cytokinů a migraci leukocytů.

Cushing

Hyperglykemie až steroidní diabetes, centrální obezita s měsíčkovitým obličejem, osteoporóza (prevence vápníkem a vitamínem D), svalová atrofie, ztenčení kůže a špatné hojení, žaludeční vřed zvláště s NSA, hypertenze, katarakta a glaukom, psychické změny, zvýšená náchylnost k infekcím a potlačení růstu u dětí.

Vysazování

⚠ Při podávání delším než dva týdny dojde k útlumu osy hypothalamus–hypofýza–nadledviny — náhlé vysazení vede k akutní adrenální insuficienci. Vysazuje se postupně.

Zátěž

Ze stejného důvodu se při operaci, infekci nebo úrazu dávka NAVYŠUJE — utlumená nadledvina nedokáže odpovědět sama.

Zástupci a mineralokortikoidy

Hydrokortison, prednison, metylprednisolon, dexametazon (vzestupně podle síly a délky účinku, sestupně podle mineralokortikoidní složky). Mineralokortikoidy (aldosteron, léčebně fludrokortison) zvyšují zpětné vstřebávání sodíku a vylučování draslíku — u Addisonovy nemoci; nadbytek působí hypertenzi, hypokalemii a metabolickou alkalózu.

⚠ Inhalační a lokální formy mají nižší systémové riziko, ale ve vysokých dávkách osu utlumí také — proto se i u nich hlídá kumulativní dávka.